T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ÇOCUK PALYATİF BAKIM
KLİNİK REHBERİ

2026

Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

ÇOCUK PALYATİF BAKIM KLİNİK REHBERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası	1409
ISBN	978-625-8644-12-8
Yayım Tarihi	Temmuz - 2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa Sayısı	107

Atıf için: T.C. Sağlık Bakanlığı (2026), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı, Çocuk Palyatif Bakım Klinik Rehberi, Ankara, ss. 107

Telif Hakkı Sahibi: © Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026

Bu rehberin yayın hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. İzin alınmaksızın çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Ücretsizdir, para ile satılamaz.

Tıbbi bilgiler sürekli değişime uğrayarak yenilenmektedir; o nedenle bu rehberdeki bilgiler literatür bilgisi ile güncellenmelidir. Herhangi bir yanlış uygulamadan kaçınabilmek amacı ile standart güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır. Her hasta için en iyi uygulamayı yapmak sorumlu hekimin görevidir.

İLETİŞİM

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

Adres: Üniversiteler Mahallesi, Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi, No: 3 Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 471 15 37

Web: shgm.saglik.gov.tr, https://shgmargestddb.saglik.gov.tr, hta.gov.tr

ÖNSÖZ

Sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunumunu sağlamak Sağlık Bakanlığı'nın en temel hedefleri arasındadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan klinik rehber ve protokoller, sağlık olgularının yönetiminde kanıta dayalı iyi klinik uygulamaları tanımlamayı, hasta bakım ve güvenlik standartlarını belirlemeyi, etkili ve sürdürülebilir stratejilerin seçiminde tüm sağlık profesyonellerine rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, sağlık olgularının tanı, tedavi, rehabilitasyon ve izlem süreçleri ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin yönetimine ilişkin uluslararası kanıtların yerel yapılara uyumu göz önünde bulundurularak hazırlanan rehber ve protokoller ile müdahale ve bakım süreçlerinin standart hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Palyatif bakım, hastanın bütüncül bakımı ile birlikte ailenin de desteklendiği bir bakım yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda hastalara son dönemlerinde sağlanan fiziksel, ruhsal, sosyal, manevi bakım ve destek ile yaşam kalitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Palyatif bakımda hastalığın neden olduğu semptomların önlenmesine yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler kullanılarak hastaya son döneme kadar rahat ve konforlu bir yaşam sunulmaya çalışılmaktadır.

Erken ve etkin palyatif bakım uygulamaları, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırarak hastalığın seyrini ve prognozunu olumlu yönde etkilemektedir. Böylelikle gereksiz hastane kabullerini ve sağlık hizmetlerinin israfını da önleyerek maliyetleri azaltmaktadır. Bunun yanı sıra çocuklar için sağlanan palyatif bakım, aile bütünlüğünü korumakta ve diğer sağlıklı çocukların ihmal ve istismarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu Klinik Rehber, çocuk palyatif bakım konusunda kabul, sevk ve taburculuk kriterlerinin netleştirilmesini ve çocuk palyatif bakım alanında çalışan sağlık profesyonellerine güncel literatüre dayalı, sürecin yönetilmesine ışık tutacak uygulanabilir bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Rehberin çocuk palyatif bakım konusunda ulusal düzeyde standart bir yaklaşım uygulanmasına katkı sağlamasını ve faydalı olmasını diler, emeği geçen tüm çalışma grubu üyelerine teşekkür ederim.

Uzm. Dr. Hasan Basri VELİOĞLU
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

ÇALIŞMA EKİBİ

Çalışmanın Adı

Çocuk Palyatif Bakım Klinik Rehberi, 2026

Çalışma Sahibi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Yöneticileri

Adı, Soyadı	Ünvanı	Kurumu/Görevi
Hasan Basri VELİOĞLU	Uzm. Dr.	Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Sacit TÜRÜDÜ	Uzm. Dr.	Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Sultan OĞRAŞ	Daire Başkanı	Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanı

Çalışma Koordinatörü

Nursel GÜNAY	Diyetisyen	Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

Editör

Ganime AYAR	Doç. Dr.	Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Yazarlar*

Şanlıay ŞAHİN	Prof. Dr.	Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Fatma Zehra ÖZTEK ÇELEBİ	Doç. Dr.	Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Ganime AYAR	Doç. Dr.	Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Nihal DURMAZ	Doç. Dr.	Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Nilgün HARPUTLUOĞLU	Doç. Dr.	Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Serap ULUSOY	Doç. Dr.	Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Gökçen İLÇİOĞLU EKİCİ	Dr. Öğretim Üyesi	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Zeynep YURDAKUL	Dr. Hemşire	Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Eğitim Birimi

Katkı Verenler

Türk Pediatri Kurumu

Grafik Tasarım/Mizanpaj

Selda CAN	Grafiker	Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı

**Yazar isimleri; akademik unvan hiyerarşisine göre; her unvan grubu içinde ise alfabetik olarak sıralanmıştır.*

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KOMİSYONU	
Ad Soyad	**Görev**
Doç. Dr. Naim ATA	Komisyon Başkanı
Uzm. Dr. Yusuf AKDOĞAN	Üye
Doç. Dr. Murat GÜLŞEN	Üye
Uzm. Dr. Erkan SANMAK	Üye
Uzm. Dr. Dilek TARHAN	Üye
Olgun ŞENER	Üye

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..... *iii*
ÇALIŞMA EKİBİ ..... *iv*
YAYIN KOMİSYONU ..... *v*
TABLOLAR ..... *viii*
ŞEKİLLER ..... *viii*
ALGORİTMALAR ..... *viii*
KISALTMALAR ..... *ix*

1. ÇOCUK PALYATİF BAKIM 1
1.1. Tanımı 1
1.2. Amacı 1
1.3. Kapsamı 3

2. ÇOCUK PALYATİF BAKIMIN TEMEL İLKELERİ 6
2.1. Çocuk Palyatif Bakımın İlkeleri 6

3. MULTİDİSİPLİNER EKİBİN BİLEŞENLERİ 10
3.1. Ekip Kavramı 10
3.2. Ekibin Bileşenleri ve Görevleri 11

4. ÇOCUK PALYATİF BAKIM DESTEĞİ NERELERDE YAPILIR? 14
4.1. Hastane Tabanlı Palyatif Bakım 14
4.2. Ev Tabanlı Palyatif Bakım 14

5. ÇOCUK PALYATİF BAKIMA KABUL,TABURCULUK VE SEVK KRİTERLERİ 16
5.1. Çocuk Palyatif Bakıma Kabul Kriterleri 16
5.2. Çocuk Palyatif Bakımdan Taburculuk Kriterleri 17
5.3. Palyatif Bakım Servislerine Sevk Kriterleri 19

6. AĞRI VE SEMPTOM YÖNETİMİ 21
6.1. Ağrı Yönetimi 21
6.1.1. Ağrının Tanımı ve Sınıflandırılması 21
6.1.2. Çocuk Palyatif Bakımda Yaygın Görülen Ağrı Türleri 22
6.1.3. Ağrının Değerlendirilmesi 24
6.1.4. Ağrının Non-Farmakolojik Yönetimi 24
6.1.5. Ağrının Farmakolojik Yönetimi 24
6.2. Semptom Yönetimi 29
6.2.1. Solunum Sistemi Problemleri ve Yönetimi 29
6.2.2. Kas-İskelet Sistemi Problemleri ve Yönetimi 32
6.2.3. Nörolojik Semptomların Kontrolü 34
6.2.4. Beslenme ve Gastrointestinal Sistem Problemleri Yönetimi 38
6.2.5. Diğer Semptomların Yönetimi 44

7. YAPAY AÇIKLIKLARIN VE BASINÇ YARALARININ BAKIMI 48
7.1. Yapay Açıklıkların Bakımı 48
7.1.1. Stoma Çeşitleri 48
7.1.2. Stoma Bakımı 49
7.1.3. Trakeostomi Bakımı 50
7.2. Basınç Yaraları Bakımı 51
7.2.1. Basınç Yaralanması Evreleri 51
7.2.2. Önleme ve Tedavi 52

8. AİLE BAKIM EĞİTİMİ 55
8.1. Saturasyon Probu Kullanımı Eğitimi 55
8.2. Postüral Drenaj Eğitimi 55
8.3. Aspirasyon Uygulaması Eğitimi 55
8.4. Trakeostomi Bakımı Eğitimi 56
8.5. Kazara Dekanülasyon Eğitimi 57
8.6. Evde Mekanik Ventilasyon Takip Eğitimi 57
8.7. Beslenme Tüpü ile Beslenme Eğitimi 57
8.8. İlaç Uygulamaları Eğitimi 58
8.9. Kişisel Hijyenin Sağlanması Eğitimi 58
8.10. Venöz Kateter Bakım Eğitimi 59
8.11. Üriner Kateter Bakım Eğitimi 59

9. ÇOCUK, AİLE VE BAKIM VERENLER İLE İLETİŞİM 61
9.1. Kronik Hastalık Sürecinin Etkileri 61
9.1.1. Aileler Üzerindeki Etkisi 61
9.1.2. Çocuklar Üzerindeki Etkisi 61
9.2. Palyatif Bakımda Etkili İletişim 63
9.2.1. İletişimin Temel İlkeleri 63
9.2.2. Ailelerle Etkili İletişimin Önemi 63
9.2.3. Kötü Haber Verme Süreci 65
9.3. Aile-Çocuk İletişimi 65
9.3.1. Aile-Çocuk İletişiminde Kolaylaştırıcı Faktörler 65
9.3.2. Aile-Çocuk İletişiminde Karşılaşılan Zorluklar 67

10. YAŞAM SONU BAKIM 75
10.1. Karar Verme 75
10.2. Yaşam Sonu Bakım Kararları 75
10.3. Bilgilendirilmiş Rıza 76
10.3.1. Türkiye'de Çocuk Bireyde Bilgilendirilmiş Rıza 77
10.4. Ailenin Çocukla İlgili Kararları 78
10.5. Ailenin Karar Vermesinde Kültürün Rolü 78
10.6. Ölüm Yeri Tercihi 79
10.7. Bir Çocuğun İyi Ölüm Konsepti 79

10.8. Yaşam Sonu Bakımındaki Tartışmalar 80
10.9. Yaşam Sonu Bakım Eğitimi 81

11. YAS SÜRECİ 84
11.1. Beklenen Yas 84
11.1.1. Normalin, Kontrolün ve Dünya Görüşünün Kaybı 84
11.1.2. Erken Dönemde Danışmanlık Hizmeti Gereksinimi 84
11.1.3. Beklenen Yas Sürecinin Başlaması 85
11.1.4. Çocuğun ve Kardeşlerin Yas Sürecine Dâhil Edilmesi 85
11.1.5. Ölüm Kaygısı 85
11.1.6. Maneviyatın Rolü 86
11.1.7. Son Dönem Bakımında Mekanın Önemi 87
11.1.8. Aile Temelli Müdahaleler ile Yas Sürecini Desteklemek 87
11.1.9. Ölüm Hakkında Çocuklarla Konuşmak 88
11.2. Ölüm Zamanındaki Yas 89
11.2.1. Ölüm Anı 89
11.2.2. Ölüm Sonrası Bakım 89
11.2.3. İlk Haftalar 90
11.3. Ölümden Sonra Yas 91
11.3.1. Yas Takibi Süreci 91
11.3.2. Yas Sürecinde Bireysel - Kültürel Duyarlılık ve Kapsayıcılık 91
11.3.3. Danışmanlık ve Terapi Desteği 91

TABLOLAR

Tablo 1. Çocuk Palyatif Bakımın Temel İlkeleri 6
Tablo 2. Çocuk Palyatif Bakımda Yer Alabilecek Ekip Üyeleri.....12
Tablo 3. Taburculuk Esnasında Yapılacaklar.....18
Tablo 4. Non-Onkolojik Yaşamı Sınırlayan Hastalıklarda Çocuklarda Görülen Ağrı Nedenleri.....23
Tablo 5. Çocuk Palyatif Bakımda Sık Kullanılan Analjezik İlaçların Dozları.....28
Tablo 6. Bulantı ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar 41

ŞEKİLLER

Şekil 1. Çocuk Palyatif Bakımın Amacı 2
Şekil 2. Palyatif Bakımdan Yararlanabilecek Hasta Grupları 3
Şekil 3. Çocuk Palyatif Bakım Kapsamı 4

ALGORİTMALAR

Algoritma 1. Yatış, Sevk ve Taburculuk Kriterleri.....19

KISALTMALAR

AAP	Amerikan Pediyatri Akademisi (American Academy of Pediatrics)
ÇPB	Çocuk Palyatif Bakım
DPEJ	Direkt Perkutan Endoskopik Jejunostomi
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü
EB	Enteral Beslenme
FES	Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu
GİS	Gastrointestinal Sistem
GÖRH	Gastroözofageal Reflü Hastalığı
HEK	Hastane Etik Kurulu
KİBAS	Kafa İçi Basınç Artışı
MSS	Merkezi Sinir Sistemi
MV	Mekanik Ventilasyon
NEMS	Nöromusküler Elektrik Stimulasyonu
NG	Nazogastrik
OG	Orogastrik
ÖTAG	Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar
PEG	Perkütan Endoskopik Gastrostomi
SIMV	Senkronize Aralıklı Zorunlu Solunum (Synchronized İntermittant Mandatory Ventilation)
WHO	Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

1. ÇOCUK PALYATİF BAKIM

Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım alanındaki gelişmeler, son yıllarda bebek ve çocuk ölüm oranlarının belirgin şekilde azalmasına katkıda bulunmuştur. Tıbbi bakımın gelişmesi, daha önce hayatta kalması mümkün olmayan prematüre bebekler ve ciddi sağlık sorunları olan çocukların yaşama şansını artırmıştır. Ancak bu durum, kronik hastalıklarla yaşayan çocuk sayısında artışa yol açarak, sağlık sistemlerinde kronik ve karmaşık hastalık yönetimine olan ihtiyacı artırmıştır *(WHO, 2023)*. Yapılan araştırmalar, kompleks hastalıkları olan çocukların sağlık bakım maliyetlerinin, çocuk sağlığı için ayrılan sağlık bakım bütçesinin yaklaşık üçte birini oluşturduğunu ortaya koymaktadır *(Boyden vd., 2023)*.

Erken ve etkin palyatif bakım uygulamaları, gereksiz hastane kabullerini ve sağlık hizmetlerinin israfını önleyerek maliyetleri azaltmaktadır. Bu tür uygulamalar, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmakta ve hastalığın seyrini ve prognozunu olumlu yönde etkilemektedir *(Craig vd., 2008)*. Ayrıca, çocuklar için sağlanan erken ve etkin palyatif bakım, aile bütünlüğünü korumakta ve diğer sağlıklı çocukların ihmal ve istismarının önlenmesine yardımcı olmaktadır *(Liberman vd., 2016)*.

1.1. Tanımı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocuk palyatif bakımı (ÇPB), hayatı tehdit eden veya tedavi edilemeyen hastalıklara sahip çocuklara yönelik yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir yaklaşım olarak tanımlamıştır *(WHO, 2023)*. ÇPB, yetişkin palyatif bakımına benzer temel prensiplere sahip olsa da, kendi içinde çocukların yaşına, gelişim düzeyine ve özel ihtiyaçlarına göre fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal sorunları ele alarak, çocuklar ve aileleri için bütüncül bir destek sunar *(Chelazzi vd., 2023)*. Ayrıca bu bakımın hastalığın erken aşamalarında başlaması ve etkin bir şekilde yaşam sonuna kadar sürdürülmesi gereklidir. Çocuk palyatif bakım, sadece hastalığın yönetimiyle sınırlı kalmayıp, ailelerin de desteklenmesini ve çocukların yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir *(Şahin vd., 2022)*.

1.2. Amacı

Çocuk palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklarla karşılaşan çocukların ve ailelerinin karşılaştığı çeşitli sorunları kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefler (Şekil 1), *(Durmaz, 2024)*.

Ağrı Yönetimi ve Fiziksel Sorunların Giderilmesi

Başta ağrı olmak üzere, fiziksel problemleri erken tespit etmek ve bu sorunları önlemek veya yönetmek için stratejiler geliştirmek.

Psiko-Sosyal Destek

Çocukların ve ailelerin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak. Multidisipliner ekip yardımı ile psiko-sosyal destek sağlamak.

Yaşam Kalitesinin Artırılması

Çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak.

Manevî Bakım

Çocukların ve ailelerin dinî, kültürel ve manevî inançlarına saygı göstererek, onların manevî ihtiyaçlarını karşılamak.

Bilgilendirme

Çocukları ve ailelerini hastalık süreçleri hakkında bilgilendirmek ve onların bu süreçle başa çıkmalarını kolaylaştırmak.

Eğitim

Evde bakıma hazırlık süreci için ailelere daha etkili destek sağlayabilmek için eğitimler vermek.

Şekil 1. Çocuk Palyatif Bakımın Amacı

1.3. Kapsamı

Palyatif bakım tanılarında sıklıkla geçen "yaşamı sınırlayan koşullar", tedavi edilemeyen ve çocuklukta ölüm riski taşıyan durumları ifade ederken, "yaşamı tehdit eden koşullar" ise iyileştirilebilen ancak tedavilerin başarılı olamayabileceği durumları belirtir. Çocuk palyatif bakım kapsamında, yaşamı sınırlayan ve tehdit eden koşullar 4 katagoride incelenmektedir (Şekil 2.) *(Durmaz, 2024)*.

Çocuk palyatif bakım desteği, çocuk hasta hayatı tehdit eden kronik bir hastalık tanısı aldığında başlamalıdır ve hastanın ölümüne kadar hasta ve ailesine destek vermeyi kapsamalıdır. Hastanın ölümünün gerçekleşmesinden sonra yas sürecinde mümkünse yaklaşık 2 yıl daha aileye destek verilmesi hedeflenmelidir (Şekil 3.) *(Şahin vd., 2022)*.

Kategori 1

Küratif tedavinin mümkün olduğu ancak tedavide başarısızlık ihtimali bulunan yaşamı tehdit eden durumlardır. Hem küratif hem de palyatif bakım yan yana verilebilir. Ancak, küratif tedavinin başarılı olmadığı kesinleştiğinde, kanserler, çoklu ilaç dirençli tüberküloz, HIV/AIDS ve benzeri durumlarda sadece palyatif bakıma geçilebilir.

Kategori 2

Erken ölümün kaçınılmaz olduğu, yaşamı sınırlayan hastalıklardır. Küratif tedavinin başarısız olduğu ortaya çıkana kadar küratif ve palyatif bakım birlikte verilebilir. Örnek; kistik fibrozis, spinal musküler atrofi, duchenne musküler distrofi.

Kategori 3

Sadece palyatif bakımın verilebildiği, hastalığın tedavi edilemediği ve giderek kötüleştiği hastalıklardır. Örnek; Trizomi 13 ve 18 gibi kromozomal bozukluklar, kalıtsal metabolik hastalıklar, anensefali.

Kategori 4

İlerleyici olmayan ancak geri döndürülemez hastalıklardır. Örnek; ağır serebral palsi, kaza ve travma sonrası birden fazla engellilik gösterilebilir.

Şekil 2. Palyatif Bakımdan Yararlanabilecek Hasta Grupları



Şekil 3. Çocuk Palyatif Bakım Kapsamı

Kaynakça

Boyden, J. Y., Bogetz, J. F., Johnston, E. E., Thienprayoon, R., Williams, C. S. P., McNeil, M. J., Patneaude, A., Widger, K. A., Rosenberg, A. R., & Ananth, P. (2023). Measuring Pediatric Palliative Care Quality: Challenges and opportunities. Journal of Pain and Symptom Management, 65(5). https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.01.021

Chelazzi, C., Villa, G., Lanini, I., Romagnoli, S., & Latronico, N. (2023). The adult and pediatric palliative care: Differences and shared issues. Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care, 3(1). https://doi.org/10.1186/s44158-023-00085-8

Craig, F., Abu-Saad Huijer, H., Benini, F., Kuttner, L., Wood, C., Feraris, P. C., & Zernikow, B. (2008). IMPACCT: Standards Pädiatrischer Palliativversorgung in Europa. Der Schmerz, 22(4), 401–408. https://doi.org/10.1007/s00482-008-0690-4

Durmaz, N. (2024). Pediatrik Palyatif Bakımın Tanımı, Felsefesi ve Temelleri. Durmaz, N (Ed).Pediatrik Palyatif Bakım (pp. 1–6). essay, Türkiye Klinikleri . Retrieved from https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/cocuk-hematolojisi-ve-onkolojisi-ozel-konular/975/issue/2024/5/4-0/pediatrik-palyatif-bakim/tr-index.html.

Liberman, D. B., Song, E., Radbill, L. M., Pham, P. K., & Derrington, S. F. (2016). Early introduction of palliative care and advanced care planning for children with complex chronic medical conditions: A pilot study. Child: Care, Health and Development, 42(3), 439–449. https://doi.org/10.1111/cch.12332

Şahin, Ş., Öztek Çelebi, F. Z., & Ayar, G. (2022). End-of-life care in pediatric palliative care. Journal of Medicine and Palliative Care, 3(4), 394–398. https://doi.org/10.47582/jompac.1192764

World Health Organization. (2023). Palliative care for children. World Health Organization. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care-for-children

2. ÇOCUK PALYATİF BAKIMIN TEMEL İLKELERİ

Palyatif bakımın temel ilkeleri, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen iyi klinik uygulamaların temel prensipleri olarak kabul edilebilir. Palyatif bakımın temel ilkeleri arasında iletişim, semptom tanısı ve değerlendirmesi, ağrı kontrolü, diğer yaygın semptomlar, duygusal bakım, sosyal konular, manevi/varoluşsal konular, keder ve yas süreçleri, personel stresi, tükenme ve etik konular bulunmaktadır *(Durmaz, 2024)*. Bu ilkeler, disiplinler arası işbirliği ile sorunların çeşitli perspektiflerden ele alınmasını ve hem çocuk hem de ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefler. Tablo 1'de Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği temel ilkeler belirtilmiştir *(WHO, 2023)*.

2.1. Çocuk Palyatif Bakımın İlkeleri

Tablo 1. Çocuk Palyatif Bakımın Temel İlkeleri

Çocuğun bedensel, ruhsal,sosyal,gelişimsel ve manevi olmak üzere bütünsel bakımı sağlanır.
Yaşamı onaylar ve ölümü normal bir süreç olarak görür.
Ölümü ne hızlandırmayı ne de ertelemeyi planlar.
Psikolojik ve manevi bakımı birleştirir.
Hastanın ölümüne kadar aktif olarak yaşamasına yardım edici bir destek sistemi sağlar.
Hasta yakınlarının hastalığa ve yas sürecine uyum sağlamalarına yardım eder.
Yas danışmanlığı da dâhil olmak üzere, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekip yaklaşımı kullanır.
Yaşam kalitesini artırmayı hedefler.
Hastalığın erken döneminde, yaşamı uzatabilecek tedavi yöntemleri olan kemoterapi veya radyoterapi yöntemlerini diğer tedavilerle birlikte uygulayabilir.
Istırap veren klinik komplikasyonları daha iyi anlamak ve yönetmek için gereken araştırmaları içerir.
Sürdürülebilir olmalıdır.

► ***Çocuğun bedensel, ruhsal ve manevi olmak üzere bütünsel bakımı sağlanır***

Şiddetli ağrı, solunum sıkıntısı veya beslenme zorlukları gibi ileri düzey semptomlar yaşayan çocuklar, ÇPB hizmetlerinden yoğun destek almalıdır. Temel semptom yönetiminin ötesinde ÇPB, çocuk ve ailesi için pisikososyal ve manevi destek de sağlamaktadır. Palyatif bakım tanı ile başlar ve hastalığın erken döneminde, yaşamı uzatabilecek tedavi yöntemleri olan kemoterapi veya radyoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte uygulanarak devam eder *(Aasen vd., 2023)*.

► ***Palyatif bakımda yaşam ve ölüm normal süreçler olarak görülür***

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), palyatif bakımın temel ilkelerinden biri olarak, "ölümü ne

hızlandırmayı ne de ertelemeyi amaçlamak" anlayışını vurgular *(Benini vd., 2022)*. Bu ilke, palyatif bakımın amacı ile ilgili önemli bir noktayı belirtir. Palyatif bakım, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve acılarını hafifletmeyi amaçlar, ancak ölümün doğal bir süreç olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım, hastaların son dönemlerinde onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaya odaklanır ve yaşamın sonuna dair kaygıları azaltmayı amaçlar. Palyatif bakım, yaşamı sonlandırmayı değil, yaşamın son dönemlerini daha kaliteli hale getirmeyi hedefler *(Şahin vd., 2022)*.

- ***Çocuk ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir***

  Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, hastanın ihtiyaçları belirlenir. Bütüncül bir yaklaşım ile her disiplin, kendi perspektifinden hastayı değerlendirecek şekilde hareket eder. Palyatif bakımda multidisipliner ekip, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli görevler üstlenir. Bunlar arasında aile danışmanlığı, ailelerin duygusal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olan profesyonel destek, akran desteği ve benzer deneyimlere sahip bireylerin bir araya gelerek birbirlerine duygusal destek sunması bulunmaktadır. Ayrıca, müzik terapisi ile rahatlama ve duygusal iyileşme sağlanması, hasta ve kardeşler için manevi destek sunarak duygusal ve ruhsal ihtiyaçların karşılanması ve uygun geçici bakım ile ailesel dinlenme fırsatları tanımak amacıyla nitelikli bakıcılardan hizmet alınması da yer almaktadır *(Marcus vd., 2020)*.

- ***Palyatif bakım aile merkezlidir ve aile tüm sürece dâhil edilir***

  Pediyatrik hastalıklar yalnızca çocuğu değil, aynı zamanda ailesini, okulda arkadaşlarını ve akrabalarını da etkiler. Fiziksel, psikososyal ve ruhsal kaygılar, çocuğun ebeveynleri, kardeşleri ve diğer aile üyeleri üzerinde de derin bir etki yaratır. Aile üyelerinin ihtiyaçları, çocuğun bakımındaki özel rollerine, çocukla olan ilişki türüne, yaşa, bilişsel duruma, anlayış düzeyine, kültürel ve ruhsal inançlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, pediyatrik bakım süreçlerinde ailenin tüm bireylerinin desteklenmesi önemli bir gerekliliktir *(Mitchell vd., 2020)*. Çocuk Palyatif Bakım hizmeti verilirken aile ile birlikte hedefler belirlenmeli, çocuğun ve ailenin karar verme sürecine aktif olarak katılımı teşvik edilmelidir. Bu alanlar, tedavi hedefleri ve planları hakkında iletişim, etik ve ortak karar verme, ağrı ve semptomların giderilmesi, bakımın sürekliliği, ailenin desteklenmesi ve yas/yas desteğini kapsamaktadır.

- ***Ailenin kültür, inanç, ırk, dil, din, etnik farklılıkları, beklentileri, yaş ve eğitim düzeylerine göre bakım planlanmalıdır***

  Biyomedikal etiğin ilkeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde, toplumsal, entelektüel ve kültürel gelenekler, ailenin tanı veya prognoz konusundaki kararları üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Farklı kültürlerde karar verme süreçleri; inanç sistemleri, din adamlarının katılımı, kurum ve kamu politikalarının yanı sıra hastane etik kurulları hasta ailesi ve çocuklara ölüm gerçeğinin aktarımı gibi unsurlarla şekillenir. Ayrıca, ağrı, ıstırap ve ölümün anlamı gibi konuların iletişimi de büyük önem taşır *(Parsa-Parsi, 2022)*.

  Çocuk hastaları, yenidoğandan ergenliğe kadar farklı fizyolojik ve gelişimsel ihtiyaçlar

göstermesi nedeni ile her hastaya yaşına ve gelişim dönemine uygun bireyselleştirilmiş bir bakım yaklaşımı benimsenmelidir.

- ***Sağlık hizmetinin verildiği tüm ortamlarda palyatif bakım hizmeti sunulmalı, buna ihtiyaç duyan tüm çocuklar için erişilebilir olmalı, hatta gerektiğinde çocuğun evinde de verilmelidir***

  Çocukların ve ailelerin ihtiyaçları değişkenlik gösterdiğinden, bakım evde, hastanede, ayakta tedavi merkezlerinde ya da bakımevlerinde sunulabilir. Bu bağlamda, bakımın çocuk ve aile tercihlerine göre özelleştirilmesi büyük önem taşır *(WHO, 2023)*.

- ***Sürdürülebilir olmalıdır***

  Uzmanlaşmış çocuk palyatif bakım ekibi, hastaların ihtiyaçlarına göre sürekli bakım sağlamak amacıyla farklı hizmet alanları arasında geçiş yaparak, hastaneye yatırılan hastalara konsültasyon ile, evde bakım hizmetleri alan hastalara telefon konsültasyonu ile sürekli bir etkileşim ve koordinasyon sağlar. Bu yaklaşım, bakımın sürekliliğini sağlayarak palyatif bakım sürecinde kesintisiz hizmet sunmayı hedefler. Böylece, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verme ve yaşam kalitelerini artırma potansiyeli ortaya çıkar *(Ersoy & Şahin, 2024)*.

Kaynakça

Aasen, E. R., Søvik, M. L., Størdal, K., & Lee, A. (2023). Are we on the same page? exploring pediatric patients' involvement with Advance Care Planning. Journal of Pain and Symptom Management, 66(3). https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2023.04.003

Benini, F., Avagnina, I., Giacomelli, L., Papa, S., Mercante, A., & Perilongo, G. (2022). Pediatric palliative care in oncology: Basic principles. Cancers, 14(8), 1972. https://doi.org/10.3390/cancers14081972

Durmaz, N. (2024). Pediatrik Palyatif Bakımın Tanımı, Felsefesi ve Temelleri. N Durmaz, (Ed).Pediatrik Palyatif Bakım (pp. 1–6). Ankara. Türkiye Klinikleri. https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/cocuk-hematolojisi-ve-onkolojisi-ozel- konular/975/issue/2024/5/4-0/pediatrik-palyatif-bakim/tr-index.html.

Ersoy, M., & Şahin, Ş. (2024). Türkiye'de ve dünyada pediatrik palyatif bakım uygulamaları. N. Durmaz (Ed.), Pediatrik palyatif bakım (pp. 7–14). Ankara. Türkiye Klinikleri. https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/cocuk-hematolojisi-ve-onkolojisi-ozel- konular/975/issue/2024/5/4-0/pediatrik-palyatif-bakim/tr-index.html.

Marcus, K. L., Santos, G., Ciapponi, A., Comandé, D., Bilodeau, M., Wolfe, J., & Dussel, V. (2020). Impact of Specialized Pediatric Palliative Care: A Systematic Review. Journal of pain and symptom management, 59(2), 339–364.e10. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2019.08.005

Mitchell, S., Slowther, A.-M., Coad, J., & Dale, J. (2020). Experiences of healthcare, including palliative care, of children with life-limiting and life-threatening conditions and their families: A longitudinal qualitative investigation. Archives of Disease in Childhood, 106(6), 570–576. https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-320189

Parsa-Parsi R. W. (2022). The International Code of Medical Ethics of the World Medical Association. JAMA. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2797507

Şahin, Ş., Öztek Çelebi, F. Z., & Ayar, G. (2022). End-of-life care in pediatric palliative care. Journal of Medicine and Palliative Care, 3(4), 394–398. https://doi.org/10.47582/jompac.1192764

World Health Organization. (2023). Palliative care for children. World Health Organization. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/palliative-care-for-children

3. MULTİDİSİPLİNER EKİBİN BİLEŞENLERİ

Ekip, belirli bir ortak amacı başarmak için iki veya daha fazla kişiden oluşan grup olarak tanımlanmaktadır *(Spect, 2009)*. Ortak amacın niteliği ve ihtiyaçlara göre kişi sayısı değişmektedir. Sağlık hizmetlerinde bireyin ihtiyaçları, çok yönlü bakım planının gerekliliği ve yaklaşımların çeşitliliği nedeniyle sağlık profesyonellerinin disiplinlinler arası ekiplerle çalışmasının önemi açıktır *(Öğüt, 2011)*. Sağlık kurumlarında ekip, bireye en kapsamlı ve kaliteli sağlık bakımını vermek üzere farklı sağlık profesyonellerinin bir araya gelerek; her birinin kendi görevlerini yerine getirdiği, sürekli bilgi ve deneyimlerini aktardığı, ortak karar aldığı ve birlikte uyguladığı takım olarak tanımlanmaktadır *(Oktay, 1990; Özdemir, 1999; Velioğlu, 1988)*.

3.1. Ekip Kavramı

Çocuk palyatif bakımda (ÇPB) ihtiyaçlar ve ekip çalışması bazı özellikler göstermektedir. Özellikle hasta ve ailesinin psikolojik ihtiyaçları, çocuğun gelişimsel süreci, aile bireyleri ile bakım verenlerin karar aşamasındaki belirleyici rolü başlıca ayırıcı yönleridir. Oyun ve okul ihtiyacı gibi farklı yönlerin bulunması ekip üyelerinin de bazı özellikleri taşıması ve bu bakımdan destekleyici, sevgi ve şefkat dolu olması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Çocuğun sosyal hayatın içindeki eğitim ve eğlence gibi faaliyetlere katılımının desteklenmesi gerekliliği de uygulamada farklı ihtiyaçları gündeme getirmektedir. Avrupa Palyatif Bakım Derneği'nin Trento Uluslararası Pediyatrik Palyatif Bakım Toplantısı (IMPACCT) sonucu oluşturulan Avrupa'daki Pediyatrik Palyatif Bakım Standartları raporu etkili palyatif bakımın tanı anından başlayarak fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden çocuğun aktif olarak bakımını sağlarken aileye destek verilmesini de içeren geniş bir multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu ve toplumsal kaynaklar sınırlı bile olsa, çocuğun erişimine açık bütün servislerde, halk sağlığı merkezleri ve hatta çocukların evlerinde de sağlanabilmesi gerektiğini vurgulamaktadır *(IMPACCT, 2013)*. Raporda aile kapsamındaki genetik bağdan bağımsız, çocuğa fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal katkıda bulunan kişilerin yeterli uzmanlık düzeyinde olması gerektiği ve her aşamada ekip kavramının önemi belirtilmiştir *(Alexandria, 2010; Kılıç, 2018)*.

Uzmanlaşmış temel ÇPB ekibi hekim, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal hizmet uzmanı, çocuk terapisti veya psikoloğu, klinik destek personeli ve manevi bakım sağlayacak bir profesyonelden oluşması önerilmektedir *(Kılıç, 2018; AAP, 2009)*. Bu ekiplerde diş hekimleri, konuşma terapistleri, iş ve uğraşı terapistleri, yutma fizyoterapisti, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulayıcılar, araştırmacılar, yas danışmanları, eğitimciler, hukuk danışmanları ve gönüllüleri ile hayvan destekli terapi ve müzik terapi uygulayıcıları gibi ekip üyelerinin de yer almasının bakım kalitesi açısından olumlu etkileri olacağı bildirilmektedir *(AAP, 2009)*.

Tüm planlamaların ve uygulamaların ötesinde, psikolojik ve manevi açıdan zor süreçleri hasta ve aileleriyle paylaşan, tükenmişlik oranlarının yüksek olması beklenen palyatif bakım çalışanlarının

palyatif bakımı bir yaşam tarzı olarak gördükleri, manevi boyutta kendilerini iyi hissettiklerini gösteren çalışmalar bulunmaktadır *(Spect, 2009; Iliffe, 2008)*. Sevgi, şefkat ve güven temelli ilişki hastalar ve ekip arasındaki temel unsuru oluşturmaktadır *(Kang, 2018)*. Çocuk palyatif bakımda "hasta çocuk ve ailesi merkezli bakım" esas alınırken, özel eğitim almış multidisipliner ekip çalışmasının bakım kalitesinin yanı sıra, hasta memnuniyeti, hastane masrafları ve hatta hastanın yaşam sürelerine olumlu etki gösterdiği bildirilmiştir *(Morrison vd., 2008; Bakitas vd., 2009; Weaver, 2017)*.

3.2. Ekibin Bileşenleri ve Görevleri

Palyatif bakım ekibi; sorumlu tabip, sorumlu hemşire, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, manevi destek uzmanı, yara bakım hemşiresi, iş uğraş terapisti ve gerekli durumlarda palyatif bakım hizmetinin gerektirdiği diğer meslek mensuplarından oluşur. Sağlık tesisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuk cerrahisi uzmanı tabip bulunmalıdır. Palyatif bakım ekibinde yer alabilecek ekip üyeleri (Tablo 2) ve temel ekip üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Hasta ve hasta yakını; hastalık ya da mevcut semptomlar hakkında ekip üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunur. Kendi yaşam deneyimlerini ve hastalıkla ilgili semptomlarını, tepkilerini dile getirir ve bakım planının hazırlanması ve karar alınmasında aktif rol alır.

Sorumlu hekim/uzman hekim; Çocuk palyatif bakım tedavisinin temeli olarak fiziksel semptomların yönetimi; ayrıntılı bilgiye ulaşıp semptom kontrolü ve ağrı yönetiminde rol alan bir (tercihen) çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılır. Hastalık ve prognozla ilgili olarak hastayı, hasta yakınını ve ekibin diğer üyelerini bilgilendirir, aradaki iletişimi destekler. Hastaların bakımıyla ilgili kararlarda uzlaşmanın gerçekleşmesini sağlar. Çoğunlukla da ekibin yönetimini üstlenir. Çocuklarda birçok hastalıkta prognoz ve fonksiyonel çıktıların net olmaması sebebi ile palyatif bakım desteğinin mevcut hastalığın tedavisi ile birlikte devam etmesi gerekebilir. Aynı zamanda büyüme gelişme sürecinin devam etmesi, erişkine göre ihtiyaçlarının, hastalıklarının ve ilaç dozlarının bile farklı olması ÇPB ekibinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının olmasını gerekli kılar.

Hemşire; hasta ve ailesiyle sık görüşme ve iletişim halindedir. Hastaya ilerleyen hastalığın getirmiş olduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda yardımcı olur; hastaya günlük becerilerini gerçekleştirmesinde destek olur ve hemşirelik girişimleriyle semptom kontrolüne katkı sağlar. Bakım verene bakım eğitimlerini uygulamalı olarak verir.

Sosyal hizmet uzmanı; hastalığın oluşturduğu sosyal ve bireysel değişikliklerin ve ölümün üstesinden gelmeleri konusunda destek sağlar. Kurumlarla olan iletişimlerinde, bakımın planlanmasında, olası ekonomik sorunlarda ve aile içi çatışmalarda destek olur. Taburcu edilmelerinde ve hazırlıklarda destek olur; sosyal servisleri ve evde bakım hizmetlerini harekete geçirir, danışmanlık yapar ve yas sürecinde hasta yakını için destek sağlar. Hastanın özellikle

uzun süren hastane yatışlarında diğer kardeşlerinin ihmal edilmemesi için takibini yapar.

Klinik Psikolog; hasta çocuk ve ailenin hastalığın üstesinden gelmesinde; depresyon ve kaygı durumları ile başetme konusunda hastaya destek sağlar. Hasta yakınlarını ve ekip üyelerini destekler.

Fizyoterapist; hastaların çoğunun yatağa bağımlı olması sebebiyle ihtiyacı olan fizyoterapinin uygulanmasını ve ailenin egsersiz eğitimlerinin ve fizyoterapi uygulamalarının devamlılığını sağlar.

Diyetisyen; hastaların tanısına, klinik durumuna ve bireysel özelliklerine göre enerji, makro ve mikro besin öğesi gereksinimlerini hesaplar, tıbbi beslenme tedavisini hekim yönlendirmesi ile planlar, ekip ile vizitlere katılarak hastanın takibini yapar, beslenme tedavisinin etkinliğini izler ve eğitim verir.

Din görevlisi/Manevi bakım görevlisi; hastanın din ve inancından bağımsız olarak dini ve manevi sorunlarda danışacağı/konuşacağı kişidir; hastalığın anlamlandırma arayışında destek sağlar.

Tablo 2. Çocuk Palyatif Bakımda Yer Alabilecek Ekip Üyeleri

Sorumlu hekim	Eczacı
Sorumlu hemşire	İş ve uğraşı terapisti
Klinik psikolog	Yutma terapisti
Diyetisyen	Ergoterapist
Fizyoterapist	Konuşma terapisti
Sosyal hizmet uzmanı	Manevi bakım görevlisi
Stoma ve yara bakım hemşiresi	Bakım elemanı
Tıbbi sekreter	Temizlik elemanı

Kaynakça

Alexandria,V.A. (2010). National Hospice and Palliative Care Organization, Available at: https://www.nhpco.org/wp-content/uploads/Pediatric_Standards.pdf

American Academy of Pedıatrıcs Committee on Bioethics and Committee on Hospital Care Palliative Care for Children. (2000). Pediatrics, 106(2), 351-357. www.aappublications.org/news

Bakitas, M., Lyons, K.D., Hegel, M.T., Balan, S., Brokaw, F.C., Seville, J., Hull, J.G., Li, Z., Tosteson, T.D., Byoock, I.R., Ahles, T.A. (2009). Effects of a palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer: the Project ENABLE II randomized controlled trial. Jama, 302(7), 741-749.

Iliffe, S. (2008). Myths and realities in multidisciplinary team-working. London Journal of Primary Care. 1(2), 100-102.

IMPACCT (2013): Avrupa'daki Pediatrik Palyatif Bakım Standardları Pediatric Palliative Care and Hospice Care Commitments, Guidelines, and Recommendations Section on Hospice and Palliative Medicine And Committee on Hospital Care. Pediatrics, 132, 966-72.

Kang, J.H., Go, S.I., Bruera, E. (2018). Compassion is a key quality for palliative care teams. Cancer Med, 7(11), 5325-5326.

Kılıç, Ö.Y., Oruç, M.A., İskenderoğlu, M., Tükenmez, B. (02-03 Mayıs 2018). Palyatif Bakımda Ekip Çalışması, Kapsamlı Bakım ve Rehabilitasyon. [TC. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Palyatif Bakım Çalıştay Raporu ve 1. Samsun Palyatif Bakım Sempozyumu]. Samsun, Türkiye. https://samsunism.saglik.gov.tr/TR,71881/i-samsun-palyatif-bakim-sempozyumu.html

Morrison, R.S., Penrod, J.D., Cassel, J.B., Caust-Ellenbogen, M., Litke, A., Spragens, L., Meier, D.E. (2008). Cost savings associated with US hospital palliative care consultation programs. Archives of Internal Medicine, 8, 168(16), 1783-1790.

Oktay Ş. (1990). Etkin Sağlık Hizmeti İçin Disiplinlerarası Ekip Yaklaşımı. Hemşirelik Bülteni, 15, 27-31.

Öğüt, A. ve Kaya, ŞD. (2011). Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 87-95.

Özdemir U. (1999). Psikiyatri Tedavi Ekibinin Ekip Çalışması Kavramına İlişkin Kendi Bilgilerini ve Çalıştıkları Psikiyatri Tedavi Kurumlarını Değerlendirmeleri. Kriz Dergisi, 7(2), 17-24.

Speck, P. (2009). Teamwork in Palliative Care Fullfilling or Frustrating ? (2nd Edition, pp. 7-24, 39). Oxford University Press.

Velioğlu P. (1988). Sağlığa Disiplinler arası Ekip Yaklaşımı. Hemşirelik Bülteni, 10, 1-9.

Weaver, M.S., Rosenberg, A.R., Julia, T., Wichman, C.S., Wiener, L. (2018). A Summary of Pediatric Palliative Care Team Structure and Services as Reported by Centers Caring for Children with Cancer Journal of Palliative Medicine, 20(20), 1-11.

4. ÇOCUK PALYATİF BAKIM DESTEĞİ NERELERDE YAPILIR?

Çocuk hastalar için PB desteğinin, genellikle evde bakım ekibi ile iletişim kurularak çocuğun evinde yapılması önerilir. Yatış endikasyonu olmayan hastalar için destek evde devam ettirilmelidir.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ÇPB hizmeti başta hastaların evlerinde olmak üzere, 1., 2. veya 3. basamak sağlık tesislerinde verilebilir *(WHO, 2018)*.

4.1. Hastane Tabanlı Palyatif Bakım

Hastane tabanlı palyatif bakım programları, palyatif bakım danışma ekiplerini, palyatif bakım servislerini ve ayaktan palyatif bakım hizmetlerini içerir. Karmaşık tıbbi sorunları olan ve intravenöz tedavi ile semptom kontrolü yapılacak olan hastalar hastanede palyatif bakım desteği alırlar *(Weaver vd., 2022)*. İntravenöz tedavileri biten hastanın bakım hedefleri planlandıktan ve aile eğitimleri tamamlandıktan sonra evde bakım birimine devri yapılarak hasta evine taburcu edilir.

Terminal dönem hastaları için zor olan karmaşık semptom yönetimi evde yapılamadığı ve ailenin semptomlarla başedemediği durumda hastane tabanlı palyatif bakım desteği için hasta yatırılabilir *(Harrop vd., 2013)*.

4.2. Ev Tabanlı Palyatif Bakım

Hastanede verilen ileri palyatif bakım desteğinin ev ortamında verildiği ev tabanlı palyatif bakımın hasta ve ailesi açısından birçok avantajı mevcuttur. Bu anlayış sayesinde ev tabanlı yaklaşımla palyatif bakım konusunda toplumun farkındalık düzeyi artmakta ve aile palyatif bakım sürecine daha çabuk entegre olmaktadır. Altta yatan hastalığın tedavisiyle eş zamanlı bir müdahalenin yaşam kalitesini iyileştirebileceği ve palyatif bakım eğitimi verildiğinde çocuk ve ailelerin pozitif bakım verme durumunun önemli derecede artacağı ve daha iyi semptom kontrolü yapılacağı düşünülmektedir *(Seow vd., 2018)*. Son zamanlarda yapılan randomize kontrollü çalışmalarda palyatif bakım hastası çocuklara 3 ay boyunca ev tabanlı palyatif bakım verilmiş ve bu bakımın yaşam kalitesinin çeşitli yönlerini iyileştirdiği ve malignitesi olan çocukların daha iyi semptom yönetimi sağladığı bulunmuştur. Toplumdaki kaynaklar sınırlı olsa bile mevcut kaynakların etkin ve başarılı bir biçimde kullanılması önemlidir. Bu bakım felsefesinin uygulanan bakımlara entegre edilmesi, yaşam kalitesi, semptom yükü, sağ kalımı ve hasta memnuniyetini önemli ölçüde iyileştirecektir *(Alexie vd., 2006; Roberts vd., 2021)*.

Kaynakça

Alexie C., Diane E.M.(2006). Palliative Care Services and Programs, Editor(s): Linda L. Emanuel, S. Lawrence Librach, Palliative Care, W.B. Saunders, Pages 567-581, ISBN 9781416025979, https://doi.org/10.1016/ B978-141602597-9.10039-0 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781416025979100390).

Harrop E, Edwards C.(2013). How and when to refer a child for specialist paediatric palliative care. Arch Dis Child Educ Pract Ed.98(6):202-8. doi: 10.1136/archdischild-2012-303325. Epub 2013 Aug 23. PMID: 23975414.

Roberts, B., Robertson, M., Ojukwu, E.I. et al. (2021). Home Based Palliative Care: Known Benefits and Future Directions. Curr Geri Rep 10, 141–147 . https://doi.org/10.1007/s13670-021-00372-8.

Seow H, Bainbridge D.(2018). A Review of the Essential Components of Quality Palliative Care in the Home. J Palliat Med. 21(S1):S37-S44. doi: 10.1089/jpm.2017.0392. PMID: 29283868; PMCID: PMC5733665.

World Health Organization.(2018). Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for healthcare planners, implementers and managers.

Weaver MS, Lindley LC.(2022). Choiceless options: when hospital-based services represent the only palliative care offering. Pediatr Res.91(4):1001-1003. doi: 10.1038/s41390-021- 01909-5. Epub 2021 Dec 18. PMID: 34923578.

5. ÇOCUK PALYATİF BAKIMA KABUL,TABURCULUK VE SEVK KRİTERLERİ

Çocuk palyatif bakım (ÇPB), kabul ve taburcu kriterleri dünya literatüründe tartışılmış ve tanımlanmış olmakla birlikte bu kriterler ülkelere, kurumlara ve sağlık sistemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir *(Wood vd., 2010; Fraser vd., 2014)*. Genel olarak kabul ve taburcu süreci, genellikle tedavi edici yaklaşımın ön planda olmadığı, hastanın ihtiyaçlarına, prognozuna ve yaşamı sınırlayan veya yaşamı tehdit eden durumun bakım hedeflerine göre şekillenir *(Harrop vd., 2013)*. Dünya Sağlık Asemblesi 3. düzey palyatif bakım eğitiminin üye ülkelerin sağlık hizmeti sunucularına verilmesini gerekli görmektedir. 1. düzey eğitimi tüm tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencileri almalıdır. 2. Düzey eğitimi ise pediyatri gibi hayatı tehdit eden hastalıkları izleyen sağlık çalışanları almalıdır. Her pediyatri hekimi ve hemşiresi rutin semptom yönetimini sağlamalıdır. 3. Düzey eğitimi ise uzmanlaşmış palyatif bakım hizmetlerini veren sağlık profesyonellerinin sahip olması gereken eğitimdir *(WHO, 2014)*. Dünya Sağlık Örgütüne göre ÇPB hizmeti, hastaların evlerinde, 1., 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde verilebilir (WHO, 2018).

5.1. Çocuk Palyatif Bakıma Kabul Kriterleri

Çocuk palyatif bakım ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri ilk tanı dönemlerinde ve klinik durumlarındaki kötüleşmelerin olduğu ilk dönemlerde hem hastalığı kabul süreci hem de yeni durumdaki bakım ihtiyaçlarını anlama ve yönetme konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. ÇPB hizmeti alma özellikle belirtilen durumlarda haktır *(European Convention on Human Rights, ETS No. 5.; Carney, 2023)*. Hastalıkla ilgili ve semptomla ilgili tedavi iletişimi, psikososyal, duygusal ve ruhsal destek, akut bakım ihtiyaçları, yaşam sonu bakım ihtiyaçları, bakım yönetimi ihtiyaçları kabul edilme kriterleridir *(Carney, 2023)*. ÇPB hizmetine ihtiyacı olan çocukları belirlemek için tanımlar şunlardır *(Bergstraesser, 2013; Lazzarin, 2021)*.

Yaşamı Sınırlayan veya Tehdit Eden Hastalıklar: Tamamen kür sağlamanın mümkün olmadığı ya da erken ölümün muhtemel olduğu düzeltilemeyecek durumlar ÇPB'ye kabul için en önemli kriter olarak görünmektedir *(Wood, 2010)*. Ciddi nörolojik bozukluklar, doğuştan gelen anomaliler, bazı metabolik hastalıklar, son evre kanser ve organ yetmezlikleri başlıca kabul durumlarıdır *(Wood, 2010; Harrop, 2013)*.

Karmaşık Semptom Yönetimi: Altta yatan hastalıklarına bağlı olarak ağrı, solunum sıkıntısı veya beslenme zorlukları gibi ileri düzeyde semptom yönetimi gerektiren çocuklar, ÇPB'nin sağladığı yoğun desteğe ihtiyaç duyarlar. Temel düzeyde semptom yönetiminin ötesinde desteğe ihtiyaç duyan hastalar kronik karmaşık koşulları olan çocukların (örneğin; serebral palsi, böbrek yetmezliği, elektrolit bozuklukları, skolyoz ve laringomalazi birlikteliği) servise yatarak izlemi bir diğer kabul kriteridir *(Schwantes, 2014)*.

Tedavi iletişimi: Hastalığın çocuk ve aileyle konuşulması, tedavi sürecinin ilerleyişi, bakım eğitimlerinin verilmesi, ölüm, ölüm yeri tercihi gibi konuların ve kararların paylaşılması ve açık, dürüst ve etkili iletişim sağlanması için yatış yapılabilir. Ayaktan tedavi sırasında böyle bir iletişimin sağlanması zordur, güven ilişkisi oluşması ve sevgi, şefkat gibi ÇPB'nin esaslarından olan iletişimin sağlanması önemlidir. Hasta ve ailenin bu nedenle yatışı yapılabilir.

Akut bakım yönetimi: Tanıdan sonra evde veya ayakta izlemi devam eden çocukların nöbet, solunum sıkıntısı, bulantı-kusma, beslenememe gibi ani gelişen semptomlarının tanı ve tedavisi için servis yatışı yapılarak takibi de hastane yatışı nedeni olmaktadır. Hastaların akut bakım gerektiren durumları düzeldikten sonra önceki bakım planına devam edilebilmektedir. Bu aşamaya gelen hastalar tekrar evlerine taburcu edilebilirler.

Psikososyal Aile Desteği: Çocuğun hastalığının duygusal ve ruhsal yönleriyle başa çıkmak için ciddi bir psikososyal desteğe ihtiyaç duyulduğu durumlarda ve/veya bakımın yapılmasında sorunlar gözlendiğinde çocuk ve aile servise kabul edilmelidir. Ayrıca ülkemizde hospis düzenlemesi bulunmaması nedeniyle, hasta ve aileye psikososyal desteğin yanında aileye dinlenme bakımını sağlamak amacıyla da hasta kabul edilebilir *(Lyon, 2013; Chelazzi, 2023)*. Bazı durumlarda tek seferlik görüşmelerden ziyade devam eden bir ilişki ve güven süreci olarak çocuk ve ailenin desteklenmesi için hasta ve ailesinin ÇPB'ye yatışı gerekebilir.

Yaşam Sonu Bakım İhtiyaçları: Hastalığın terminal evresinde olan, fiziksel, duygusal ve ruhsal ihtiyaçların karşılanması gereken çocuklar için çocuk ve ailenin isteği de göz önüne alınarak ÇPB'ye kabul edilerek desteklenmeleri bir hak ve ihtiyaçtır *(Schwantes, 2014)*. Bu dönemi evlerinde geçirmek isteyen aileler için evde ÇPB desteği verilmesi önemlidir. Bunun için mobil ekipler veya evde sağlık hizmetleri ekibi yeterliyse evde destek verilebilir. *(Harputluoğlu, 2020)*. Çocuğun ızdırap çekmesinin istenmediği, semptomlarla baş edemeyen ve evde bulunmaktan çekinen hastalar için hasta çocuk ve ailesinin ÇPB'ye yatışı yapılmalıdır.

Kendi Kendine Sevk: Dünyada hazırlanan rehberlere göre ÇPB uzman hekimleri kritik durumlar ve karmaşık klinik ikilemlerin varlığında, tedavi kesme, düzenleme veya tartışmalı konularda hastayı tekrar yatırıp (kendine sevk) değerlendirmek durumunda kalabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Pediyatrik Palyatif Bakım rehberinde ÇPB uzmanlığı tanımlanmıştır *(IMPACCT, 2013)*. ÇPB hekimleri zor kararlar ve kritik kararlar konusunda (yaşam sonu kararları) hastane "klinik etik kurullar" dan destek alabilmelidir *(Feudtner, 2014)*.

5.2. Çocuk Palyatif Bakımdan Taburculuk Kriterleri

Semptomların Stabilizasyonu: Çocuğun semptomları kontrol altına alındığında, evde bakımı sürdürülebilir olduğunda, ailenin bakım eğitimleri tamamlandığında, tedavilerin ve koşulların uygun olması durumunda çocuk taburcu edilir. Taburculuk sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar Tablo 3'te gösterilmiştir. *(IMPACCT, 2013; Chelazzi, 2023)*.

Uzun Süreli Bakıma Geçiş: Palyatif bakım servislerinden taburcu edilen ve servis sorumlu tabibi tarafından evde izleme uygun görülen hastalar için bireyselleştirilmiş bakım planı oluşturularak ESH birimi ve aile hekimliği ile elektronik ortamda paylaşılır ve izlem süreci başlatılır. Taburculuğu takiben ilk ev değerlendirmesi ESH birimi tarafından en geç üç gün içinde gerçekleştirilir. Yapılan tüm işlemler elektronik hasta kaydına işlenir ve düzenli olarak aile hekimliği ve palyatif bakım ve ESH koordinasyon birimi ile paylaşılır. Hastaneler bünyesinde "Palyatif bakım ve evde sağlık hizmeti koordinasyon birimi" ve "Palyatif bakım polikliniği" kurulmaktadır. Özellikle "Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi-ESKOM" ile elektronik bilgi sistemleri entegrasyonu bulunan bu koordinasyon birimleri sayesinde; evde sağlık hastalarının palyatif bakım servislerine yatırılması ve palyatif bakım servislerinden taburcu olan hastaların Evde Sağlık Hizmet Birimi ya da aile hekimlerine yönlendirilmesi koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

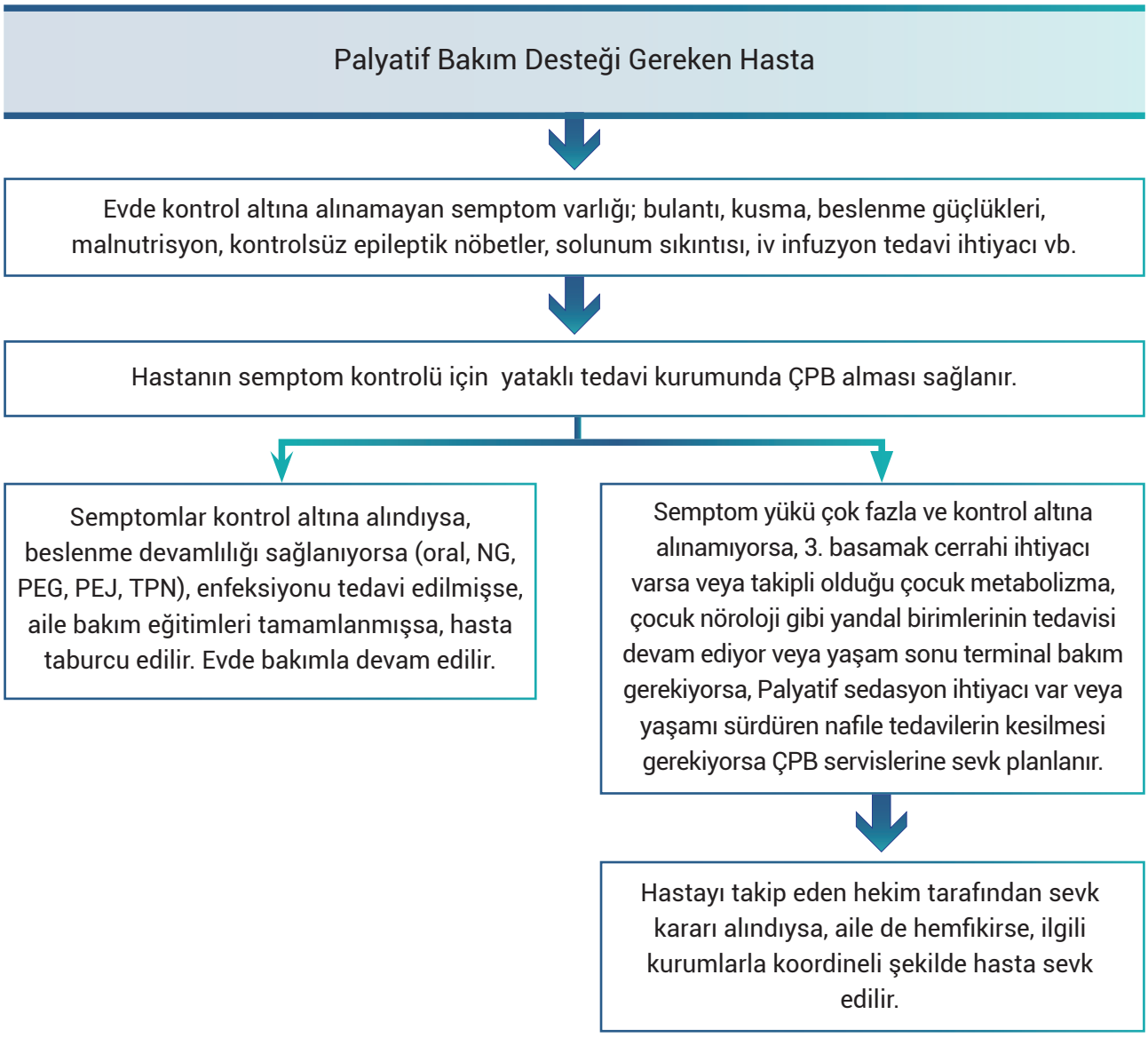
Tablo 3. Taburculuk Esnasında Yapılacaklar

Taburculukta Lütfen Kontrol Edin
Anne-baba veya bakım veren eğitimleri tamamlanmış mı, kontrol edin.
Hastanın eksik malzemesi var mı, evde bakım için gerekli olan tüm cihazları ve malzemeleri tamam mı (hastanın ihtiyacına göre, oksijen konsantratörü, aspirasyon cihazı, nabız oksimetre, pulsoksimetre, oksijen tüpü vb.) kontrol edin.
Hastanın beslenme şeklini, aralıklarını ve miktarını aldığı su ile birlikte not edin.
Tüple beslenen hastanın özel tıbbi amaçlı gıda (ÖTAG) raporunu kontrol edin. Tüple besleniyorsa özel tıbbi amaçlı gıda raporu çıkarılmış mı, raporu hastanın beslenme şekli ve miktarı ile uyumlu mu kontrol edin.
Hastanın sürekli kullandığı ilaçlarını ve kullanım şekillerini dozlarıyla birlikte not edin.
Sürekli kullandığı ilaçların raporu çıkarılmış mı, dozu uyumlu mu? Eksik raporları tamamlayın.
Hastanın trakeostomisi varsa en son kanül değişim tarihi ve değişim sırasında veya sonrasında komplikasyon olmuş mu, not edin.
Hastanın gastrostomisi varsa gastrostominin türünü (PEG, Nissen+gastrostomi veya cerrahi gastrostomi) ve son gastrostomi tüpü değişim tarihini not edin.
Hasta ev tipi mekanik ventilatörde izleniyorsa, ventilasyon modunu ve son parametre ayarlarını not edin.
Hastanın eksik aşıları var mı, özel durumlarda aşılama açısından hastanın planı yapıldı mı, kontrol edip taburculuk önerilerine ekleyin.
Acil durumlar ve evde bakım bilgilendirilmesi yapılmış mı, kontrol edin ve evde bakım kayıt ve randevu telefonunu tekrar hatırlatıp epikriz sonuna ekleyin.

5.3. Palyatif Bakım Servislerine Sevk Kriterleri

Palyatif bakıma yatış gerekliliği; semptom kontrolünün evde veya ayaktan bakım ile sağlanamaması, terminal dönem bakım ihtiyacının ortaya çıkması ya da sosyal ve fiziksel şartların evde bakımın sürdürülmesine imkân vermemesi durumunda hastanın tıbbi özgeçmişi ve güncel klinik durumu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Hastanın tanıları, hastalık evresi, semptom kontrol düzeyi, fonksiyonel durumu, e-Nabız üzerinden verileri, sosyal şartları ve bakım verenin desteği birlikte değerlendirilerek palyatif bakım sorumlu tabibi tarafından servise kabul/yatış işlemleri gerçekleştirilir. Hastanın klinik durumu, yaşam kalitesi beklentileri ile hasta veya yakınının tercihleri dikkate alınarak bakım hedefleri belirlenir. Bu kapsamdaki görüşmeler yüz yüze veya gerekli hâllerde uzaktan sağlık hizmeti yoluyla yapılır. Belirlenen bakım hedefi ve bireyselleştirilmiş bakım planı hakkında hasta ve yakınına bilgilendirme yapılarak rıza alınır ve kaydedilerek ilgili birimlere elektronik ortamda bildirilir.

Algoritma 1. Yatış, Sevk ve Taburculuk Kriterleri



Kaynakça

Bergstraesser, E., Hain, R. D., & Pereira, J. L. (2013). The development of an instrument that can identify children with palliative care needs: the Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale): a qualitative study approach. BMC palliative care, 12, 1-14.

Carney, K.M.B., Googrich, G., Lao, A., Tan, Z., Kiza, A.H., Con g, X., Hinderer, K.A. (2023). Palliative care referral criteria and application in pediyatric illness care: A scoping review, Palliat Med, 37(5), 692-706.

Chelazzi, C., Villa, G., Lanini, I., Romagnoli, S., Latronica N. (2023). The adult and pediyatric palliative care: differences and shared issues. J Anesth Analg Crit Care. 3, 1.

European Convention on Human Rights, ETS No. 5. "Convention on Human Rights and Biomedicine" (ETS No. 164) .

Feudtner, C., Nathanson, P.G. (2014). Pediyatric Palliative Care and Pediyatric Medical Ethics: Opportunities and Challenges. Pediyatrics, 133(1), 1-7.

Fraser, L.K., Lidstone, V., Miller, M., Aldridge, J., Norman, P., McKinney, Parslow, R.C. (2014). Patterns of diagnoses among children and young adults with life-limiting conditions: a secondary analysis of a national dataset. Palliat Med, 2014, 28(6), 513–520.

Harputluoğlu, N., Çelik, T., Karaaslan, U.Ü, Uysal, S. (2020). The Importance of Collaboration of the Home Health Care Unit and Pediyatric Palliative Care Unit in Children. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 8, 83-87.

Harputluoğlu, N., Yılmaz, Ü., Çelik, T. (2020). Pediatrik Palyatif Bakımda Etiyoloji:Tek Merkez Deneyimi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi. 10 (3), 245-250.

Harrop, E., Edwards, C. (2013). How and when to refer a child for specialist paediatric palliative care. Arch Dis Child Educ Pract Ed, 98(6):202.

IMPACCT. (2013). Pediyatric Palliative Care and Hospice Care Commitments, Guidelines, and Recommendations Section on Hospice and Palliative Medicine And Committee on Hospital Care. Pediyatrics, 132, 966-72.

Lazzarin, P., Giacomelli, L., Terrenato, I., Benini, F., & ACCAPED Study Group. (2021). A tool for the evaluation of clinical needs and eligibility to pediyatric palliative care: the validation of the ACCAPED scale. J Palliat Med, 24(2), 205-210

Lyon, M.E,, Jacobs. S., Briggs, L., Cheng, Y.I., Wang, J. (2013). Family-centered advance care planning for teens with cancer. JAMA Pediatr, 167, 460–467.

Schwantes, S., O'Brien, H.W. (2014). Pediyatric palliative care for children with complex chronic medical conditions. Pediatr Clin North Am, 61(4), 797-821.

Wood, F., Simpson, S., Barnes, E., Hain, R. (2010). Disease trajectories and ACT/RCPCH categories in paediatric palliative care. Palliat Med, 24(8), 796–806.

World Health Organization. Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for health-care planners, implementers and managers. 2018.

World Health Organization. Sıxty-Seventh World Health Assembly. 2014; https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC1/A67_2014_REC1-en.pdf

6. AĞRI VE SEMPTOM YÖNETİMİ

Çocuk palyatif bakım (ÇPB), yaşamı tehdit eden ya da yaşam süresini sınırlayan hastalıklara sahip çocukların bütüncül bakım ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Semptom ve ağrı yönetimi, çocukların yaşam kalitesini artırma ve hastalığın seyrine bağlı gelişen semptomları azaltma sürecinde temel bileşenlerden biridir *(Feudtner vd., 2011)*. Çocuk hastalarda semptomlar çok boyutlu olup, hem çocukların hem de ailelerinin psikolojik ve sosyal durumlarını etkileyebilir.

Bu alanda Birleşik Krallık'ta kurulan "Together For Short Lives" derneğinin "Basic Symptom Control in Paediatric Palliative Care" *(Jassal, 2022)* adında yayınladığı kitapçığın 10. ve son baskısı ÇPB'de semptom yönetimi için kapsamlı bir kaynak sağlamakta ve tüm ilaçların dozları hakkında da ayrıntılı bilgi içermektedir.

6.1. Ağrı Yönetimi

Palyatif ve yaşam sonu bakım süreçlerinde, çocukluk çağında en sık karşılaşılan semptom ağrıdır *(Feudtner vd., 2011)*. Bu nedenle, ağrı kontrolü çocuk palyatif bakımın temel bir bileşeni olarak öne çıkar. Palyatif bakım çerçevesinde ağrı yönetimi bir insan hakkı olarak kabul edilmekte olup, bu alanda çalışan tüm profesyonellerin etkin bir ağrı yönetimi sağlaması ve güncel kaynaklara erişimi zorunludur *(Gwyther vd., 2009)*.

6.1.1. Ağrının Tanımı ve Sınıflandırılması

Ağrı, "gerçek ya da potansiyel doku hasarına bağlı olarak gelişen hoş olmayan bir duyusal ve duygusal deneyim" şeklinde tanımlanır *(Loeser & Treede, 2008)*. Bu tanım, ağrının yalnızca fiziksel hasarı değil, geniş bir yelpazede duygusal ve zihinsel bileşenleri de içerdiğini ortaya koyar *(Downing vd., 2015)*. Cicely Saunders'ın ortaya koyduğu "Bütünsel Ağrı" (total pain) kavramı ise ağrının fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi boyutlarını ele alır *(Richmond, 2005; Zernikow & Printz, 2022)*. Çocuk palyatif bakımda çocukların yaşadığı ağrılar genellikle hastalığın kendisinden, uygulanan tıbbi işlemlerden veya tedavi sürecinden kaynaklanır *(Downing vd., 2015)*. Ağrı, kökenine göre nosiseptif, nöropatik veya karma tip olarak sınıflandırılabilir. Nosiseptif ağrı, ağrı reseptörlerinin doğrudan uyarılması sonucu oluşur ve somatik ya da visseral olarak ikiye ayrılır. Somatik ağrı, deri, kas ya da kemik dokusunda meydana gelir ve belirgin bir şekilde lokalize edilebilir. Visseral ağrı ise iç organ kaynaklı olup daha geniş veya derin hissedilen, lokalizasyonu zor bir ağrı türüdür *(Yağcı & Saygin, 2019)*. Sinir dokusundaki yapısal bir bozukluktan kaynaklanan nöropatik ağrı ise yanma, hipoestezi, dizestezi, hiperaljezi ve allodini gibi kendine has belirtilerle ortaya çıkar. Farklı ağrı türleri, farklı tedavi yaklaşımları gerektirdiğinden ağrının kaynağının doğru tespiti önemlidir. Sebebi belirlenemeyen ağrılar ise idiyopatik olarak adlandırılır. Ağrı süresine göre akut ya da kronik olarak da sınıflandırılabilir; üç aydan uzun süren ağrılar kronik kabul edilir *(Öztek Çelebi & Zernikow, 2021; Yağcı & Saygin, 2019)*.

6.1.2. Çocuk Palyatif Bakımda Yaygın Görülen Ağrı Türleri

Pediyatrik onkoloji hastalarında ağrı, çoğunlukla ağrılı müdahaleler ve mukozit gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkar *(Zernikow & Printz, 2022)*. Ayrıca amputasyon sonrası hayalet ağrı, kemik ya da sinir dokusu infiltrasyonları veya siklosporin gibi ilaçların yan etkilerine bağlı gelişen nöropatik ağrı da gözlemlenir. Kemik iliği nakli sonrası oluşan yanık benzeri cilt hasarları, veno-oklüzif hastalığa bağlı karaciğer kapsül ağrısı, Graft-versus-Host hastalığı sırasında meydana gelen ağrılar ve akciğer metastazı olanlarda görülen göğüs ağrıları gibi tümörle ilişkili ağrı sendromları detaylı bir öykü alınmasını gerektirir *(Zernikow & Printz, 2022)*.

Kanser dışında yaşamı sınırlayan hastalıkları olan çocuklarda ağrı nedenleri oldukça çeşitlidir. Özellikle ifade edemeyen çocuklar için Tablo 4'te yer alan nedenler göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır çoklu engeli olan çocuklarda sıklıkla kronik reflü ve uzun süreli post-operatif ağrılar gözlemlenir.

Tablo 4. Non-Onkolojik Yaşamı Sınırlayan Hastalıklarda Çocuklarda Görülen Ağrı Nedenleri

Ağrı Yeri	Etyoloji	Klinik İpuçları
Baş	SSS enfeksiyonları	Meningismus, ateş, nörolojik belirtiler
	Artmış kafa içi basınç	Baş ağrısı, kusma, bilinç değişiklikleri, bradikardi
	Primer baş ağrısı: – Migren – Epizodik sendromlar – Trigemino-otonomik baş ağrısı	Her durumun kendine özgü semptomları vardır.
	Trigeminal nevralji (basıya bağlı primer/klasik, MS gibi mevcut altta yatan hastalığa, yer kaplayan lezyonlara sekonder)	Trigeminal sinirin beslediği bölgede, saniyeler ila dakikalar arasında, atak benzeri şiddetli, paroksismal tek taraflı yüz ağrısı atakları
Göz	Konjunktivit, kornea yaralanması, orbital selülit	Kızarıklık, artmış gözyaşı
Kulak/Burun/Boğaz ve Diş:	– Enfeksiyonlar (otit, mastoidit, mukozit, stomatit, tonsilit, oral kandidiyazis) – Diş çürükleri ve zor diş çıkarma	Ağrı ve inflamasyon bulguları
Göğüs	Plevra ağrısı (enfeksiyöz)	Nefes alırken veya hareketle ağrı, nefes darlığı
Karın	Gastroözofageal reflü, gastrit/özofajit	Ağrılı geğirme, kusma, gıda alımıyla ilişkili epigastrik ağrı, gastrointestinal kanama
	Konstipasyon	Azalmış dışkılama sıklığı, batın distansiyonu
	İleus, volvulus, invajinasyon	Şiddetli karın ağrısı, batın distansiyonu, kusma
	Apandisit	Karın ağrısı, kusma, ateş
	Safra taşı, pankreatit	Ani başlayan şiddetli üst kadran ağrısı, mide bulantısı, kusma
	Sistit, piyelonefrit	Sık idrara çıkma, idrarda yanma, yan ağrısı, ateş
	Böbrek taşları	Hematüri
	Anogenital enfeksiyon ve yaralanmalar	Ağrı, kızarıklık, yaralanma
Kas-İskelet	Artrit, spastisite, kontraktürler, skolyoz, kalça dislokasyonu, patolojik kırıklar/osteoporoz	Hareket ve taşıma sırasındaki ağrı
Cilt/Cilt Altı	– Uygun olmayan yatak/materyal (uygunsuz sabitleme, yardımcı araçlar, alçı) – Cilt enfeksiyonları – Cihazların giriş yerlerindeki inflamasyon	Bası yaraları, tekerlekli sandalyede/ortezde geçirilen zamana bağlı ağrı

Kaynak: Zernikow & Printz, 2022.

6.1.3. Ağrının Değerlendirilmesi

Ağrıyı etkili bir şekilde yönetebilmek için öncelikle iyi bir öykü alma ve fizik muayene ile ağrının doğru değerlendirilmesi gerekmektedir *(Öztek Çelebi & Zernikow, 2021)*. Detaylı ağrı öyküsü ve fizik muayene ile ağrının kaynağı belirlenir; ayrıca yaşa uygun bir değerlendirme aracı ile ağrının şiddeti ölçülmelidir. Çocuklar öz değerlendirme yapabiliyorsa tercih edilir, ancak her çocuğun bunu gerçekleştirecek bilişsel ve dil becerisi olmayabilir. Bu durumda davranışsal gözlem ölçekleri devreye girer. Türkiye'de çocuklarda yaygın olarak Gözden Geçirilmiş Yüzler Ağrı Ölçeği, Wong Baker Yüzler Ağrı Ölçeği, Görsel Analog Skala ve FLACC ölçekleri kullanılmaktadır. Yenidoğanlarda ise N-PASS ve PIPP gibi ölçekler tercih edilir *(Hicks vd., 2001; Garra vd., 2013; Voepel-Lewis vd., 1997)*.

6.1.4. Ağrının Non-Farmakolojik Yönetimi

Pediyatrik ağrı kontrolünde, ilaçsız yöntemler oldukça önemli bir yer tutar. Çocuklarda etkin bir ağrı yönetimi için uygun analjezi sağlanırken sedasyonun aşırıya kaçmaması gerekir. Bunun için, non-opioid ve opioid analjezikler ile yardımcı ilaçlar anestezik müdahalelerle bütüncül terapiler şeklinde entegre edilir. Bu yaklaşımlar, ilaçsız teknikler olarak rehberli hayal kurma, hipnoz, karın solunumu ve dikkat dağıtma gibi bilişsel davranışsal yöntemler ile kucaklama, masaj, TENS, pozisyonlama, sıcak-soğuk uygulama ve aromaterapi gibi fiziksel yöntemleri içerir. Ayrıca gevşeme, meditasyon, yoga, biofeedback, grup desteği gibi çeşitli tamamlayıcı terapiler de çocuklarda ağrıyı azaltmak amacıyla kullanılmaktadır *(Downing vd., 2015)*.

6.1.5. Ağrının Farmakolojik Yönetimi

Çocuklarda ağrıyı hafifletmede en yaygın ve etkili yol ilaç tedavisidir. Bu tedavide kullanılan ilaçlar; non-opioid analjezikler, opioid analjezikler ve destekleyici ilaçlar olarak sınıflandırılır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kanser hastalarında uygun ağrı yönetimini sağlamak amacıyla 1986 yılında analjezi merdiveni modelini tanıtmıştır *(WHO, 1996)*. DSÖ'nün analjezi merdiveni modelinin üç temel prensibi vardır: ilaçların düzenli olarak, belirli aralıklarla, ağız yolundan verilmesi ve gerektiğinde basamaklara uygun olarak doz ayarlaması yapılması *(Anekar vd., 2023)*. Çocuklarda ise bu merdiveni zayıf opioidleri kaldırarak iki basamaklı bir sistem olarak düzenlemiştir *(Afshan & Bashir, 2014)*. Bu iki basamaklı model bazı uzmanlar tarafından desteklenirken, diğerleri tarafından eleştirilmektedir *(Downing vd., 2015; Zernikow & Printz, 2022)*. Ayrıca DSÖ Kılavuz Geliştirme Grubu, çocuklarda kodeinin güvenliğine dair yeterli kanıt bulunmadığını vurgulamaktadır. Bazı ülkelerde tramadol, 12 yaş altındaki çocuklar için onaylanmamıştır ve güvenilirlik verileri sınırlıdır. İki basamaklı sistemi tercih eden uzmanlar, çocuklarda kodein ya da tramadol yerine morfinin daha etkili bir ağrı yönetimi sağladığını savunmaktadır *(Downing vd., 2015)*.

6.1.5.1. Çocuklarda Farmakolojik Ağrı Tedavisinin Temel İlkeleri

a. Analjezik seçiminde DSÖ'nün basamak modeli dikkate alınmalı, erken dönemde opioidler kullanılmaya başlanmalıdır.
b. Engelli çocuklar, yenidoğanlar ve bebekler opioid tedavisine başlarken daha düşük dozlar almalıdır.
c. Belirli ağrı sendromları (örneğin kemik ağrıları) için opioid ve non-opioid analjezik kombinasyonları etkili olabilir. Analjezik tercihi, ağrının patofizyolojisi ve olası yan etkiler dikkate alınarak yapılmalıdır.
d. Oral uygulama tercih edilmelidir, çünkü bu yol hem güvenli hem de esnektir. En şiddetli ağrılar bile ağız yolundan tedavi edilebilir; kas içi enjeksiyonlardan kaçınılmalı, gerekirse intranazal veya transdermal yollar tercih edilmelidir.
e. Analjezikler belirli aralıklarla, gerektiğinde ise kaçak ağrılar için ek dozlar halinde verilmelidir.
f. Opioid kullanımının sık rastlanan yan etkilerinden kabızlık için önleyici tedavi sağlanmalıdır. Diğer yan etkiler de öngörülerek hızlı ve uygun müdahaleler yapılmalıdır.
g. Etkili bir ağrı yönetimi için tedavinin etkinliği ve yan etkileri yazılı olarak kaydedilmelidir.

(Zernikow & Printz, 2022)

6.1.5.2. Çocuklarda Ağrı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

6.1.5.2.1. Non-opioidler

Parasetamol: Çocuklarda yaygın ve güvenilir bir analjezik ve antipiretik olarak kullanılan parasetamol, yenidoğan döneminden itibaren uygulanabilir *(Cuzzolin vd., 2013)*. Trombosit işlevini etkilemez, antiinflamatuar etkisi yoktur; gastrointestinal hasar nadiren görülür. Ancak uzun süreli kullanımda, özellikle 72 saat sonrasında dozun azaltılması önemlidir, çünkü hepatotoksisite riski vardır. Detaylı doz bilgisi Tablo 6'da sunulmuştur.

Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar: Parasetamolden daha güçlü antiinflamatuar etkisi olan bu grup ilaçlarda çocuklar için en sık ibuprofen tercih edilir. Gastrointestinal mukoza üzerindeki yan etkileri sık görülür ve nefrotoksisite riski taşır. Kanama riskini artırabilir. Yaşamın ilk 3-6 ayında önerilmez *(Zernikow & Printz, 2022)*. Doz ve kullanım bilgileri Tablo 6'da bulunmaktadır.

6.1.5.2.2. Opioidler

DSÖ temel sağlık ihtiyaçları için vazgeçilmez sayılan kodein, morfin, fentanil, metadon ve loperamidi Temel İlaçlar Listesi'ne dâhil etmiştir *(WHO, 2017)*. Türkiye'de opioid kullanımı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşüktür *(Scholten vd., 2020)*. Opioidlerin kullanımı sırasında yan etkileri izlenmelidir. En önemli yan etkileri:

a. ***Kabızlık:*** Opioid kullanımının en sık rastlanan yan etkisidir ve profilaktik olarak tedavi gerektirir.

b. ***Bulantı-Kusma:*** Başlangıçta sık görülen bu yan etkiye karşı antiemetik (ondansetron gibi) ilaçlar faydalı olabilir.

c. ***Kaşıntı:*** Sık görülen bir yan etki olup, gerekirse farklı bir opioid tedavisine geçilebilir *(Ganesh & Maxwell, 2007).*

d. ***İdrar Retansiyonu:*** Nadir görülür; mesaneye ılık kompres veya kateterizasyon gerekebilir.

e. ***Solunum Depresyonu:*** Nadir fakat ciddi bir yan etki olup naloxon ile müdahale edilmesi gerekebilir.

f. ***Miyoklonus:*** Yüksek dozlarda oluşur; benzodiazepinlerle veya opioid rotasyonu ile tedavi edilir.

g. ***Fizyolojik veya psikolojik bağımlılık:*** Opioidlerle etkili ağrı yönetimindeki önemli engellerden biri bağımlılık korkusudur. Tolerans, opioidin sürekli kullanımıyla etkisinin azalmasıdır; hastalar aynı etkiyi elde etmek için giderek daha yüksek dozlara ihtiyaç duyar. Ancak sedasyon ve solunum depresyonuna karşı tolerans, ağrı kesici etkiye kıyasla daha hızlı gelişir, bu yüzden yüksek dozlarda bile aşırı sedasyon veya solunum depresyonu riski düşüktür. Yoksunluk opiodin aniden kesilmesi veya dozunun azaltılması durumunda ortaya çıkar. Yoksunluk sendromu, sinirlilik, huzursuzluk, otonom uyarılma, burun tıkanıklığı, piloereksiyon, ishal ve jitternes ile karakterizedir; bu durum, güçlü opioidlerin >5-7 gün süreyle uygulanmasıyla ortaya çıkar. Bağımlılık, bir psikiyatrik patoloji olup, psikolojik istek, kompulsif ilaç arama davranışı ve tıbbi zarara rağmen ilaç kullanımını ifade eder. Tıbbi nedenlerle opioidlerle tedavi edilen çocuklar üzerine yapılan araştırmalar madde kötüye kullanımı geliştirme riskinde bir artış olmadığını bulmuştur *(Zeltzer, 2020).*

Zayıf Etkili Opioidler

Tramadol gibi zayıf etkili opioidlerin kullanımı çocuklarda bazı tartışmalara konu olmaktadır. Kodeinin çocukluk yaş grubunda güvenli olmadığı konusunda fikir birliği mevcuttur.

Tramadol, opioid reseptörleri üzerinde saf etki gösteren bir agonisttir ve analjezik etkisini serotonin salınımını artırarak ve noradrenalinin sinir hücrelerine geri alımını engelleyerek sağlar. Çocuklarda tramadol kullanımı, bulantı, kusma ve solunum depresyonu gibi yan etkilere nadiren yol açar. Ancak, konvülzyon riskini artırdığı bilinmektedir *(Zernikow & Printz, 2022).* Tramadol, Türkiye'de damla, kapsül, tablet ve intravenöz formda bulunmaktadır. Detaylı doz bilgileri Tablo 6'da sunulmuştur.

Güçlü Etkili Opioidler

ÇPB'de, özellikle ileri evre hastalarda güçlü opioidler ilk tercihler arasındadır. Bu dönemdeki çocukların %75-96'sında opioid tedavisi uygulanmaktadır; en yaygın kullanılan opioid ise

morfindir. Altı aylıktan küçük bebeklerde ve serebral hasarlı çocuklarda tedaviye önerilen dozun 1/3 veya 1/4'ü ile başlanmalıdır. Güçlü opioidlerin 5 günden fazla süren kullanımı sonrası, ilacın dozu kademeli olarak 3-4 gün içinde azaltılmalıdır. Daha uzun süreli kullanımda ise önce günlük %20-40, ardından %5-20 oranında azaltılmalıdır. Çekilme belirtileri gözlenirse doz azaltma süreci geçici olarak durdurulmalıdır.

Morfin: Çocuklarda güvenle kullanılabilen, kolay erişilebilen bir güçlü opioiddir *(Downing vd., 2015)*. Morfin için üst bir doz sınırı bulunmamaktadır; ağrıyı kesen doz etkin dozdur. Türkiye'de morfin, intravenöz, intramusküler, tablet ve uzun salınımlı tablet formunda bulunur. Oral biyoyararlanımı intravenöz forma göre daha düşüktür (%30). Böbrek yetmezliği durumunda, morfin ve metabolitlerinin böbreklerden atılımı yavaşlayabilir ve merkezi sinir sistemi yan etkileri görülebilir. Uzun salınımlı tabletlerin mekanik olarak bölünmesi önerilmez; kullanım bilgileri Tablo 5'te bulunmaktadır.

Fentanil: Morfinden yaklaşık 100 kat daha güçlü olan fentanil, intravenöz ve transdermal formlarda çocuklar için sıklıkla tercih edilir. İğneli işlemler için intravenöz formu uygunken, transdermal formu 2 yaş üstü çocuklarda stabil ağrı tedavisi için kullanılır. En küçük dozu 12,5 µg/saat olan fentanil transdermal forma geçişte, minimum günlük oral morfin eşdeğer dozu 30 mg/gün gereklidir. Transdermal form, etkisini 12 saat sonra gösterip 48 saat devam eder. Ateş, fentanilin salınım hızını artırarak daha yüksek kan düzeylerine yol açabilir. Transdermal fentanil kullanan hastalarda ekstra ağrılar için morfin veya diğer fentanil formları kullanılabilir.

Morfin ve fentanil dışında hidromorfon, oksikodon, piritramid, metadon, levometadon, petidin ve buprenorfin gibi opioid türleri de mevcut olup, DSÖ bu ilaçların çocuklarda kullanımı konusunda temkinli yaklaşmaktadır *(WHO, 2020)*.

Tablo 5. Çocuk Palyatif Bakımda Sık Kullanılan Analjezik İlaçların Dozları

İlaç adı	Uygulama yolu	Doz	Uygulama Sıklığı	Maksimum Doz
Parasetamol	Oral	15 mg/kg (max 500 mg)	4-6 saatte bir	<2 yaş 60 mg/kg/gün >2 yaş 90 mg/kg/gün
	IV	15 mg/kg (max 500 mg)	6 saatte bir	<1 yaş 30 mg/kg/gün >1 yaş 60 mg/kg/gün
İbuprofen	Oral	10 mg/kg (max 400 mg)	6-8 saatte bir	40 mg/kg/gün
Tramadol	Oral	1 mg/kg (max. 50 mg)	4-6 saatte bir	
	İv/bolus İv/devamli infüzyon	1 mg/kg (max. 50 mg) 0,3 mg/kg/saat(max 10mg/saat)	4-6 saatte bir	
Morfin	Oral	0,2 mg/kg (max 5mg)	4 saatte bir	
	İv/Bolus İv/devamlı infüzyon	0,05 mg/kg (max 3 mg) 0,02 mg/kg/h (max 0,5 mg/h)	3 saatte bir	

Kaynak: (Zernikow & Printz, 2022)

6.1.5.2.3. Yardımcı Analjezik Ajanlar

DSÖ, analjezi merdiveninin tüm aşamalarında yardımcı analjeziklerin kullanımını desteklemektedir. ÇPB'de özellikle uykusuzluk, anksiyete ve belirli ağrı sendromları yaygındır. Bu durumlar için önerilen bazı ilaçlar şunlardır:

Trisiklik Antidepresanlar: Yanıcı özellikteki nöropatik ağrı, hayalet ağrı ve diğer kronik ağrı durumlarında etkilidir. Aynı zamanda ağrıya bağlı uyku problemlerinde de kullanılabilir.

Benzodiazepinler: Şiddetli uyku bozuklukları, epileptik nöbetler, anksiyete ve nefes darlığı durumlarında uygulanabilir.

Nöroleptikler: Özellikle ciddi dispne veya sedasyon gerektiren durumlarda etkilidir.

Antikonvülsanlar: Gabapentin ve pregabalin, nöropatik ağrı tedavisinde kullanılır. Ayrıca, şiddetli distoni, visseral hiperaljezi veya özel ağrı davranışları gösteren ağır engelli çocuklar için uygundur. Trisiklik antidepresanlarla birlikte kombinasyon yapılabilir; karbamazepin trigeminal nevralji tedavisinde de etkilidir.

Glukokortikosteroidler: Deksametazon, intrakranial basınç artışı, bulantı-kusma, tümör infiltrasyonu, spinal bası, sinir sıkışması, kemik metastazları ve karaciğer kapsül ağrısı gibi durumlar için kullanılabilir.

Ketamin: Çeşitli ağrı türlerinde, nöropatik ağrı dâhil olmak üzere, etkili bir analjeziktir. Opioid tedavisine destek olarak da kullanılabilir. Ülkemizde intravenöz formda mevcuttur.

ÇPB'de ağrı, yönetimi en öncelikli semptomlardan biridir. Hastaların acısını azaltmak için etkili bir ağrı tedavisi sağlanması, ilaçlara erişim kolaylığı ve ağrıya bütüncül bir yaklaşımla mümkündür. Çocuklarda genellikle ilk basamak tedavisi yeterli olur. Ancak orta ve şiddetli ağrısı olan çocuklarda opioidlere (fentanil, morfin) geçilebilir. Opioidler her çocukta ayrı olarak titre edilerek kullanılmalıdır. Bazen ikili veya üçlü kombinasyon gerekebilir. Her bir çocuk için tedavi kişiselleştirilmelidir.

6.2. Semptom Yönetimi

6.2.1. Solunum Sistemi Problemleri ve Yönetimi

Palyatif bakımda pek çok hastalık solunum sorunlarına yol açabilir ve bu sorunlar arasında en önemlileri solunum yetmezliği ve dispnedir.

6.2.1.1. Solunum Yetmezliği ve Tedavisi

Solunum sistemi, gaz alışverişini sağlayan akciğerler ve akciğerleri ventile eden solunum pompası olmak üzere iki temel anatomik bileşenden oluşur. Solunum pompası, göğüs duvarı, solunum kasları, merkezi sinir sistemi (MSS) ve bu sistemden gelen sinyalleri ileten spinal kord ve periferik sinirler tarafından kontrol edilir. Kistik fibrozis, bronkopulmoner displazi gibi akciğeri etkileyen hastalıklar veya musküler distrofiler, spinal musküler atrofi gibi nöromusküler hastalıklar, hidrosefali ve beyin tümörleri gibi MSS sorunları çocuklarda kronik solunum yetmezliğine yol açabilir. Tedaviye başlamadan önce, altta yatan tedavi edilebilir nedenler tedavi edilmelidir. Hipoksemi ve hiperkarbisi olan hastalar evde uzun süreli oksijen tedavisi veya mekanik ventilasyon (MV) desteği açısından değerlendirilir; pulmoner rehabilitasyon bu süreçte destekleyici olabilir.

Solunum yetmezliğinde ilk basamak oksijen desteğidir, çünkü hipoksemi hiperkarbiye kıyasla daha tehlikelidir. Nazal kanüllerle küçük çocuklara 2 lt/dk'ya kadar, büyük çocuklara ise 4 lt/dk'ya kadar oksijen verilebilir. Oksijen tedavisi sırasında sekresyonları biriktirme riskine karşı kanüllerin sık sık temizlenmesi önemlidir. Basit yüz maskeleri ile 5-10 lt/dk oksijen sağlanabilirken, rezervuarlı maskeler daha yüksek oksijen konsantrasyonu sağlar. Yüksek oksijen konsantrasyonu (FiO_2 >0,5) verilirken oksijen toksisitesi, absorpsiyon atelektazisi ve silia fonksiyon bozukluğu gibi yan etkiler açısından dikkatli olunmalıdır.

Kronik solunum yetmezliği olan çocuklarda evde mekanik ventilasyon (MV) önemli bir tedavi seçeneğidir. Aile bireylerinin ventilatör ve trakeostomi bakımı, acil durumlarda müdahale gibi konularda eğitim alması gerekir. Evde kullanılan MV, invaziv veya noninvaziv olarak uygulanabilir.

Noninvaziv MV (NİMV): Endotrakeal tüp veya trakeostomiye gerek kalmadan yapılan ventilasyon olup, hasta konforu yüksek ve komplikasyon riski düşüktür. İki seviyeli pozitif hava yolu basıncı (BiPAP) ile uygulama yaygındır ve hastanın solunumuna göre otomatik ayarlanabilir. BiPAP

uygulamalarında üç ana mod vardır: BİPAP S (spontan), hastanın nefes alımına uyum sağlar ve solunum kontrolü sorunu olmayanlarda tercih edilir. BİPAP S/T (spontan/zaman ayarlı), belirlenen solunum hızının altına düşüldüğünde devreye girerek solunumu destekler ve apne yaşayan hastalar için uygundur. BİPAP T (tam zaman ayarlı) ise nadir kullanılır ve tüm solunumu cihaz kontrol eder, ileri solunum desteği gereken durumlarda tercih edilir. Obstrüktif uyku apne sendromu gibi durumlarda sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) uygulanarak akciğer hacmi ve oksijenasyon arttırılabilir. NİMV, spontan solunumu olmayan veya ağır GİS kanamaları gibi risk faktörleri taşıyan hastalar için uygun değildir.

İnvaziv MV: Noninvaziv MV'nin yetersiz kaldığı veya uzun süreli (>16-20 saat/gün) ventilasyon gerektiği durumlarda tercih edilir. Trakeostomi aracılığıyla uygulanan pozitif basınçlı ventilasyonla sağlanır ve en sık SIMV (senkronize aralıklı zorunlu solunum) modu kullanılır. Bu mod, hastanın spontan solunum çabasını destekleyen bir özellik taşır. Evde kullanılan ventilatörler, hastane ventilatörleri kadar yüksek gaz akımı sağlayamayabilir; bu nedenle, evdeki destek hastanedeki ile aynı olmayabilir.

Kronik Solunum Yetmezliği Olan Çocukların Evde İzlemi: Evde MV'nin amacı, solunum desteği sağlamak, çocukların yaşam kalitesini iyileştirmek ve büyüme ile gelişmelerini desteklemektir. Uzun dönem hayatta kalım oranları altta yatan hastalığa göre değişiklik gösterir. Trakeostomi ile eve taburcu olan hastalar, trakeostomi bakımı, sekresyon temizliği ve olası komplikasyonlara müdahale konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca, bu hastalar yutma, beslenme ve hastalığın durumu açısından düzenli olarak izlenmelidir. Hastaneden taburcu edilen çocukların ailesi sürekli iletişimde olmalı, kontrollerde ventilatör ayarları güncellenmelidir. Pulmoner hipertansiyon riski nedeniyle her 6-12 ayda bir ekokardiyografi ile takip edilmelidir *(Oktem, vd., 2008; Onay & Şişmanlar Eyüpoğlu, 2021)*.

Trakeostomi bakımı detayları aile bakım eğitimi bölümünde anlatılmıştır.

6.2.1.2. Dispne

Dispne, hastaların nefes darlığı hissini tanımlayan subjektif bir algıdır ve yalnızca solunum hızının artışı ya da oksijen satürasyonunun düşmesiyle belirlenemez. Bu nedenle, dispne yaşayan çocuklar genellikle nefes almakta zorlandıklarını, hava açlığı hissettiklerini, kısa kısa nefes aldıklarını ya da göğüslerinde baskı olduğunu belirtirler. Dispne, konuşma, giyinme ve yürüme gibi fiziksel aktivitelerle kötüleşebilir; ancak aynı zamanda korku, üzüntü gibi duygusal stresler de nefes darlığı hissini artırabilir. Dispne algısı nörobiyolojik olarak ağrıya benzer ve bu yüzden, özellikle palyatif bakımda biyopsikososyal bir yaklaşım ile değerlendirilmelidir. Palyatif bakımda dispne, özellikle kistik fibrozis, kas atrofileri, ciddi skolyoz gibi solunumu kısıtlayan hastalıklarda önemli bir rol oynar. Kanserli çocukların %50-60'ında, hastalığın son ayında dispne gözlenir; bu durum, ebeveynler tarafından rahatsız edici bir semptom olarak tanımlanır. Dispneye yalnızca

pulmoner patolojiler değil, birçok sistemik faktör de neden olabilir. Anemi, korku, sıvı yüklenmesi, asit, hepatomegali, böbrek hasarı, enfeksiyon, kaşeksi, bronşit/bronşiolit/astım atakları, kas güçsüzlüğü, plevral veya perikardiyal efüzyonlar, ağrı, vena cava superior sendromu, koyu balgam veya sekresyon birikimi gibi durumlar dispneye yol açabilir. Bu nedenle, dispne tedavisinde her zaman altta yatan nedeni ele almak gerekir.

6.2.1.2.1. Dispne Tedavisinde Nedene Yönelik Yaklaşımlar

Enfeksiyon: Alt solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik ve antipiretik tedavi uygulanır; solunum yollarının açık tutulması için destekleyici bakım sağlanır.

Bronşit, Bronşiolit veya Astım Atakları: Wheezing ve uzamış ekspirasyon gibi belirtiler varsa bronkodilatörler (örneğin Salbutamol ve gerekirse İpratropium bromid) inhaler verilir; gerekirse kısa süreli kortikosteroidler eklenir.

Yoğun Sekresyonlar: Öksürük refleksi güçlü olan hastalarda solunum terapisi ve %0,9 NaCl inhalasyonu önerilir. Öksürük refleksi veya kas gücü zayıf olanlarda düzenli "Cough Assist" cihaz kullanımı sekresyonların temizlenmesine yardımcı olur.

Anemi: Solgunluk, yorgunluk, baş ağrısı veya taşikardi belirtileriyle kendini gösteren anemide eritrosit transfüzyonu yapılabilir.

Asit: Karın çevresinde genişleme ve dispne ile birlikte asit mevcutsa sıvı kısıtlaması, diüretik tedavi, tromboz profilaksisi ve antibiyotik profilaksisi uygulanabilir.

Bronş Obstrüksiyonu: Tümör invazyonuna bağlı hava yolu tıkanıklığında antineoplastik tedavi (kemoterapi veya radyoterapi) ya da stent uygulaması gerekebilir.

Plevral Efüzyon: Plevral ponksiyon bazı durumlarda yapılabilir ancak çocuklar için zor tolere edilebildiğinden nadiren tercih edilir. Malign plevral efüzyon durumunda torakoskopik plörodezis erişkin palyatif bakımında kullanılabilmektedir.

Sıvı Yüklenmesi: Sıvı kısıtlaması ve gerekirse diüretik verilmesi önerilir.

Pulmoner Emboli: Ani takipne, taşikardi, öksürük, göğüs ağrısı veya kanlı balgam gibi belirtiler pulmoner emboliyi düşündürebilir.

Perikardiyal Efüzyon: Otururken veya öne eğilince rahatlama, boyun venlerinde dolgunluk gibi belirtiler varsa ekokardiyografi yapılabilir. Gerektiğinde diüretik veya nadiren perikardiyal ponksiyon yapılabilir.

Vena Cava Superior Sendromu: Yüz veya kollarda şişlik, boyun venlerinin dolgunluğu ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, bir onkolojik acil kabul edilip, ödemi azaltmak için yüksek doz kortikosteroid ve radyoterapi ile tedavi edilebilir.

6.2.1.2.2. Destekleyici ve Psikolojik Müdahaleler

Dispne tedavisinde ilaç dışı müdahaleler, hemşirelik ve psikolojik yaklaşımlar önem taşır. Postural drenaj, göğüs duvarının mekanik titreşimi ve solunum eğitimi uygulanabilir. Çocuğun en rahat nefes aldığı pozisyonda yatması, odanın havalandırılması, oda sıcaklığının düşürülmesi, hava nemlendiricilerinin kullanılması ve sigara dumanından uzak tutulması gibi önlemler önemlidir. Hastanın yüzüne hava üfleyen el vantilatörü kullanmak rahatlama sağlar. Psikolojik rahatlama sağlamak için dikkat dağıtma teknikleri, diyafram solunumu ve imgeleme egzersizleri kullanılabilir. Anksiyete ve dispne arasındaki bağlantıyı azaltmak için bilişsel davranışçı terapi ve öz-hipnoz gibi yöntemler uygulanabilir.

6.2.1.2.3. Farmakolojik Tedavi

Opioidler: Dispne tedavisinde temel farmakolojik ajan olarak kullanılır. Opioidler nefes darlığını hafifletir, hiperkapni ve hipoksiye yanıtı azaltarak solunum işini düşürür ve oksijen tüketimini azaltır. Morfinin vazodilatasyon etkisi de kalp yetmezliği olan hastalara fayda sağlar. Ayrıca, anksiyolitik ve sedatif etkiler de gösterirler. En yaygın kullanılan opioid morfindir; gerektiğinde subkutan da uygulanabilir. Opioidlere yeni başlayan hastalar için başlangıç dozu, analjezik dozun dörtte biri olacak şekilde ayarlanır. Analjezik amaçla düzenli olarak opioid alan çocuklarda dispne ortaya çıktığında başlangıçta ek bolus veya kurtarma dozları verilir. Yeterli sonuç alınamazsa, ikinci sıradaki seçenekler (benzodiazepinler ve antipsikotikler) ek olarak uygulanır. Alternatif olarak, kriz durumlarında fentanilin intranazal, bukkal veya sublingual uygulaması yapılabilir.

Benzodiazepinler: Opioid tedavisine ek olarak, dispne kontrolünde midazolam, lorazepam veya diazepam gibi benzodiazepinler de sıkça tercih edilir. Midazolam intravenöz kullanılabilirken, yanak içi ya da dil altına da uygulanabilir. Çocuklarda, uygun ağırlığa göre lorazepam da alternatif olarak düşünülebilir. Tüm bu yöntemler, dispne yaşayan çocuklara konfor sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için bir arada da kullanılabilir *(Printz, vd., 2022)*.

6.2.2. Kas-İskelet Sistemi Problemleri ve Yönetimi

ÇPB'de, hastanın yaşam kalitesini iyileştirme ve mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürdürme hedeflerine ulaşmada fizyoterapinin önemli bir rolü vardır. Palyatif bakım altındaki çocuklarda sık görülen kas-iskelet sistemi sorunlarından aşağıda bahsedilmiştir.

6.2.2.1. Kas Güçsüzlüğü

Kas güçsüzlüğü, özellikle mekanik ventilatöre bağlı hastalarda yaygın bir sorundur. İmmobilite, uzun süreli ventilasyon, kortikosteroidler, nöromusküler blokörler ve sedatif ilaç kullanımı gibi faktörler kas zayıflığına neden olabilir. Bu çocuklar için bireysel bir egzersiz programı oluşturulmalıdır. Yaş, bilişsel durum, ek hastalıklar ve kondisyon dikkate alınarak kas güçsüzlüğünü azaltmaya yönelik güçlendirme, eklem hareket açıklığını koruma ve kondisyon artıran aerobik egzersizler önerilir. Kas güçsüzlüğünü

önlemek veya tedavi etmek amacıyla Nöromusküler Elektrik Stimulasyonu (NEMS) ya da Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu (FES) kullanılabilir *(Cankurtaran & Ünlü Akyüz, 2021; Komatz & Carter, 2015).*

6.2.2.2. Spastisite

Spastisite, kas tonusunda artışa neden olan bir durumdur ve üst motor nöron sendromunun bir parçası olarak ortaya çıkar. Palyatif bakımdaki çocuklarda serebral palsi, beyin travması ve hipoksik beyin hasarına bağlı olarak görülebilir. Spastisitenin olumsuz etkileri arasında hareket güçlüğü, postür bozuklukları, deformiteler, kontraktürler, basınç yaraları ve ağrı bulunur. Özellikle adduktor ve hamstring kaslarının artan tonusu oturma, perineal hijyen sağlama ve giyinmeyi zorlaştırır. Ancak artmış tonus, çocuğun bacaklarını dik tutmasını ve yer çekimine karşı duruşunu destekleyerek kemik yoğunluğunun korunmasına katkıda bulunabilir.

Spastisite tedavisi bireye göre uyarlanmalı ve spastisitenin hem olumlu hem olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Genel hedefler arasında tonusu azaltmak, eklem hareket açıklığını artırmak, ortez kullanımını kolaylaştırmak, kontraktür gelişimini önlemek, ağrı ve spazmı hafifletmek, rehabilitasyonu kolaylaştırmak ve fonksiyonu artırmak yer alır.

Spastisite tedavisinde kullanılan fizik tedavi yöntemleri germe egzersizleri, postür ve pozisyonlama, ortez kullanımı, soğuk uygulama, elektrik stimülasyonu, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve botulinum toksini enjeksiyonlarını içerir. Medikal tedavi olarak baklofen, diazepam, tizanidin ve dantrolen gibi ilaçlar kullanılabilir. Gerekirse intratekal baklofen tedavisi ve tendon uzatma, tendon transferleri, selektif dorsal rizotomi gibi cerrahi müdahaleler de uygulanabilir *(Cankurtaran & Ünlü Akyüz, 2021; Smania, vd., 2010).*

6.2.2.3. Eklem Kontraktürü

Eklem kontraktürü, eklem, kas veya yumuşak dokudan kaynaklanan, pasif eklem hareket açıklığının kısıtlandığı bir durumdur. Spinal kord yaralanması, travmatik veya hipoksik beyin hasarı ve nöromusküler hastalıklar gibi hastalıklara sahip çocuklarda sıkça görülür. Eklem kontraktürleri geliştiğinde, motor performans düşer, hareket kabiliyeti sınırlanır, eklem fonksiyonları azalır ve günlük aktiviteler zorlaşır. Alt ekstremitelerde eklem kontraktürleri üst ekstremitelere kıyasla daha yaygındır. Kontraktürleri önlemek, geciktirmek veya tedavi etmek amacıyla beş temel fizyoterapi prensibi uygulanır: 1) Destekleyici cihaz yardımıyla düzenli ayakta durma pozisyonu, 2) Pasif/aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri, 3) Germe egzersizleri, 4) Uygun pozisyonlama ve 5) Doğru ortez kullanımı *(Cankurtaran & Ünlü Akyüz, 2021; Skalsky & McDonald, 2012).*

6.2.2.4. Osteoporoz ve Kırıklar

Çocukluk döneminde osteoporoz, primer nedenler (örneğin osteogenesis imperfekta) veya kortikosteroid ve antiepileptik ilaç kullanımı, immobilite nedeniyle yük bindiren aktivitelerdeki eksiklik gibi ikincil nedenlerle ortaya çıkabilir. Palyatif bakımdaki çocuklarda osteoporozun yol

açabileceği en ciddi sorunlar, düşük enerjili vertebral ve/veya femur, tibia, humerus, ön kol, ayak bileği ve ayaklarda non-vertebral kırıklardır.

6.2.2.4.1. Osteoporoz Tedavisi

Beslenme Desteği: Kemik sağlığı için en bilinen besin öğeleri D vitamini ve kalsiyumdur; bununla birlikte demir, çinko, magnezyum, protein ve A, C, K vitaminleri de kemik sağlığını destekleyen önemli elementlerdir. Palyatif bakım altındaki çocuklar, sınırlı güneş maruziyeti, antiepileptik kullanımı, malabsorbsiyon ve yetersiz diyet alımı nedeniyle D vitamini eksikliği açısından risk altındadır.

Fiziksel Aktivite: Yoğun fiziksel aktiviteler, özellikle prepubertal ve pubertal dönemlerde kemik kütlesi üzerinde anabolik etkilere sahiptir. Osteoporozu olan ve hareket edebilen çocuklar için düşük riskli ve temas gerektirmeyen egzersizler (örneğin yürüyüş, sabit bisiklet) önerilir. Ciddi yetersizlikleri olan çocuklarda ise ayakta durma egzersizlerine ek olarak, yüksek frekanslı vibrasyon uygulamalarının kemik mineral yoğunluğunu artırdığı gösterilmiştir.

Medikal Tedavi: Osteoporozun medikal tedavisi, kırıkları önlemek (birincil koruma) ve kırık oluşmuşsa yeni kırıkları engellemek (ikincil koruma) üzerine odaklanır. Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar iki gruba ayrılır: kemik yıkımını önleyen antirezorptif ajanlar ve kemik yapımını artıran anabolik ajanlar. Çocuk hastalarda genellikle antirezorptif ajanlardan olan bifosfonatlar tercih edilir; alendronat sodyum ve pamidronat pediyatrik osteoporozda kullanım için kanıtlanmış ajanlardır. Son yıllarda zolendronik asidin kullanımı ile ilgili kanıtlar da artmaktadır *(Cankurtaran & Ünlü Akyüz, 2021; Ward, 2016).*

6.2.3. Nörolojik Semptomların Kontrolü

Palyatif bakıma sevk edilen çocukların yaklaşık üçte birinde nöromusküler hastalıklar ve %41'inde nörolojik sonuçlara yol açabilecek genetik veya doğumsal rahatsızlıklar bulunmaktadır *(Feudtner, 2011).* Palyatif bakım hastalarında sıkça gözlemlenen nörolojik semptomlar, dirençli doğaları ve semptom yönetimi konusunda yetersiz kanıt bulunması nedeniyle yönetilmesi zorlayıcı ve karmaşık olabilir.

6.2.3.1. Konvülziyon Yönetimi

Anti-konvülzanların Akılcı Kullanımı: Tedavisi zor veya ilerleyici hastalıkları olan çocuklar ile ağır nörolojik engelleri bulunan çocuklarda kontrol altına alınamayan nöbetler görülebilir. Bu çocukların çoğu palyatif bakım sürecinde birden fazla antiepileptik ilaç kullanır. Antiepileptiklerin devamı, fayda-risk analizi yapılarak, çocuk nöroloji uzmanı ile yakın iş birliği içinde kararlaştırılmalıdır. Nazal veya bukkal midazolam uygulaması, özellikle terminal dönemde kolaylık sağlar ve nöbet yönetiminde iyi bir seçenektir. Nöbetlerin tam kontrolünün her zaman mümkün olamayabileceği konusunda aile bilgilendirilmelidir.

Non-Farmakolojik Tedaviler: Terminal dönemde hastanın rahatını sağlamaya yönelik pozisyonlama ve oksijen desteği önemlidir. Bu aşamada aşırı müdahalelerden kaçınmak, nöbetlerin şiddetlenmesini önlemek açısından önem taşır. Uygulanan her müdahale kas spazmları ve ağrıyı tetikleyebilir. Masaj gibi rahatlatıcı yaklaşımlar yardımcı olabilir. Yumuşak pozisyonlama, nöbet sırasında hastayı koruyarak nöbet kaynaklı yaralanmaların önüne geçebilir *(Hain & Douglas, 2011; Öztek Çelebi & Yüksel, 2021; Ullrich, vd., 2019).*

6.2.3.2. Hareket Bozukluklarının Yönetimi

Palyatif bakımda hasta ve bakım verenlerin yaşam kalitesini etkileyen başlıca hareket bozuklukları arasında spastisite, distoni, miyoklonus ve kore yer alır. Spastisite daha önce anlatıldığından burada ele alınmamaktadır.

Distoni: Distoni, agonist ve antagonist kasların istemsiz kasılmaları nedeniyle gövde veya uzuvlarda bükülme ve kıvrılma ile karakterize bir hareket bozukluğudur. Çocukluk çağında distoninin en sık nedeni serebral palsidir. Diğer nedenler arasında nörodejeneratif veya nörometabolik hastalıklar, ilaçlar ve genetik kökenli primer distoniler yer alır. Distoninin rabdomiyoliz ve hipertermi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Tedavide tetikleyici faktörleri belirlemek önceliklidir. Distoniye bağlı ağrı, duruş bozuklukları, uyku bozuklukları, ortopedik komplikasyonlar, yutma ve solunum güçlükleri de görülebilir. İlaç dışı tedavi yöntemleri arasında pozisyonlama, proprioseptif geri bildirim ve yumuşak splintler bulunmaktadır.

Distonilerin ilaç tedavisi genellikle zordur. Triheksifenidil, santral etkili antikolinerjik bir ilaç olarak kullanılır ancak sedasyon, ağız kuruluğu, göz kuruluğu ve kabızlık gibi yan etkileri olabilir. Spastisitenin eşlik ettiği distonide baklofen ilk tercih olarak düşünülür. L-Dopa bazı primer ve sekonder distonilerde yarar sağlayabilirken; diazepam, ağrılı kas spazmlarını gidermek için kas gevşetici ve sedatif olarak kullanılabilir. Gabapentin de nöropatik ağrı tedavisinde tercih edilir. Fokal distonilerde botulinum toksini, yaygın distonilerde ise derin beyin stimülasyonu tedavi seçenekleri arasındadır. Status distonikusta benzodiazepin, klonidin ve intravenöz hidrasyon uygulanmalı, böbrek yetmezliği riski açısından serum kreatin kinaz ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Miyoklonus: Miyoklonus, bir veya daha fazla kasın istemsiz kasılması sonucu ani ve hızlı hareketlerle kendini gösterir. Palyatif bakımda en sık opioid ilişkili miyoklonus görülür ve genellikle opioid dozunun yüksekliği veya hızlı arttırılması ile ilişkilidir. Miyoklonusa ayrıca nörometabolik, nörodejeneratif hastalıklar ve progresif miyoklonik epilepsiler de neden olabilir. Tedavide benzodiazepinler, levetirasetam, valproik asit, fenobarbital veya primidon kullanılabilir.

Kore: Kore, palyatif bakım sürecinde birçok nörodejeneratif hastalık, renal ve hepatik disfonksiyonlarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Kore, genellikle ağrıya neden olmaz, ancak hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. Digoksin, antiemetikler, beta adrenerjikler, teofilin,

trisiklik antidepresanlar ve fenitoin koreyi tetikleyen başlıca ilaçlardır. Kore tedavisinde, bu ilaçların kullanımından kaçınılması ve semptomatik tedavi için tetrabenazin, nöroleptikler ve benzodiazepinlerden yararlanılması önerilir *(Hain & Douglas, 2011; Öztek Çelebi & Yüksel, 2021; Wusthoff, vd., 2007).*

6.2.3.3. Serebral İrritasyon Yönetimi

Serebral palside beyin hasarına bağlı olarak çeşitli semptomlar ortaya çıkar ve bu durum serebral irritasyonun en yaygın nedenidir. Yenidoğan veya küçük bebeklerde akut beyin hasarı veya fiziksel yaralanmalar sonucu ortaya çıkan stres, hasarlı nöronlar tarafından tolere edilemediğinde serebral irritasyon oluşur. Serebral irritasyonun en sık nedeni hipoksik iskemik ensefalopatidir. Tedavide fenobarbital, benzodiazepinler ve opioidler kullanılabilir *(Hain & Douglas, 2011; Hauer & Houtrow, 2017; Öztek Çelebi & Yüksel, 2021; Ramusseen & Gregoire, 2015).*

6.2.3.4. Ajitasyon Yönetimi

Ajitasyon, artan uyarılma sonucu ortaya çıkan rahatsızlık hissidir ve genellikle sinirli konuşma, ağlama, kas gerginliği, terleme ve taşikardi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ajitasyonun belirtileri anksiyeteyle benzerlik gösterse de daha çok motor belirtiler ön plandadır. Terminal huzursuzluk ise yaşamın son döneminde yetişkinlerin %25-88'inde görülen deliryumlu veya deliryumsuz ajitasyon halidir, ancak çocuklarda sıklığı bilinmemektedir.

Ajitasyonun Yönetim Basamakları:

Olası Sebeplerin Değerlendirilmesi: Ağrı, özellikle nörolojik engelli çocuklarda ajitasyonun en yaygın nedenidir. Ayrıca, miyoklonus veya amaçsız hareketler gibi belirtiler kafa içi basıncının yükseldiğine işaret edebilir. Hiperkalsemi, enfeksiyonlar, hipoksi, böbrek veya karaciğer yetmezliği de ajitasyonu tetikleyebilir.

Deliryum Varlığının İncelenmesi: Ajitasyona eşlik eden uyku sorunları, dikkat eksikliği ve duygu durum dalgalanmaları deliryumu işaret edebilir.

İlaç İncelemesi: Sedatiflerin paradoksal etkileri, kortikosteroidler ve adrenerjik ilaçlar ajitasyonu artırabilir. Ayrıca, antikonvulzan, opioid, klonidin, nikotin ve sedatif hipnotiklerin yoksunluğu da ajitasyona neden olabilir.

İlaç Dışı Yaklaşımlar: Ajitasyonun ilk yönetimi ilaç dışı yöntemlerdir. Bakım verenler, çocuğu yumuşak ses ve dokunuşlarla rahatlatabilir. Tanıdık eşyalar, çocuk için sakinleştirici olabilir. Çocuğun kendine zarar verme riski olduğunda fiziksel sınırlamalar gerekebilir.

İlaç Tedavisi: Pediyatrik ajitasyon tedavisi için ilaç tedavisinde sınırlı kanıt bulunmakla birlikte, gabapentin, klonidin, benzodiazepinler, antipsikotikler, trisiklik antidepresanlar ve kloralhidrat kullanılabilir. Gabapentin, özellikle nöropatik ağrı yönetiminde tercih edilir. Gabapentin, ajitasyona

neden olabilecek nöropatik ağrı durumlarında ilk basamak tedavi olarak da değerlendirilir; en yaygın yan etkisi sedasyondur. Ajitasyon sırasında disotonomi görülüyorsa, klonidin gibi bir alfa-2-adrenerjik reseptör agonisti düzenli veya kriz durumlarında kullanılabilir. Diğer destekleyici ilaçlar arasında gabapentin, opioidler ve benzodiazepinler yer alır. 2008 DSÖ Palyatif Bakımdaki Çocuklar için Temel İlaçlar Listesinde, çocuklarda kaygı ve ajitasyon yönetiminde diazepam, midazolam gibi benzodiazepinleri ve haloperidol gibi antipsikotikleri önermektedir. Benzodiazepinler sedasyon, artmış tükürük salgısı, solunum depresyonu ve nadiren paradoksal reaksiyonlara (huzursuzluk, saldırganlık) yol açabilir. Antipsikotikler ise daha az sedasyon sağlar ancak ekstrapiramidal semptomlar ve nöbet riskini artırabilir. Trisiklik antidepresanlar da ajitasyon tedavisinde kullanılabilir. İlk ve ikinci basamak ilaçlarla yeterli sonuç alınamazsa, geçici olarak kloralhidrat, dimenhidrinat veya metotrimeprazin gibi daha yatıştırıcı ilaçlar kullanılabilir *(Hain & Douglas, 2011; Hauer & Houtrow, 2017; Öztek Çelebi & Yüksel, 2021; Ramusseen & Gregoire, 2015; Wusthoff, vd., 2007).*

6.2.3.5. Uyku Bozukluklarının Yönetimi

ÇPB alan, özellikle nörolojik etkilenimi olan çocuklarda, beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar nedeniyle uyku-uyanıklık döngüsünün de bozulması yaygındır. Bu durum, bakım verenler için uykusuzluk sorununu artırarak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Tedavinin amacı, uyku-uyanıklık döngüsünü yeniden düzenlemektir.

Uyku Düzeninin Yeniden Sağlanması: Gündüz ve gece döngüsünün net bir şekilde oluşturulması önemlidir. Çocuğun doğal ışığa ve karanlığa erişimi sağlanmalı, gündüz saatlerinde stimülasyon artırılmalı, gece boyunca ise azaltılmalıdır. Çocuğun aktif kalmasına destek olmak için hidroterapi, aromaterapi ve masaj gibi yaklaşımlar kullanılabilir. Gündüzleri, çocuk yatakta yüksek oturur veya yan yatar pozisyonda daha fazla uyaran alabilir; uyku saatlerinde ise daha yatık pozisyonlar tercih edilmelidir.

Düzenli Kullanılan İlaçların Düzenlenmesi: Nörolojik semptomları olan çocukların aldığı ilaçlar, sıklıkla sedasyona yol açabilir. Bu ilaçların zamanlamasının gözden geçirilmesi, uyku sorunlarının çözülmesine katkıda bulunabilir; sakinleştirici veya sedatif özellikteki ilaçları gece vermek, uyku kalitesini artırabilir.

Farmakolojik Tedavi: Melatonin takviyesi uyku sorunları için yaygın olarak kullanılır, genellikle 3 mg ile başlanır. Etkili olabilecek diğer ilaçlar, anksiyete azaltıcı benzodiazepinler ve uykuya yardımcı ancak anksiyolitik olmayan kloral hidrat gibi ajanlardır. Nöropatik ağrı varlığında amitriptilin veya gabapentin tercih edilebilir. Uyku bozukluğu depresyona bağlıysa, antidepresan dozunun artırılması da düşünülebilir *(Hain & Douglas, 2011; Hauer & Houtrow, 2017; Öztek Çelebi & Yüksel, 2021).*

6.2.4. Beslenme ve Gastrointestinal Sistem Problemleri Yönetimi

Palyatif bakım altındaki çocuklar arasında, özellikle nörolojik problemleri olanlarda beslenme sorunları sık görülür. Yutma güçlüğü (disfaji), Gastrointestinal Sistem (GİS) motilitesinde yavaşlama, sürekli kusma ve iştahsızlık gibi sorunlar, çocukların temel besin ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırabilir. Yeterli beslenme sağlanamadığında çocuğun genel sağlığı bozulabilir. Ağız yoluyla yeterli beslenemeyen çocuklar için enteral beslenme (EB) yöntemleri uygulanır; bu, çoğunlukla tüple beslenme yoluyla yapılır. Tüpler prepilorik (örneğin, orogastrik veya nazogastrik) veya postpilorik (nazoduodenal veya jejunostomi) yerleştirilebilir; her yöntemde çocuğun durumu ve ailenin tercihleri dikkate alınmalıdır. Derin sedasyon alan, şiddetli gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan veya gastrik boşalma hızı yavaş olan hastalarda postpilorik beslenme tercih edilir. Polivinilklorid tüplerin 3-5 günde bir değiştirilmesi gerekirken, silikon ve poliüretan tüpler 8 haftaya kadar kullanılabilmektedir. Özellikle 4-6 haftadan uzun sürecek durumlarda gastrostomi veya jejunostomi önerilebilir. EB bolus veya sürekli infüzyon şeklinde uygulanabilir; bolus beslenme basitliği nedeniyle tercih edilirken, bazı durumlarda sürekli infüzyona geçilmesi gerekebilir. EB'nin enfeksiyon veya tüp kayması gibi bazı riskleri de mevcuttur *(Bekem Soylu, 2020; Braegger, 2010; Mahant, vd., 2009; Öztek Çelebi & Şahin, 2021).*

Terminal dönemde iştahsızlık yaygın bir sorun olup kaşeksiye yol açabilir, bu da çocuğun günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini zorlaştırır ve yaşam kalitesini düşürür. Bu durumda, beslenme desteği sağlanması, öğünlerin sıklaştırılması, porsiyonların küçültülmesi gibi düzenlemeler yapılabilir; ayrıca iştahı artırmak amacıyla bazı farmakolojik tedaviler de kullanılabilir *(Bekem Soylu, 2020; Öztek Çelebi & Şahin, 2021).*

6.2.4.1. Ağız ve Yutma Sorunları

Ağız sağlığı, palyatif bakım altındaki hastaların yaşam kalitesini ve genel iyilik durumunu etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle ağızdan beslenemeyen, sıvı alımı sınırlı olan, NG veya OG tüp kullanan, mekanik ventilatöre bağlı veya hastalığın son dönemlerinde olan hastalar için ağız bakımı daha da kritik hale gelir. Palyatif bakım hastalarında dikkate alınması ve tedavi edilmesi gereken başlıca ağız sorunları arasında kötü ağız hijyeni, oral kandidiyaz, mukozit, ağız ülseri, ağız kuruluğu, diş eti kanamaları ve diş problemleri yer alır. Ağız sağlığını korumanın temel yolu, dişlerin ve diş etlerinin florürlü diş macunuyla günde iki kez özenle temizlenmesidir. Ağız bakım süngerleri kullanılabilir. Ayrıca dudaklarda kuruluk ve çatlamayı önlemek amacıyla nemlendirici krem veya parafin uygulanabilir *(Öztek Çelebi & Şahin, 2021; Friedrichsdorf vd., 2011).*

6.2.4.2. Disfaji

Yutma, ağız, yutak ve yemek borusunun koordinasyonunu gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte yer alan kaslar, sinirler veya yutma yolundaki herhangi bir yapıda meydana gelen hasar yutma güçlüğüne yol açabilir. Disfaji, terminal dönemdeki çocukların %23-30'unda görülmekte

olup, özellikle nörolojik bozuklukları olan çocuklarda yaygındır ve bu grupta aspirasyon riski %94 oranında rapor edilmiştir. Disfaji şüphesi varsa tanıyı doğrulamak amacıyla video floroskopi, baryumlu yutma testi, endoskopi ve özofageal manometri gibi incelemeler yapılabilir. Tedavide öncelikle altta yatan neden bulunmalı ve varsa ağız kuruluğu, enfeksiyon veya reflü tedavi edilmeli, ağrı kontrolü sağlanmalı ve anksiyete gibi psikolojik etkenler düzenlenmelidir. Ayrıca postür düzenleme, öğünlerin kıvam ve miktarını ayarlama gibi önlemler de tedaviye destek sağlar *(Öztek Çelebi & Şahin, 2021; Friedrichsdorf & Collins, 2007).*

6.2.4.3. Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)

Nörolojik defisiti olan çocukların %15-75'inde GÖRH gözlenir. Beslenme sırasında veya sonrasında, sırt üstü yatarken yiyecek reddi, kusma, kilo kaybı, gelişim geriliği, aşırı sekresyon, aspirasyon pnömonisi ve tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları gibi belirtiler GÖRH şüphesi yaratır. Hafif vakalarda, başı yüksek tutmak, yatmadan önce beslenmemek, çikolata ve kafein gibi gıdalardan kaçınmak, küçük miktarlarda beslemek ve kıvam arttırıcı kullanmak gibi yaşam tarzı düzenlemeleri önerilir. İlaç tedavisi olarak antiasitler, H2 reseptör antagonistleri (Ranitidin, Famotidin), proton pompa inhibitörleri (omeprazol, lansoprazol) ve prokinetik ajanlar (eritromisin, metoklopramid, domperidon) uygulanabilir. İlaç tedavisi yeterli olmazsa antireflü cerrahi seçenek olarak düşünülebilir *(Bekem Soylu, 2020; Öztek Çelebi & Şahin, 2021).*

6.2.4.4. Bulantı ve Kusma

Bulantı ve kusma, özellikle nörolojik hastalığı olan palyatif bakım hastalarında, gastroözofageal reflü ve hareket bozuklukları gibi nedenlerle sık karşılaşılan semptomlardır. Ayrıca sistemik ve gastrointestinal enfeksiyonlar, elektrolit dengesizlikleri, ilaç yan etkileri ve psikolojik faktörler de bu semptomlara yol açabilir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları, GİS tıkanıklıkları, vestibüler sistem sorunları, kafa içi basınç artışı (KİBAS) ve beyin metastazları da bulantı ve kusmanın diğer nedenleri arasındadır. Hastanın öyküsünde semptomların başlangıcı, kusma materyalinin içeriği, eşlik eden bulgular, ilaç ve beslenme ilişkisi gibi bilgiler sorgulanmalıdır. Ateş ve ishal enfeksiyöz bir neden düşündürürken, epigastrik ağrı, yanma veya regürjitasyon üst GİS tahrişini; karın ağrısı, şişkinlik ve dışkılama zorluğu ise tıkanıklığı işaret edebilir. Kusmanın kırmızı veya kahverengi olması kanama riskini akla getirmelidir. Kusmanın aşırı olması dehidrasyon riski taşır. Bulantı ve kusmanın komplikasyonları arasında özofajit, aspirasyon pnömonisi, sıvı-elektrolit dengesizlikleri ve yaşam kalitesinde azalma yer alır.

6.2.4.4.1. Tedavi Yaklaşımı

1. ***Değerlendirme:*** Bulantı ve/veya kusma şikâyeti olan her palyatif bakım hastasının detaylı bir klinik öykü ve fizik muayene ile değerlendirilmesi gerekir. Beslenme, ilaç kullanımı, ağrı veya duyusal uyaranlarla olan ilişkisi sorgulanmalıdır. Ağrının yeterince kontrol edilmemesi

de bu semptomlara yol açabilir. Tanı konulamayan durumlarda, tam kan sayımı, biyokimya, CRP, idrar tahlili, kültürler ve radyolojik incelemeler (batın ultrasonografisi, GİS pasaj grafisi) yapılabilir.

2. ***Altta Yatan Nedenin Tedavisi:*** Kabızlık, reflü, subileus, gastroenterit, enfeksiyonlar ve metabolik bozukluklar gibi altta yatan nedenler ele alınmalıdır. Antibiyotikler, antikolinerjikler, kortikosteroidler, opioidler gibi ilaçlar da bulantı ve kusma yapabilir.

3. ***Destekleyici Yaklaşımlar:*** İyi ağız hijyeni, püre şeklinde yumuşak yiyecekler, yemeklerin zamanlaması ve porsiyonların ayarlanması, hoşlanmadığı kokulardan kaçınma gibi önlemler alınabilir. Ayrıca davranış terapisi, aromaterapi, müzik terapisi ve akupunktur gibi yöntemler tedavide denenebilir.

4. ***Farmakolojik Tedavi:*** Kullanılacak ilaçlar Tablo 6'da listelenmiştir. GÖRH'ye bağlı kusmalarda kıvam artırıcıların kullanılması da fayda sağlayabilir *(Friedrichsdorf, 2011; Öztek Çelebi & Şahin, 2021)*

Tablo 6. Bulantı ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

İlaç Adı	Etki Mekanizması/Yan Etkileri
Ondansetron, granisetron, dolasetron	Seratonin 5HT3 reseptör antagonistidir. Antiemetik ve prokinetik etkileri nedeniyle ampirik bulantı tedavisinde başarılıdır. Elektrolit dengesizliği, KKY, aritmi veya QT uzamasına yol açan ilaç kullanımı varsa EKG monitorizasyonu önerilir. Yan etkisi kabızlıktır.
Metaoklopramid, domperidon	MSS'de dopamin antagonistidir. Dismotilite varlığında başarılıdır. Antiemetik ve sedatif etkilidir. Domperidone kan beyin bariyerini geçemediği için yan etkileri daha azdır. Metaoklopramid ise yüksek dozda ekstra-piramidal reaksiyonlara neden olabilir, ileus ve feokromasitomada kontrendikedir.
Difenhidramin, dimenhidrinat, hidroksizin, siklizin	Histamin1 ve Asetilkolin reseptör antagonistidir. Zayıf antiemetiklerdir. Sedasyon yapabilir.
Kortikosteroidler-Deksametazon, Prednizolon	SSS'de serotonin sentezini değiştirir ve endorfin salınımını uyarır. Karaciğer kapsül gerginliği, bağırsak duvarında ödem, anoreksi ve KİBAS'da yararlıdır. Yan etkileri açısından dikkatli kullanılmalıdır.
Eritromisin	Prokinetik etkisi vardır. Motilin reseptör antagonistidir.
Lorazepam	Lorazepam ve diğer benzodiazepinler, antiemetik tedaviye ilave faydaları olabilecek güçlü anksiyolitik ajanlardır.
Dronabinol	Kapsül şeklinde kullanıldığı için yutamayan çocuklarda içeriğin sıvı ile karıştırılarak verilmesi önerilir. Susam yağı alerjisi olanlarda, depresyon, mani ve şizofrenide önerilmez. Öfori, disfori ve mod değişikliği yapabilir.
Skopalamin bandı	Sekresyonlarda koyulaşma yapabilir. Hareket kaynaklı bulantı-kusmada yararlıdır. Yanlışlıkla göze dokunursa anizokori ve bulanık görme yapabilir. Bandın kesilmesi önerilmez, katlanarak kullanılabilir. Antikolinerjik yan etkileri olabilir.
Olanzapin	Metoklopramid ile birlikte kullanımı önerilmez.
Protein pompa inhibitörleri, H2 reseptör blokeri	Gastrik asit salgısını baskılayarak GİS mukozasını korur.

(Friedrichsdorf, 2011)

6.2.4.5. Kabızlık

Kabızlık, iki haftadan uzun süre devam eden, haftada üçten az, sert ve zorlanarak dışkılama durumu olarak tanımlanır ve çocuk palyatif bakım hastalarının %27-59'unda görülen bir sorundur. Bu durum genellikle hareket kısıtlılığı, yetersiz sıvı alımı ve düşük lif içeren beslenme nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle nörolojik bozuklukları olan çocuklarda, elektrolit dengesizlikleri, beslenme problemleri, ilaç yan etkileri ve hipotiroidizm durumunda daha sık görülür.

6.2.4.5.1. Tedavi Yaklaşımı

1. Değerlendirme: Kabızlık iştahsızlık, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Anemnez ve fizik muayenede nörolojik belirtiler (alt ekstremite güçsüzlüğü, idrar retansiyonu, dışkı kaçırma gibi) dikkatlice incelenmelidir. Rektal muayene, dışkının birikim durumunu ve rektal tonusu belirleyerek anal fissür veya hemoroid gibi nedenleri açığa çıkarabilir.

2. Altta Yatan Nedenin Tedavisi: Kabızlık nedenleri arasında anoreksiya, karın kas tonusunun azalması, yanlış tuvalet alışkanlıkları, postur bozuklukları, depresyon ve hipotiroidizm, hipokalemi, hiperkalsemi gibi durumlar yer alır. Ayrıca bağırsak tıkanıklıkları ve ilaç yan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Destekleyici ve Tamamlayıcı Tedavi: Rektumda birikmiş sert dışkı için lavman uygulanmalı ve ardından idame tedaviye geçilmelidir (nötropenik hastalarda lavmandan kaçınılmalıdır). Tuvalet düzenini sağlama, aktiviteyi artırma, yeterli sıvı ve lif alımı, karın masajı gibi önlemler kabızlığın yönetiminde yardımcı olabilir. Hiperkalorik ürün kullanan hastalarda sıvı alımını desteklemek önemlidir ve lif içeriği yüksek formüller tercih edilmelidir. Kabızlığa neden olabilecek opioidler, antidepresanlar, diüretikler ve antihistaminikler gibi ilaçların yan etkileri değerlendirilmelidir. Ayrıca biofeedback ve bilişsel davranışçı terapi nörojenik kabızlıkta etkili olabilir.

4. Farmakolojik Tedavi:

- ***Dışkı Yumuşatıcılar:*** Mineral yağ, laktuloz, dokusat, sorbitol, magnezyum hidroksit ve polietilen glikol gibi laksatifler bağırsakta su tutulumu yaparak dışkıyı yumuşatır.
- ***Uyarıcı Laksatifler:*** Senna ve bisakodil, dışkı yumuşatıcıların yetersiz kaldığı durumlarda kısa süreli kullanılabilir.
- ***Prokinetikler:*** Gastrointestinal hipomotiliteye bağlı kabızlık için düşük doz metoklopramid veya eritromisin kullanılabilir.
- ***Opioid Antagonistleri:*** Metilnaltrekson, opioid kaynaklı kabızlıkta kullanılır ve etkisi hızlı başlar.
- ***Suppozituvar ve Lavmanlar:*** Rektal boşaltım için kısa süreli ve aralıklı kullanılabilir (nötropeni olanlarda önerilmez). İçeriğinde sorbitol fosfat, serum fizyolojik, mineral yağ ve gliserin bulunabilir.
- ***Miralaks:*** Tatsız ve toz formda olduğu için içeceklere karıştırılarak kullanılabilir.
- ***Probiyotikler:*** Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği konusunda sınırlı kanıt bulunmaktadır *(Friedrichsdorf, 2011; Öztek Çelebi & Şahin 2021).*

6.2.4.6. İshal

Artan sekresyonlar, azalan emilim veya bağırsak hareketlerinin artması sonucu dışkının yumuşaması ve miktarının artması (>10 mL/kg/gün veya 200 mL/gün) ile ishal ortaya çıkar. Palyatif bakım altındaki hastaların %21-40'ında enfeksiyonlar, bağışıklık ve inflamasyon sorunları, ilaç kullanımı, maligniteler, motilite bozuklukları veya beslenme hataları nedeniyle ishal görülebilir.

6.2.4.6.1. Tedavi Yaklaşımı

1. Değerlendirme: İshalin değerlendirilmesinde ilk adım, hastanın öyküsünü almak ve fizik muayene yapmaktır. En sık karşılaşılan nedenler gastroenteritler, malabsorpsiyon, laksatif kullanımı, antibiyotikler ve kemoterapidir.

2. Altta Yatan Nedenin Tedavisi: Tedavi edilebilecek nedenler arasında taşma tipi dışkılama, anksiyete, besin intoleransı, aşırı laksatif kullanımı, radyoterapiden kaynaklanan GİS hasarı, irritabl bağırsak sendromu, pankreatik yetersizlik, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve laktoz intoleransı bulunur.

3. Destekleyici Tedaviler: Dehidrasyonu önlemek için sıvı alımını artırmak önerilir. Bakteriyel gastroenterite bağlı geçici laktaz eksikliğinde süt alımı azaltılabilir. Enfeksiyon mevcutsa tedavi edilmelidir. Ayrıca özel tıbbi amaçlı gıdaların miktar ve ozmolaritesi ayarlanabilir veya ağız yoluyla beslenen hastalarda diyet içeriği düzenlenebilir. Perianal cilt bakımı, bariyer kremlerle yapılmalıdır.

4. Farmakolojik Tedavi:

- ***Loperamid:*** Güçlü bir μ-reseptör agonisti olup, kan-beyin bariyerini geçmediği için güvenle kullanılabilir.
- ***Bizmut Subsalisilat:*** Etki mekanizması tam olarak bilinmese de ishal tedavisinde kullanılır; viral enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
- ***Kolestiramin:*** Hiperkolesterolemi, karaciğer yetmezliğiyle ilişkili kaşıntı ve ishal için kullanılabilir.
- ***Oktreotid:*** Sekretuvar ishal tedavisinde etkilidir.
- ***Probiyotikler*** (Saccharomyces boulardii ve Lactobacillus rhamnosus GG) önerilse de etkinlik ve güvenilirlik konusunda kesin kanıt bulunmamaktadır.
- ***Ondansetron ve Çinko*** preparatları da destekleyici olarak kullanılabilir *(Friedrichsdorf, 2011; Öztek Çelebi&Şahin 2021).*

6.2.4.7. Beslenme İntoleransı

Çocuk palyatif bakım hastalarında, beslenmeyle ilişkili irritabilite ve ağrı gibi GİS semptomları sık görülür. Beslenme şekli, yolu veya özel tıbbi amaçlı gıdaların değiştirilmesine rağmen intolerans devam ederse, beslenme miktarının azaltılması yararlı olabilir. Visseral hiperaljezi, bağırsak duyusal uyarılarına aşırı yanıt olarak gelişir ve genellikle GİS patolojisi olmayan çocuklarda düşünülmelidir. Tedavi seçenekleri arasında analjezikler, eritromisin, metoklopramid, gabapentin ve ondansetron bulunur. Ayrıca yutma fizyoterapisi, ağızdan beslenme desteği, davranış terapileri, aromaterapi ve masaj gibi tamamlayıcı yöntemler denenebilir *(Öztek Çelebi & Şahin, 2021; Siden vd., 2009).*

6.2.5. Diğer Semptomların Yönetimi

İlerlemiş hastalık durumlarında semptom yönetiminde, çocuğun yaşına, kilosuna ve klinik durumuna göre ilaç dozları dikkatle ayarlanmalı ve kontrol edilebilir semptomları hafifletmek için uzmanlardan destek alınmalıdır. Aşağıda ÇPB'de sık karşılaşılan ağrı dışı semptomlara değinilecektir.

Genel Semptomlar ⟶ Halsizlik/Yorgunluk

Karmaşık kronik hastalıkları olan çocuklarda yorgunluk üzerine yapılan en ayrıntılı çalışmalar kanserli çocuklar üzerinde yapılmıştır. Küçük çocuklarda yorgunluk, bedensel hareketleri gerçekleştirmede zorlanma şeklinde, örneğin bacakları hareket ettirme veya gözleri açma güçlüğü olarak tanımlanırken, ergenlerde ise fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmişliği içeren değişken bir yorgunluk hali olarak tarif edilir. Kanser hastası çocukların yarısından fazlasında yorgunluk, halsizlik, enerji kaybı ve uyuklama gibi belirtiler görülür.

Yorgunluk çok boyutlu bir semptom olup hastalık, tedavi veya psikolojik faktörlerle ilişkili olabilir ve değerlendirilmesi hem subjektif hem objektif verilerle yapılmalıdır. Subjektif değerlendirme, çocuğun yorgunluk hissi, süresi, hangi durumlarda arttığı ve günlük aktivitelerine etkisi üzerine bilgi toplar. Objektif değerlendirme ise vital bulguların, nefes darlığı veya kusma gibi semptomların, hidrasyon durumunun ve kas gücünün ölçülmesini içerir. Laboratuvar testleri arasında oksijen satürasyonu, tam kan sayımı ve tiroid fonksiyon testleri bulunur. Yorgunluk yönetimi, altta yatan nedene göre farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımları kapsar. Örneğin, anemiye bağlı yorgunlukta kan transfüzyonu yapılabilirken, hastalığın ilerlemesinden kaynaklanan yorgunlukta psikostimülanlar (metilfenidat veya dekstroamfetamin) kullanılabilir. Uykusuzluk veya kaygı durumunda ise difenhidramin, lorazepam veya adolesanlarda zolpidem gibi uyku düzenleyiciler uygulanabilir. Ayrıca, kas güçsüzlüğü yaşayan çocuklar için fiziksel ve iş uğraşı terapileri önerilir; kaygı sorunlarında ise uykuya olumlu etki sağlaması amacıyla oyun terapisi gibi destekleyici yöntemlere başvurulabilir *(Ferrell, 2015)*.

Kaynakça

Afshan, G., & Bashir, K. (2014). Cancer pain in children: a two-step strategy. Anaesthesia Pain & Intensive Care, 18(1), 106-110.

Anekar, A. A., Hendrix, J. M., & Cascella, M. (2023). WHO analgesic ladder. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing.

Bekem Soylu, O. (2020). Gastroenteroloji. In T. Celik, S. A. Ozdemir, & N. Harputluoğlu (Eds.), Pediatrik Palyatif Bakım (1st ed., pp. 461-517). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.

Braegger, C., Decsi, T., Dias, J. A., et al. (2010). Practical approach to paediatric enteral nutrition: A comment by the ESPGHAN committee on nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 51, 110-122.

Cankurtaran, D., & Ünlü Akyüz, E. (2021). Kas-iskelet sistemi problemleri ve fizyoterapi. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1241-1246).

Chiaretti, A., Pierri, F., Valentini, P., Russo, I., Gargiullo, L., & Riccardi, R. (2013). Current practice and recent advances in pediatric pain management. European Review for Medical & Pharmacological Sciences, 17.

Cuzzolin, L., Antonucci, R., & Fanos, V. (2013). Paracetamol (acetaminophen) efficacy and safety in the newborn. Current Drug Metabolism, 14(2), 178-185.

Downing, J., Jassal, S. S., Mathews, L., Brits, H., & Friedrichsdorf, S. J. (2015). Pediatric pain management in palliative care. Pain Management, 5(1), 23-35.

Feudtner, C., Kang, K. R., Hexem, S. J., et al. (2011). Pediatric palliative care patients: A prospective multicenter cohort study. Pediatrics, 127(6), 1094-1101.

Ferrell, B. (Ed.). (2015). HPNA palliative nursing manuals: Pediatric palliative care (Vol. 4). Oxford University Press.

Friedrichsdorf, S. J., & Collins, J. J. (2007). Management of non-pain symptoms in pediatric palliative care. Medical Principles and Practice, 16(Suppl. 1), 3-9.

Friedrichsdorf, S. J., Drake, E., & Webster, M. L. (2011). Gastrointestinal symptoms. In J. Wolfe, P. Hinds, & B. Sourkes (Eds.), Textbook of Interdisciplinary Pediatric Palliative Care (1st ed., pp. 311-334). Philadelphia: Elsevier Health Sciences.

Ganesh, A., & Maxwell, L. G. (2007). Pathophysiology and management of opioid-induced pruritus. Drugs, 67, 2323-2333.

Garra, G., Singer, A. J., Domingo, A., & Thode Jr, H. C. (2013). The Wong-Baker pain FACES scale measures pain, not fear. Pediatric Emergency Care, 29(1), 17-20.

Gwyther, L., Brennan, F., & Harding, R. (2009). Advancing palliative care as a human right. Journal of Pain and Symptom Management, 38(5), 767-774.

Hain, R., & Douglas, H. (2011). Neurological symptoms. In J. Wolfe, P. Hinds, & B. Sourkes (Eds.), Textbook of Interdisciplinary Pediatric Palliative Care (1st ed., pp. 239-250). Philadelphia: Elsevier Health Sciences.

Hauer, J., & Houtrow, A. J. (2017). Pain assessment and treatment in children with significant impairment of the central nervous system. Pediatrics, 139(6), e20171002.

Hicks, C. L., von Baeyer, C. L., Spafford, P. A., van Korlaar, I., & Goodenough, B. (2001). The faces pain scale– revised: Toward a common metric in pediatric pain measurement. Pain, 93(2), 173-183.

Hummel, P., Puchalski, M., Creech, S., & Weiss, M. (2008). Clinical reliability and validity of the N-PASS: Neonatal pain, agitation and sedation scale with prolonged pain. Journal of Perinatology, 28(1), 55-60.

Jassal, S. S. (Ed.). (2022). Basic symptom control in paediatric palliative care. Together For Short Lives.

Komatz, K., & Carter, B. (2015). Pain and symptom management in pediatric palliative care. Pediatric Review, 36, 527-534.

Loeser, J. D., & Treede, R.-D. (2008). The Kyoto protocol of IASP basic pain terminology. Pain, 137(3), 473- 477.

Mahant, S., Friedman, J. N., Connolly, B., et al. (2009). Tube feeding and quality of life in children with severe neurological impairment. Archives of Disease in Childhood, 94, 668-673.

Marston, J., Boucher, S., Downing, J., et al. (2013). International children's palliative care network: Working together to stop children's suffering. European Journal of Palliative Care, 20(6), 308-310.

Oktem, S., Ersu, R., Uyan, Z. S., et al. (2008). Home ventilation for children with chronic respiratory failure in Istanbul. Respiration, 76, 76-81.

Onay, Z. R., & Şişmanlar Eyüpoğlu, T. (2021). Kronik solunum yetmezliği. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1250-1253).

Öztek Çelebi, F. Z., & Şahin, Ş. (2021). Beslenme, gastrointestinal sistem problemleri ve yönetimi. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1241-1246).

Öztek Çelebi, F. Z., & Yüksel, D. (2021). Nörolojik semptomların kontrolü. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1254-1258).

Öztek Çelebi, F. Z., & Zernikow, B. (2021). Ağrı yönetimi. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1258-1261).

Printz, M., Zernikow, B., Baumann-Köhler, M., et al. (2022). Pulmonale symptome. In B. Zernikow (Ed.), Pädiatrische Palliativversorgung – Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle (2nd ed., pp. 207-228). Springer.

Rasmussen, L. A., & Gregoire, M.-C. (2015). Challenging neurological symptoms in paediatric palliative care: An approach to symptom evaluation and management in children with neurological impairment. Paediatrics & Child Health, 20(3), 159-165.

Richmond, C. (2005). Dame Cicely Saunders. BMJ: British Medical Journal, 331(7510), 238.

Scholten, W., Christensen, A.-E., Olesen, A. E., & Drewes, A. M. (2020). Analyzing and benchmarking global consumption statistics for opioid analgesics 2015: Inequality continues to increase. Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy, 34(1), 1-12.

Siden, H., Tucker, T., Derman, S., et al. (2009). Pediatric enteral feeding intolerance: A new prognostic factor for children with life-limiting illness? Journal of Palliative Care, 25, 213-217.

Smania, N., Picelli, A., Munari, D., et al. (2010). Rehabilitation procedures in the management of spasticity. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 46, 423-438.

Skalsky, A. J., & McDonald, C. M. (2012). Prevention and management of limb contractures in neuromuscular diseases. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 23, 675-687.

Srouji, R., Ratnapalan, S., & Schneeweiss, S. (2010). Pain in children: Assessment and nonpharmacological management. International Journal of Pediatrics, 2010.

Stevens, B., Johnston, C., Petryshen, P., & Taddio, A. (1996). Premature infant pain profile: Development and initial validation. The Clinical Journal of Pain, 12(1), 13-22.

Voepel-Lewis, T., Shayevitz, J. R., & Malviya, S. (1997). The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. Pediatric Nursing, 23(3), 293-297.

Ward, L. M., Konji, V. N., & Ma, J. (2016). The management of osteoporosis in children. Osteoporosis International, 27, 2147-2159.

Wong, C., Lau, E., Palozzi, L., & Campbell, F. (2012). Pain management in children: Part 1—Pain assessment tools and a brief review of nonpharmacological and pharmacological treatment options. Canadian Pharmacists Journal/Revue des Pharmaciens du Canada, 145(5), 222-225.

World Health Organization. (1996). Cancer pain relief: With a guide to opioid availability. World Health Organization.

World Health Organization. (2017). WHO model list of essential medicines, 20th list (March 2017, amended August 2017).

World Health Organization. (2020). Guidelines on the management of chronic pain in children. World Health Organization.

Wusthoff, C. J., Shellhaas, R. A., & Licht, D. J. (2007). Management of common neurologic symptoms in pediatric palliative care: Seizures, agitation, and spasticity. Pediatric Clinics of North America, 54(4), 709-733.

Yağcı, Ü., & Saygın, M. (2019). Ağrı fizyopatolojisi. Medical Journal of Süleyman Demirel University, 26(2), 209-220.

Zeltzer, L. K., & Levy, R. L. (2020). Pediatric pain management. In G. S. Kliegman & R. Blum (Eds.), Nelson Textbook of Pediatrics (22nd ed., pp. 469-490).

Zernikow, B., & Printz, M. (2022). Praktische schmerztherapie. In Pädiatrische Palliativversorgung – Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle (pp. 7-60). Springer.

7. YAPAY AÇIKLIKLARIN VE BASINÇ YARALARININ BAKIMI

7.1. Yapay Açıklıkların Bakımı

Stoma, Yunanca açıklık, ağız anlamına gelmekte olup, lümenli bir organın doğrudan ya da bir tıbbi cihaz ile cerrahi olarak cilde ağızlaştırılmasıdır. Pediyatrik hastalarda açılan stomalar genellikle geçicidir ancak bazı durumlarda yaşam boyu kalıcı olabilir. Pediyatri hastalarında stoma bakımı yetişkinlerden farklılık göstermektedir. Bunlar; stoma endikasyonu, stoma boyutu, çocuğun büyüme ve gelişimi, özellikle yenidoğanda ve çocuklarda cilt farklılıkları, stomanın aile ve çocuk üzerindeki psikososyal etkisi şeklinde sıralanabilir *(Forest-Lalande,2023).*

7.1.1. Stoma Çeşitleri

Stomalar açıldıkları vücut bölgesine göre isimlendirilir. Pediyatri hastalarında kullanılan stomalar sindirim sistemi stomaları, trakeostomi ve üriner sistem stomalarıdır.

7.1.1.1. Sindirim Sistemi Stomaları

Gastrostomi: Ağız yoluyla beslenemeyen hastaların enteral olarak beslenebilmesi için midenin karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Beslenme genellikle bir tüp aracılığı ile sağlanır. Cerrahi, endoskopik veya floroskopik yöntemle oluşturulabilir. Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) en sık kullanılan yöntemdir. Oral yolla olmayan beslenme desteğinin 3-6 haftadan uzun sürmesi beklendiğinde veya nazogastrik tüp ile beslemenin güvenli olmadığı durumlarda PEG veya cerrahi gastrostomi önerilmektedir *(Homan, 2021).*

Jejunostomi: Jejenumun karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Uzun süreli enteral beslenme için gastrostomiye alternatif olarak kullanılabilir *(Gauderer, 2011).* Direkt perkutan endoskopik jejunostomi (DPEJ) yapılabilmekle beraber bazı avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

İleostomi: İleumun karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Barsak içeriğinin vücuttan uzaklaştırılması (dekompresyon) veya akım yönünün değiştirilmesi (diversiyon) amacı ile yapılır. Uç, loop, çifte namlusu (double-barrel ostomi) şeklinde olabilir. İleostomi içeriği kolostomilere göre daha sıvıdır. Proteolitik enzimlerden zengin olduğu için, stoma içeriğinin cilde temasının önlenmesi önem taşır. Stoma komplikasyonlarının çoğu ileostomiler nedeniyle gerçekleşir *(Gauderer, 2011).*

Kolostomi: Kolonun bir bölgesinin karın duvarına ağızlaştırılmasıdır. Sigmoid kolostomi, transvers kolostomi, çekostomi gibi ağızlaştırılan kolon bölgesine göre adlandırılır. Uç, loop, çifte namlusu gibi farklı şekillerde yapılabilir. Gaytanın boşalmasını sağlamak veya akım yönünü değiştirmek için kullanılır. Kalıcı veya geçici olabilir *(Engida, 2016).*

Sağlıklı bir stomanın görünümü hafif nemli, rengi pembe ya da kırmızıdır. Mukozadan kaynaklanan kanamalar olsa da hızla iyileşme potansiyeli vardır. Ağrı hissi yoktur. Stomalar cilt ile aynı seviyede, yüksek veya oluşturulma tekniğine göre çökük olabilir. İlk açıldığında ödemli, boyutu büyük ve daha nemli görülebilir. Zaman içerisinde ödemi ve stoma yüksekliği azalacaktır.

7.1.1.2. Trakeostomi

Güvenli solunumun sağlanması için trakeaya açılan stomalar 'trakeostomi' olarak adlandırılır. Kronik akciğer hastalıkları, uzun süreli ventilasyonun desteklenmesi ve laringotrakeal stenozun önlenmesi, nörolojik bozukluklar, üst solunum yolu anomalileri en sık endikasyonlarıdır. Çocuklarda trakeanın yapısı ve boyutu, larinks pozisyonu, hava yolu darlığı, trakeanın yumuşak ve esnek yapısı nedeni ile hem açılmasında hem de yönetilmesinde özel teknik ve dikkat gerektirir *(Volsko, 2021)*. Cerrahi olarak ameliyathane şartlarında güvenle yapılabilir. Yoğun bakımda yatak başı perkütan trakeostomi yapılabilmekle beraber tercih edilmemektedir.

7.1.1.3. Üriner Sistem Stomaları

Üriner sistem stomaları, idrarın stoma aracılığı ile dışarı atılmasında üriner ya da intestinal sistem yapıları kullanılarak oluşturulan açıklıklardır. İdrar yolu anomalileri, nörolojik rahatsızlıklar, mesane veya böbrek yetmezliği, ciddi üriner sistem travmaları, kronik enfeksiyonlar ve mesane kanseri gibi endikasyonları mevcuttur. Üreterostomi, vezikostomi, nefrostomi, ileal konduit, genellikle gastrointestinal sistemin bir parçasının işleme dâhil edildiği kalıcı üriner diversiyonlar gibi çeşitleri mevcuttur *(Browning, 2018)*.

7.1.2. Stoma Bakımı

Tüm stomalarda bakımın amacı, stomanın fonksiyonunu yerine getirmesi, cildin korunması, stoma komplikasyonlarının önlenmesi ve hasta ve ailenin konforlu bir yaşam sürmesinin sağlanmasıdır.

Hangi yaş grubu olursa olsun stomalı bireylerin beden imgesinde, psikososyal gelişiminde, gastrointestinal, üriner veya solunum sistemi fizyolojisinde ve yaşam tarzında önemli değişiklikler olmaktadır. Zaman zaman bu değişikliklerin hasta ve ailesi tarafından kabul edilmesi güçleşmektedir. Bu nedenle ameliyat öncesi ve sonrası dönemde aile merkezli bir yaklaşım benimsenmelidir. Yapılacak olan tedavi planının her aşamasında aileye ve gelişimsel dönemi uygunsa çocuğa bilgi verilmelidir. Stoma bakımına ailenin aktif katkısı sağlanmalıdır.

7.1.2.1. Gastrointestinal ve Üriner Sistem Stoma Bakımı

Stoma bakımının yapılabilmesi için stoma bakımında kullanılan malzeme ve ekipmanların ayrıntılı olarak bilinmesi gerekmektedir. Tüm yaşlar ve boyutlar için, hatta en küçük prematüre bebekler için bile, ticari olarak temin edilebilen geniş bir stoma malzemesi yelpazesi mevcuttur. Gastrointestinal veya ürüner sistem stomalarında kullanılan ürünler küçük farklılıklar dışında birbiri ile benzerdir ve aynı şekilde bakım yapılır. Stoma adaptörü, stoma torbası ve stoma pastası stoma bakımında kullanılan en temel malzemelerdir. Stoma adaptör ve torbası ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, birleşik olduğu tek parça sistemler de mevcuttur. Çocuk hastalarda kullanım kolaylığı açısından tek parça sistemler daha kullanışlı olacaktır. Stoma torbaları şeffaf veya opak yapıda olabilir. Şeffaf torbalar operasyondan önceki günlerde ostominin durumunun gözlenebilmesi için

kullanılabilir. Ayrıca üriner sistem ostomilerinde ostomi içeriğinin değerlendirilebilmesi amacı ile şeffaf torbalar önerilmektedir. Üriner sistem stomalarında kullanılan torbaların ucunda idrarın boşaltılmasını sağlayan musluk benzeri sistem mevcut olabilir. Ucuna idrar torbası takılıp, drenaj sağlanır. Stoma adaptörleri ticari olarak hazır kesilmiş halde veya ostominin boyutuna göre sonradan kesilebilir formda bulunabilmektedir. Stomanın retrakte olduğu durumlarda kullanılmak üzere konveks adaptörler mevcuttur. Stoma pastası adaptör ile cilt arasına sürülür. Sızıntıların önlenmesinde, cildin korunmasında etkilidir.

Cilt temizleyiciler, bariyer şeritler, stoma kemerleri, cilt pudrası, yapıştırıcılar, yapışkan çıkarıcılar, cilt koruyucu mendil ve spreyler gibi stoma bakımında kullanılan ve ticari olarak piyasaya sürülmüş pek çok bakım ürünü mevcuttur. Bu ürünler kullanılırken hastanın ve stomanın durumu, hastanın ihtiyaçları, ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Stoma torba-adaptör sistemi kullanım süresi farklı yaş gruplarında değişir. Çocuklarda adaptör değişimi sıklığı en aza indirilmelidir. Stoma torbasının yarısı dolduğunda, torba boşaltılmalıdır. Torbanın ortalama değişim süresi 2-3 gündür. Stoma adaptör ve torbaları her gün kontrol edilmeli ve peristomal cildi iyi koruduğundan emin olunmalıdır.

Stoma boyutu genellikle postoperatif 6. haftada stabilize olur; sonrasında nispeten sabit kalır. Buna karşın, ostomi boyutu, bebek veya çocuk büyüdükçe zamanla değişmeye devam eder. Bu nedenle ostomi boyutu sürekli kontrol edilmeli ve uygun malzeme değişiklikleri yapılmalıdır.

Yenidoğan döneminde stoma emzirmeye engel değildir, hatta anne bu konuda teşvik edilmelidir. Yeni gıdaların denenmesi sırasında ostomi içeriği izlenmelidir. Özellikle ileostomilerde beslenme danışmanlığı sağlanmalı ve dehidratasyona dikkat edilmelidir.

En sık karşılaşılan stoma komplikasyonları peristomal cilt komplikasyonlarıdır. Bunun yanı sıra mukokütanöz ayrılma, iskemi ve nekroz, kanama, parastomal herni, prolapsus, retraksiyon, stenoz gibi cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilecek komplikasyonlarla da karşılaşılabilir. Stoma komplikasyonlarının önlenmesinde doğru cerrahi teknik ile stomanın oluşturulması, ameliyat öncesi ve sonrası hasta ve ailenin eğitimi önem taşır *(Ambe,2018; D'Ambrosio, 2022).*

7.1.3. Trakeostomi Bakımı

Trakeostomi bakımı üç aşamalı olarak yapılmalıdır.

Trakeal aspirasyon: Tükürük, balgam ve sekresyonların solunum açıklığının sağlanabilmesi için aspire edilmesi gerekmektedir. Aspirasyon uygun aspiratör kullanılarak mukozaya zarar vermeden, aseptik şartlarla gerçekleştirilmelidir.

Stoma ve etrafındaki cildin korunması: Trakeostomi tüpü ve sekresyonların cilde zarar vermemesi için stoma açıklığı ve çevresi temizlenmelidir. Stoma etrafındaki cilt lokal pomatlar, yara bakım örtüleri veya trakeostomi için özel planlanmış koruyucu örtülerle desteklenebilir.

Nemlendirme: Trakeostomiden solunan havanın nemlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için farklı tiplerde buhar makineleri kullanılabilir.

7.2. Basınç Yaraları Bakımı

Basınç yaraları, deri ve/veya deri altı dokularda basınca bağlı oluşan lokalize yaralanmalardır. Basınç yaralanmaları genellikle bir kemik çıkıntısı üzerinde oluşurken tıbbi veya diğer cihazlarla ilişkili olarak da ortaya çıkabilir *(Karadağ, 2024)*. Çocuklar, yaş veya gelişim düzeyine bakılmaksızın, özellikle de hastanede yatan pediyatrik hastalar olmak üzere, basınç yaralanmaları açısından yüksek risk altındadır.

Literatürde basınç yaralanmalarının çocuk hastalardaki kümülatif insidans ve prevalans değerleri sırası ile %13,5-12,2'dir *(Zhang, 2022)*.

Çocuklarda basınç yaralanmalarının en sık olarak görüldüğü bölgeler oksiput, sakrokoksigeal bölge, kulaklar, topuklar, ayak bilekleri, burun ve iskial tüberositlerdir. Yoğun bakım servislerinde oksiput en sık görülen bölge iken, genel servislerde ise sakrum ve topuklar en yaygın bölgelerdir *(Zhang, 2022)*.

Hastaneye yatan çocuklarda en sık tibbi cihaz ilişkili basınç yaralanmaları görülmektedir *(Zhang, 2022)*.

7.2.1. Basınç Yaralanması Evreleri

Basınç yaralanmalarının evrelemesi için farklı evreleme sistemleri kullanılabilmektedir. Burada en sıklıkla kullanılan evreleme sistemi olan NPUAP Sınıflandırma Sistemi'ne değinilecektir. Bu sınıflama sisteminde Evre1-4, Evrelendirilemeyen Evre ve Derin Doku hasarı olmak üzere altı evre ile ek iki tanımlama bulunmaktadır *(NPUAP, 2019)*.

NPUAP Evreleme Sistemi

Evre 1: Sağlam derinin basmakla solmayan eritemi mevcuttur. Deri bütünlüğü bozulmamıştır. Renk değişiklikleri mor ya da bordo renk değişikliğini içermez; bunlar derin doku hasarını işaret edebilir.

Evre 2: Dermisin açıkta olduğu kısmi kalınlıkta deri kaybı mevcuttur. Yara yatağı canlı, pembe-kırmızı renkte ve nemlidir. Üzerinde içi serum dolu bütünlüğü bozulmamış ya da rüptüre olmuş büller bulunabilir. Adipoz doku ya da daha derin dokular görünür değildir. Granülasyon dokusu, slough doku ya da eskar mevcut değildir.

Evre 3: Tam kalınlıkta deri kaybı mevcuttur. Ülserde adipoz doku görülebilir. Granülasyon dokusu ve epibol sıklıkla mevcuttur. Fasya, kas, tendon, bağ, kıkırdak ve/veya kemik açıkta değildir.

Evre 4: Tam kalınlıkta deri ve doku kaybı mevcuttur. Yara yatağında fasya, kas, tendon, bağ, kıkırdak ya da kemik görülebilir ya da palpe edilebilir. Slough doku ve eskar görülebilir.

Evrelendirilemeyen Evre: Gizlenmiş tam kalınlıkta deri ve doku kaybı mevcuttur. Ülser tamamen slough doku ya da eskar dokusu ile kaplıdır. Slough ya da eskar dokusu kaldırılırsa, Evre 3 veya Evre 4 basınç yaralanması ortaya çıkacaktır.

Derin Doku Hasarı: Bütünlüğü bozulmamış sağlam deride, lokalize bir alanda, basmakla solmayan, koyu kırmızı, bordo, mor renk değişikliği ya da koyu renkli yara yatağı ile içi kanla dolu kesecikleri gösteren epidermal ayrılma vardır. Eğer nekrotik doku, subkütan doku, granülasyon dokusu, fasya, kas ya da alttaki diğer yapılar görünür ise, burada derin doku hasarı tanımlaması kullanılmamalıdır.

Ek Tanımlamalar

Mukozal Membran Basınç Yaralanması: Yaralanma, alanında tıbbi araç kullanma hikayesi olan mukozal membranlar üzerinde gelişir. Bu yaralanma tipi evrelendirilemez.

Tıbbi Araç İlşkili Basınç Yaralanması: Teşhis veya tedavi amacı ile kullanılan tıbbi araçlar nedeni ile oluşmaktadır. Ortaya çıkan yaralanma genellikle cihazın modeline veya şekline uygundur. Yaralanma evreleme sistemi kullanılarak evrelenmeli ancak etyolojik neden belirtilmelidir.

7.2.2. Önleme ve Tedavi

7.2.2.1. Önleme

Basınç yaralarının önlenmesinde ilk basamağı basınç yaralanması açısından yüksek risk altındaki bireylerin belirlenmesi oluşturmaktadır. Prematüre bebekler, düşük doğum ağırlığına sahip olanlar, uzun süreli ventilasyon desteğine ihtiyaç duyulan çocuklar, nörolojik hastalığı olanlar, mobilizasyon kısıtlılığı olanlar, kronik hastalıkları olan çocuklar basınç yaralanmaları açısından risk altındadır.

Basınç yaralanmalarının önlenmesinde en önemli adımı hastanın hareket ettirilmesi oluşturmaktadır. Hareket edemeyen hastalarda düzenli pozisyon değişimi yapılmalıdır. Yatan hastaların en az iki saatte bir pozisyonu değiştirilmelidir.

Pediyatrik yaş grubunda cilt farklı özellikler göstermektedir. Cildin değerlendirilmesi, temizlenmesi ve bakımı önem arz eder.

Basınç yaralanmalarının önlenmesinde havalı yatak, yastık gibi destek yüzeyler kullanılabilir. Destek yüzeyler hastanın çevrilmesi, yeniden pozisyon verilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Hastanede yatan çocuklarda en sık tıbbi araç ilişkili basınç yaralanmaları görülmektedir. Tamamen önlenebilir yaralanmalardır. Hasta için uygun boyut ve özellikte cihazların kullanılması, mümkünse cihaz kullanımının en kısa sürede sonlandırılması, kullanılan cihazın altına koruyucu örtü uygulamaları, cihazın altında kalan derinin sık kontrol edilmesi tıbbi cihaz ilişkili yaralanmaların önlenmesinde etkili olacaktır.

Hastaların beslenme ve metabolik durumlarının değerlendirilmesi ve gerekli tedavilerin verilmesi basınç yaralarının önlemesinde etkilidir *(Karadağ vd., 2024; Ayar & Şahin, 2021).*

7.2.2.2. Tedavi

Hangi evrede olursa olsun basınç yaralanmasının nedeninin belirlenmesi ve yara bölgesi üzerindeki basıncın azaltılması gerekmektedir. Yara ayrıntılı olarak değerlendirilip, yara iyileşmesi için uygun nemli ortam sağlanmalı ve eksuda kontrol altına alınmalıdır. Yaranın uygun şekilde temizlenip gayta ve idrar kontaminasyonunun önlenmesi elzemdir. Yaranın temizlenmesi için normal salin önerilir. Yara enfeksiyondan korunmalı, gerekli durumlarda yara kültürü alınmalıdır. Yara iyileşmesi için hastaya ait faktörler gözden geçirilip, gerekli tedaviler verilmelidir.

Evre 1: Genellikle tedavi gerektirmez, kendiliğinden iyileşir. Hastanın cildi ıslak veya aşırı kuru tutulmamalıdır. Lokal pomatlar, çinko içerikli bariyer kremler kullanılabilir.

Evre 2: Genellikle basit pansumanlar ile iyileşir. Lokal pomatlar, çinko içerikli kremler kullanılabilir.

Evre 3: Tam kalınlıkta doku kaybı mevcuttur. Nekrotik dokular uzaklaştırılmalıdır. Cerrahi debridman yapılabilir. Cerrahi yapılamayan hastalarda otolitik ya da enzimatik debridman yapan yara bakım ürünleri kullanılabilir. Yaranın kapanması için farklı yara bakım ürünleri, uygun hastalarda negatif basınçlı yara kapama kullanılabilir. Yara bakım yöntemleri ile kapatılamayan veya erken kapama gereken hastalarda cerrahi kapama seçenekleri düşünülmelidir.

Evre 4: Tam kalınlıkta doku kaybı mevcuttur. Bakım ve tedavisi 3. Evre ile benzerdir. Kemiğin açıkta olduğu yaralarda osteomiyelit ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Evrelendirilemeyen Evre: Nekrotik dokular uzaklaştırıldıktan sonra yaranın evresi değerlendirilir. Evre 3-4 gibi tedavi edilir.

Derin Doku Hasarı: Koruyucu önlemler alınmalı, hastaya ait faktörler ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir *(Ayar & Şahin, 2021).*

Kaynakça

Ambe, P. C., Kurz, N. R., Nitschke, C., Odeh, S. F., Möslein, G., & Zirngibl, H. (2018). Intestinal Ostomy. Deutsches Arzteblatt international, 115(11), 182–187.

Ayar, G., & Şahin, Ş. (2021). Dermatolojik problemler ve yönetimi. In Z. Akelma (Ed.), Pediatri (1st ed., pp. 1261-1265).

Browning, J. D., & Stephany, H. A. (2018). Advances in Pediatric Urinary Diversion. The Urologic clinics of North America, 45(1), 123–132.

D'Ambrosio, F., Pappalardo, C., Scardigno, A., Maida, A., Ricciardi, R., & Calabrò, G. E. (2022). Peristomal Skin Complications in Ileostomy and Colostomy Patients: What We Need to Know from a Public Health Perspective. International journal of environmental research and public health, 20(1), 79.

Engida, A., Ayelign, T., Mahteme, B., Aida, T., & Abreham, B. (2016). Types and Indications of Colostomy and Determinants of Outcomes of Patients After Surgery. Ethiopian journal of health sciences, 26(2), 117–120.

European Pressure ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure ulcers/Injuries: Quick Reference Guide. EPUAP/NPIAP/PPPIA;2019.

Forest-Lalande, L. (2023). Best practice guidelines for ostomy care in neonates, children, and adolescents: An executive summary. Wound, Ostomy, and Continence Nursing, 50(5), 381– 385.

Gauderer, M. W. L., & Saad, D. F. (2011). Stomas of the small and large intestine. In R. J. Suchy, F. P. Heubi, & W. F. Balistreri (Eds.), Pediatric gastrointestinal and liver disease (4th ed. pp. 614-625).

Homan, M., Hauser, B., Romano, C., Tzivinikos, C., Torroni, F., Gottrand, F., Hojsak, I., Dall'Oglio, L., Thomson, M., Bontems, P., Narula, P., Furlano, R., Oliva, S., & Amil-Dias, J. (2021). Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Children: An Update to the ESPGHAN Position Paper. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 73(3), 415–426.

Karadağ A.,Şimşek E., & Semerci R.(2024) Çocuk hastalarda basınç yaralanması risk değerlendirmesi: Geleneksel derleme. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 16(2), 582-92.

Volsko, T. A., Parker, S. W., Deakins, K., Walsh, B. K., Fedor, K. L., Valika, T., Ginier, E., & Strickland, S. L. (2021). AARC Clinical Practice Guideline: Management of Pediatric Patients With Tracheostomy in the Acute Care Setting. Respiratory care, 66(1), 144–155.

Zhang, H., Ma, Y., Wang, Q., Zhang, X., & Han, L. (2022). Incidence and prevalence of pressure injuries in children patients: A systematic review and meta-analysis. Journal of tissue viability, 31(1), 142–151.

8. AİLE BAKIM EĞİTİMİ

Ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaç duyduğu bakımların tüm aşamasında varlığı ve katılımı iyi bir bakım sağlanması için esastır. Çocuk palyatif bakımda, çocuğun bakımını üstlenen ebeveyn ya da bakıcı için kişiselleştirilmiş bir bakım eğitimi verilmesi bakım verenin kontrol algısını artırmakta ve bakımın üstlenilmesini hızlandırabilmektedir *(Koch & Jones, 2018)*. Bu bölümde çocuk palyatif bakıma yatan çocuk ve ailelerine verilmesi önerilen eğitim konuları yer almaktadır.

8.1. Saturasyon Probu Kullanımı Eğitimi

Oksijen satürasyonunda değişmeye ilişkin belirti bulgular (solunum hızı, derinliği veya ritmindeki değişiklikler, solunum seslerinde değişme, siyanoz, huzursuzluk, konfüzyon, bilinç düzeyinde azalma, dispne) değerlendirilmeli, SpO2 alarm sınırları (en düşük değer %85, en yüksek değer %100) kontrol edilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021)*. Etkili ve doğru bir SpO2 ölçümü alabilmek için pulse oksimetre probu, oksijen satürasyon ölçümü yapılacak alana uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Ölçüm için kullanılacak klipsli ya da yapışkan proplar düz bir şekilde ve kan akımını bozmayacak sıkılıkta uygulanmalıdır *(Potter vd., 2023)*. Eğer sürekli SpO2 ölçümü yapılıyorsa sensörün altında kalan derinin bütünlüğü iki saatte bir kontrol edilmeli ve en az dört saatte bir yer değiştirilmelidir *(Potter vd., 2023; Snyder, Berman, Frandsen & Snyder, 2022)*.

8.2. Postüral Drenaj Eğitimi

Kontrendikasyon yoksa ve hekim uygun görüyorsa hastanın bol sıvı alması sağlanmalı ancak; oral ya da tüple beslenmeden sonraki 1-2 saat içinde postüral drenaj yapılmamalıdır. Sürekli tüple besleme yapılan hastalarda ise işlemden 30-45 dakika önce besleme durdurulmalı, rezidü 100ml'den fazla ise işleme başlanmamalıdır. Hasta inhale bronkodilatatör veya aerosol tedavi alıyorsa bu tedavilerden 20 dakika sonra postüral drenaj yapılmalıdır. Sıvı birikmiş alanları drene etmek için hastaya uygun pozisyon verilmeli, bu pozisyon 10-15 dakika korunarak perküsyon (göğüs kafesi üzerine kapalı parmaklar aracılığıyla vurma şeklinde, daha çok aşağıdan yukarıya doğru) yapılmalı, drenaj sonrasında hasta oturtturularak öksürtülmeli ya da aspire edilmelidir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bakım veren ile birlikte yapılarak gösterilmeli, mümkünse bir fizyoterapistle birlikte eğitim verilmelidir. Uygulama sıklığının hastaya göre değişebileceği gibi ve işlem için en uygun zaman sabah kahvaltı öncesi ya da yatmadan bir saat önce olarak önerilmektedir. Ayrıca; tüm işlem 30-60 dakikayı geçmemelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021)*.

8.3. Aspirasyon Uygulaması Eğitimi

Aspirasyon gerektiren alt ve üst solunum yolu tıkanıklığı belirtileri (inspirasyon ve ekspirasyonda hırıltı, hışırtı, huzursuzluk, etkisiz öksürme, solunum seslerinin tek taraflı, segmental ve lomber azlığı ya da yokluğu, takipne, siyanoz, fazla miktarda burun ve ağız içi sekresyon) değerlendirilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021)*. Aspirasyon ihtiyacı çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Ayrıca

solunum yolu enfeksiyonları sırasında aspirasyon ihtiyacı artabilir. Her çocuğun özelinde aspirasyon sıklığı belirlenmelidir. Trakeostomili bir çocuk hastanede yatarken aspirasyonun steril teknik kullanılarak yapılması gerekir. Eller güzelce yıkandıktan sonra steril eldiven giyilerek aspirasyona başlanır. Ancak evdeki aspirasyonlarda temiz teknik yeterli olacaktır, eller yıkandıktan sonra temiz tek kullanımlık eldivenlerle ve temiz bir kateter ile aspirasyon yapılır. Aspirasyon kateterinin boyutu trakeostomi tüpünün boyutuna bağlıdır. Trakeostomi kanülündeki açıklığın 2/3'ünü kapatacak kalınlıkta sonda tercih edilmelidir. Trakeada granülasyon dokusunun oluşmaması için aspirasyon sırasında kateterin trakeostomi tüpünün ucundan yaklaşık en fazla 1 cm kadar ileriye gitmesine izin verilmesi aile eğitimi sırasında önemle vurgulanmalıdır *(Erdem Eralp, 2020)*. Kateter ilerlemesinde zorluk olduğunda, inspirasyon sırasında kateter ilerletilmeye çalışılmalıdır. Boşaltılmak istenilen bronşiyal yolun ters tarafına hastanın başının çevrilmesi işlemin doğru yapılmasını sağlayacaktır. Mümkünse farengeal aspirasyondan önce trakea ya da ağız içi aspire edilmeli ve her bir işlem en fazla 10 saniye sürmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021)*.

Nazofarengeal aspirasyon için burun ucundan kulak memesine kadar olan mesafe kadar kateter ilerletilmelidir. Yapay hava yolu aspirasyonunda (trakeostomi) aspirasyon başlangıcında kateter kat (kıvırma) yapılarak ilerletilir, daha sonra kıvırdığınız nokta serbestleştirilerek (açarak) emiş sağlanır, kateter hafifçe döndürülerek geri çekilir. Kateter endotrakeal tüpün alt ucundan geçmiyorsa büyük olasılıkla tüpün distal ucundaki yan deliğe sıkışmıştır ve yavaşça döndürerek çıkarılabilir. Düz bir şekilde kateter yeniden ilerletildiğinde kateter yine ilerlemiyorsa mukus tıkaçları trakeostomi tüpünü tıkamış olabilir. Mukus tıkacı düşünülüyorsa aspirasyon öncesi 5 yaş altı için 0,5 ml, 5-15 yaş arası 1 ml serum fizyolojik trakeostomi tüpü içine konularak yeniden aspirasyon denenir. Aspirasyon sırasında solunum sıkıntısı gelişirse işlem hemen durdurulmalıdır. Gerekirse ambu ile düşük basınçlı solunum desteği verilir *(Potter vd., 2023)*. Tüm bu aşamalar bakım verene gösterilir ve gözetimli yaptırarak öğretilmelidir.

8.4. Trakeostomi Bakımı Eğitimi

Bakım öncesi eller yıkanmalıdır. Bakım yapılması gereken belirti bulgular (aşırı peristomal sekresyon, intratrakeal sekresyon, trakesotomi bağının ıslanması, trakeostomi tüpünden hava akımının azalması, obstrüksiyon belirti bulguları) değerlendirilmeli, trakeostomi giriş alanında yapışkan sekresyonlar varsa temizlenmelidir. Steril suyla temizlik yapıldıktan sonra cilt kurulanmalı ve trakeostomi pedinin trakeostomi tüpünün çevresine sıkıştırılması sağlanmalıdır. Trakeostomi pedlerinini her nemlendiğinde değiştirilmesi ve alanın kuru tutulması sağlanmalıdır. Stomatit olmaması için trakeostomi bakım sıklığının arttırılması ve kurumasının beklenmesi önemlidir. Gerekli durumlarda topikal antibakteriyel solüsyon uygulanması sadece stomanın altına hidrokolloid ya da transparan pansuman uygulanması önerilmektedir. Uzun süredir var olan, cildin iyi durumda olduğu ve sekresyonlarla ıslanmadığı trakeostomilerde trakeostomi pedi veya gazlı bez kullanılmasına gerek duyulmaz *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021)*.

8.5. Kazara Dekanülasyon Eğitimi

Hastanın tüpünün bazen trakeostomi bağları çok gevşek olduğunda veya çocuk hastanın tüpü çekip çıkarması ile kazara gerçekleşebilmektedir. Eğer trakeostomi tüpü yerinden çıkmış ve hastada solunum sıkıntısı ve saturasyon düşüklüğü varsa yeni ve steril bir tüp aramak yerine vakit kaybetmeden çıkmış olan tüp yerine takılmalıdır. Daha sonra uygun koşullarda yeni tüple değiştirilmelidir. Eğer yerine takılamıyorsa yedek olarak var olan bir küçük tüp takılmalıdır. Böyle bir durumda aileye de evde şunları yapması önerilir:

Çocuğun boynunu hafifçe geriye atıp, çıkmış olan trakeostomi tüpünü hemen yavaşça itekleyerek zorlamadan yerine tekrar yerleştirin. Yedek olarak bir küçük boy kanül bulundurun, diğer kanülü takamazsanız bunu yerleştirin. Eğer kanül hiçbir şekilde takılamazsa kanül yerini gazlı bezle kapatın, oksijen ve ambu ile ağızdan nefes verin ve acil çağrı merkezini arayın *(Erdem Eralp, 2020).*

8.6. Evde Mekanik Ventilasyon Takip Eğitimi

Eve mekanik ventilasyon desteği ile taburcu edilen hastalar için hasta ve yakınları, sağlık personeli ve tıbbi araç sağlayan şirket temsilcisinden oluşan multidisipliner bir ekipten eğitim almalıdır. Hasta ve yakınları ventilatör modlarında veya ayarlarında değişiklik yapmamalı ancak ventilasyon aksaklıklarının nedenlerini saptayabilmelidir. Özellikle ekran üzerinde dokunmatik olarak ayarların yapıldığı cihazlarda olmak üzere tüm cihazlar için aileye kapalı mod gösterilmeli ve cihazın her zaman kilitli modda olduğundan emin olunmalıdır. Hava yolu basıncında artma ve azalma durumlarında; sekresyonlar temizlenmeli, hastaya uygun pozisyon verilmeli, trakeostomi tüpünün yerinde olup olmadığı kontrol edilmeli ve ventilatör bağlantıları kontrol edilmelidir *(Potter vd., 2023).* Ventilatör ile mekanik arıza durumlarında tıbbi aracı sağlayan şirketten telefonla ve evde destek alabilmeli, gerekirse cihaz tamire gittiğinde şirket tarafından yedek cihaz sağlanmalıdır.

8.7. Beslenme Tüpü ile Beslenme Eğitimi

Tüpün yerinde olup olmadığı aralıklı beslenen bireylerde her beslenmeden, sürekli beslenenlerde ise 4-12 saatte bir ve ilaç verilmeden hemen önce aspire edilerek kontrol edilmelidir. Aspire edilen içeriğin kırmızı veya kahverengi olması, mide rezidüel volümünün fazla olması durumlarında hastanın başı 30 derece yükseltilmeli ve hekime haber verilmelidir. Hava veya sıvının tüpten verilememesi tüpün tıkalı olduğunu göstermektedir. Bu durumun önlenmesi için de beslenme tüpü her beslenme ve ilaç uygulaması öncesinde ve sonrasında rutin olarak yıkanmalı, hasta başı 30 derece yükseltilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021).*

Beslenme tüpü ile enteral besleme yapılıyorsa özel tıbbi amaçlı gıdanın oda sıcaklığında, homojen olmasına, beslenme sırasında sette hava olmamasına ve setin her 24 saatte bir değiştirilmesine dikkat edilmelidir. Üretici firmaya göre farklılık göstermekle birlikte özel tıbbi amaçlı gıda açıldıktan sonra oda ısısında sekiz saat, buzdolabında 24 saat stabil kalabilmektedir. Gastrostomi veya jejunostominin abdominal insizyon bölgesindeki drenajı (kanama, enfeksiyon veya obstrüksiyon belirtileri) olması durumunda hekime haber verilmelidir *(Potter vd., 2023).*

8.8. İlaç Uygulamaları Eğitimi

Sublingual ve bukkal uygulanan ilaçların yutulmamasına dikkat edilmelidir. Nazogastrik tüp yolu ile her ilaç uygulamasından önce beslenme tüpünün yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tabletler tamamen toz haline gelene kadar ezilmeli, uygun olan kapsül ilaçların ise içindeki toz ya da granüller çıkarılarak verilmelidir. Her ilaç uygulamasından sonra su ile yıkama yapılmalı, klemplenmeli ve yatak başı yüksek tutulmalıdır. Eğer sürekli besleme yapılıyorsa ilaç uygulamasından sonra bir saat beslenmeye ara verilmesi önerilmektedir. Transdermal yama/flaster uygulamadan önce eski yama çıkarılmalı, yenisinin üstüne tarih ve saat yazılmalı, tüysüz kuru ve temiz bir bölgeye yerleştirilmelidir.Subkutan enjeksiyonlar için uygun bölgeler dönüşümlü olarak kullanılmalı, iğne 45-90 derecelik açı ile dokuya girdikten sonra hareket ettirilmemelidir. Enjeksiyon bölgesine masaj yapılmamalı, hafif bir basınç uygulanmalıdır *(Potter vd., 2023; Snyder vd., 2022).*

8.9. Kişisel Hijyenin Sağlanması Eğitimi

İmmobil ya da kısmen hareket edebilen çocuklara banyo yaptırırken deri bütünlüğünün bozulma belirtilerine (kızarıklık, ödem, soyulma, inflamasyon, aşırı nem, kuruluk, pullanma vb.) dikkat edilmeli, kızarıklık olan bölgelere masaj yapılmamalıdır *(Potter vd., 2023).* Karın ve kasıktaki deri kıvrımları, parmak araları ve ayaklar yıkandıktan sonra mutlaka kurulanmalıdır *(Potter vd., 2023; Snyder vd., 2022; Stein & Hollen, 2021).*

Perine bakımı immobil çocuklarda dorsal rekümbent poziyonu verilerek tek kullanımlık temiz bezlerle yapılır. Eğer hastada kateter varsa kateterin gerilmemesine ve çevresinin tamamen temizlenmesine dikkat edilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021).*

Ağız bakım sıklığı çocuğun rahatlık seviyesine ve ağız boşluğunun durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bakım için diş fırçası ve macun kullanılabilmektedir. Diş fırçalama yapılırken öğürme refleksinin uyarılmasından kaçınılmalıdır. Ağız bakımı sırasında dişeti kenarlarında ya da mukozada lokalize inflamasyon, kanama, kuruluk veya plak oluşumlarına dikkat edilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021).*

Gözler, her göz için temiz bir bez kullanılarak iç kantüsten dış kantüse doğru sadece ılık su ile silinmelidir. Göz kapağında herhangi bir çapaklanma varsa çıkarmayı denemeden önce 2-3 dakika ılık su ile ıslatarak bekletilmelidir. Göz kırpma refleksi kaybolan bilinçsiz hastalarda kornea kuruluğu, göz enfeksiyonu ve sürtünerek aşınma problemleri yaşanabildiği için bakımdan sonra hekim istemine uygun olarak göz damlası uygulanabilir *(Potter vd., 2023; Snyder vd., 2022; 2022; Stein & Hollen, 2021).*

Üç yaşından küçük çocuklarda dış kanalı temizlenmesi için kulak kepçesi aşağı ve geriye, üç yaşından büyük çocuklarda ise aşağı ve geriye doğru çekilmelidir *(Potter vd., 2023; Snyder vd., 2022).*

8.10. Venöz Kateter Bakım Eğitimi

Kateter giriş yeri kızarıklık ya da solukluk, ödem, dokunulduğunda soğukluk ve ağrı, sızıntı, eksuda ve kanama açısından değerlendirilmelidir. Periferik olarak yerleştirilen santral kateterler ve bağlantı seti; sızıntı, yırtılma, ayrılma ve çatlama yönünden gözlemlenmelidir. Pansuman değiştirilmek istenildiğinde; eski pansuman kateterin yerleştirildiği yöne doğru dikkatle çıkarılarak dairesel hareketlerle kateterin giriş noktasından dışa doğru antiseptik solüsyonla temizlenmeli, enfeksiyon belirti bulguları yönünden değerlendirilmeli ve temiz gazlı bez ile kapatılmalıdır *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021).*

8.11. Üriner Kateter Bakım Eğitimi

Perine bakımı yapıldıktan sonra, üretral meatus ve çevresindeki dokular inflamasyon, akıntı, şişlik açısından değerlendirilmelidir. Üretral meatus çevresinde kabuklanma ya da tortu birikimi varsa temizlenmeli, kateterin gergin olmaması sağlanmalıdır. Üriner kateterin drenaj tüpünün kıvrılmamasına, idrar torbasının mesane seviyesinin altında olmasına ve en az sekiz saatte bir boşaltılmasına dikkat edilmelidir *(Potter vd., 2023; Stein & Hollen, 2021).*

Kaynakça

Erdem Eralp, E., (2020). Sağlık Çalışanları için Trakeostomili Çocuk Bakım ve İzlem Kitapçığı. Sağlık Çalışanları için Trakeostomili Çocuk Bakım ve İzlem Kitapçığı (pp.1-56), İstanbul: Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği.

Koch KD, Jones BL. Supporting Parent Caregivers of Children with Life-Limiting Illness. Children. Jones BL.(2018); 5(7):85. https://doi.org/10.3390/children5070085

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2023). Fundamentals of nursing-e-book. Elsevier health sciences.

Snyder, C., Berman, A. T., Frandsen, G., & Snyder, S. J. (2022). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing, eBook, Global Eition.

Stein, L. N. M., & Hollen, C. J. (2021). Concept-Based Clinical Nursing Skills: Fundamental to Advanced. Elsevier Health Sciences.

9. ÇOCUK, AİLE VE BAKIM VERENLER İLE İLETİŞİM

Çocuklarda palyatif bakım süreci psikososyal ve manevi ihtiyaçların da değerlendirilip yönetilmesini içerir. Mümkünse yas süreci boyunca aileyi desteklemek hedeftir *(Kostak & Akan, 2011)*. Çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak, aileleri, arkadaşları, okulları ve diğer sosyal çevreleriyle bağlantılı olarak kendilerine özgü palyatif bakım ihtiyaçlarına sahiptir *(Liben vd., 2008)*.

Terminal dönemde sağlanan palyatif bakım, yas sürecini yaşayan ailelerin işlevlerini ve bütünlüklerini korumalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır *(Michelson & Steinhorn, 2007; Özdemir & Karabucak, 2016)*. Bu bakım, gereksiz ve zararlı tedavilerin önüne geçilmesini sağlarken, hasta ve ailenin tedavi hakkında bilinçli tercihler yapmasına olanak tanır. Ayrıca, yaşam süresinin kalan kısmında otonomi sağlamaya yardımcı olur; ağır hastalıkla mücadele eden çocukların yaşamlarının anlam ve amacı olduğunu vurgular, yaklaşan ölümle başa çıkmalarını destekler ve geride anlamlı hatıralar bırakmalarına olanak tanır *(Moody vd., 2011)*.

9.1. Kronik Hastalık Sürecinin Etkileri

9.1.1. Aileler Üzerindeki Etkisi

Kronik hastalık, ailenin dinamiklerini derinden etkiler. Ebeveynler hastalığın, çocuklarının dolu ve mutlu bir yaşam sürme potansiyeline önemli bir engel teşkil ettiğini fark ettiklerinde, genellikle derin bir kayıp ve kırgınlık hissi yaşarlar *(Patrick-Ott & Ladd, 2010)*. İlk tepkileri çoğunlukla çocuklarını kaybetme ihtimali karşısında duydukları şok ve yoğun korku duygularıdır *(Lou vd., 2015; Waldman & Wolfe, 2013)*. Ardından öfke ve içerleme hissedebilir, eşlerini, kendini veya başkalarını suçlama eğilimi gösterebilirler. Bu süreç genellikle ebeveynlerin hastalığı kabullenmesiyle sona erer *(Lou vd., 2015)*. Bu süreçte çocuklar, ebeveynlerinin yaşadıkları kaygı ve stresten etkilenir ve bu durum psikolojik gelişimlerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aile içindeki bu değişim, yas sürecinin başlamasına ve aile dinamiklerinin yeniden şekillenmesine yol açar *(Ceylan, 2016)*.

9.1.2. Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Kronik hastalığı olan çocuklar, fiziksel gelişimde yavaşlama veya değişiklikler, düzenli tıbbi işlemler, ani sağlık sorunları ve okuldan geri kalma gibi pek çok stresli durumla başa çıkmak zorundadır. Ayrıca, sağlıklı akranları gibi aynı gelişimsel görevleri ve zorlukları da aşmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bu çocukların yaşadığı tüm bu zorluklar, kronik hastalığı olan çocuklarda psikososyal uyum bozukluklarına yol açabilmektedir *(Brown & Kupst, 2016)*. Araştırmalar, bu çocukların akranlarına göre daha fazla duygusal ve davranışsal sorun yaşadığını göstermektedir *(Immelt, 2006)*. Yaş dönemlerine göre çocukların yaşadıkları hastalık sürecini anlamlandırmaları ve tepkileri değişkenlik gösterir.

9.1.2.1. Çocuklarda Farklı Yaş Dönemlerinde Kronik Hastalığın Etkileri

I. 0-2 Yaş: Bu dönemde yaşanan travmatik anılar, bedensel duyumlar olarak hafızada kalır. Çocuk, ebeveynlerinin kaygılarından etkilenir.

II. Okul Öncesi Dönem (2-6 Yaş): Genellikle hastalığın nedenini anlamakta zorlanabilir ve bu durumu kendilerine yönelik bir ceza olarak değerlendirebilirler. Bazıları haksızlığa uğradıklarını düşünebilir *(Schonfeld, 2002)*. Çocuklar hastalığı somut olaylarla ilişkilendirebilir; büyüsel düşünce ve benmerkezcilik nedeniyle yanlış anlamalar yaşanabilir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, hastalığı ebeveynlerinin tepkilerinden ayırt edemez. Bu nedenle, ebeveynlerin hastalığı gerçekçi bir bakış açısıyla kabullenme derecesi ve duygusal tepkilerini çocuklarına ne ölçüde yansıttıkları, çocukların ilerleyen süreçte duruma uyum sağlamaları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir *(Ceylan, 2016)*. Çocuğun duygusal desteği yeterince sağlanmadığında içe kapanma veya öfke sorunları gözlenebilmektedir. Strese bağlı sonradan ortaya çıkabilen alt ıslatma, özbakımında ebeveyne bağımlılık ya da isteklerini işaret ya de bebeksi konuşma ile anlatma şeklinde regresif davranışlar gözlenebilmektedir.

> **Öneriler:** Çocuğun hastalığın bir ceza olmadığını veya hatalı bir davranışından dolayı ortaya çıkmadığını anlaması için ailesinin ve tedavi ekibinin süreğen desteğine ihtiyacı vardır. Hastalığın açıklamaları basit ve kısa cümlelerle yapılmalı, güvenli alanlar oluşturulmalıdır. Duygusal destek sağlamak, kaygıyı azaltabilir *(Himebauch vd., 2008; Kurtz vd., 2010; Özdemir & Karabucak, 2016)*.

III. Okul Çağı (6-12 Yaş): Bu dönemde çocuklar hastalığı daha iyi anlayabildikleri ve hastalığı kendilerinden ayırmaya başladıklarından baş etme becerileri genellikle daha iyidir. Hastalık başlangıcında regresyon görülebilir. Yaşadıkları stres, hastalığın seyri, yapılan girişimler çocuğun uyumu ve işlevselliğini etkileyebilir. Bu yaş grubundaki çocuklar terminal dönemde iken kalan zamanlarının sınırlı olduğunun bilincinde olabilirler; fakat ölümün geri dönülmez bir durum olduğunu kavramakta güçlük çekebilirler.

> **Öneriler:** Yaşa uygun aktiviteler (resim, yapboz, el işi, bilgisayar oyunları, vb.) sunarak çocukların işlevselliğini artırmak önemlidir. Bu sayede çocuğun çaresizlik ve kontrol kaybına ilişkin duyguları azalır ve çocuğun süreçle baş etmesi kolaylaşır. Çocuğa hastalık hakkında kısa, doğru bilgiler sunarak, ayrıca uygulanan tedavi ve tedavi hedefleriyle ilgili çocuğun anlayacağı bir dille bilgi vermek klinisyenle çocuk arasında bir ilişki kurulmasını ve çocuğun uyumunun artmasını kolaylaştırabilir *(Himebauch vd., 2008; Rennick & Rashotte, 2009)*.

IV. Ergenlik Dönemi (12 Yaş ve Üzeri): Ergenlik döneminde beden algısı, bağımsızlık, cinsel gelişim ve kişilik gelişimi ön plandadır. Ebeveynlerden bağımsızlaşma ve kimlik oluşturma çabası içinde olan ergenler için hastalığın kendisi temel sorundur. Hastalığın neden olduğu fiziksel kısıtlamalar ve bağımlılıklar nedeniyle, kronik hastalığı olan ergenlerde depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik

sorunların görülme olasılığı daha yüksektir *(Bruzzese vd., 2009; Pinquart & Shen, 2011)*. Ebeveynlerine daha bağımlı hale gelmeleri onlarda hoşnutsuzluk, öfke ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu dönemde ergenler ölümün kalıcı olduğu anlayışına ulaşırlar.

Öneriler: Görüşmeler, ergenin otonomi isteğini destekleyecek şekilde düzenlenmeli; fiziksel mahremiyet sağlanmalıdır. Ebeveynlerle olan ilişkilerde dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir *(Lewinsohn vd., 1996; Özdemir & Karabucak, 2016)*.

9.2. Palyatif Bakımda Etkili İletişim

9.2.1. İletişimin Temel İlkeleri

Palyatif bakımda iletişim, sağlık hizmeti sunucularının sadece bilgi aktardığı bir süreç olmaktan öte, ailelerin duygusal deneyimlerini anlamalarına ve kabul etmelerine yardımcı olur. Bu bağlamda, etkili iletişim, sağlık profesyonellerinin ailelerle empati kurabilmesi ve onların kaygılarını giderebilmesi için bir araçtır *(Levetown & Bioethics, 2008)*.

Palyatif bakım sürecinde, sağlık profesyonellerinin kullanması gereken temel iletişim bileşenleri şunlardır:

1. ***Bilişsel İletişim:*** Ailelerin çocuklarının durumu hakkında net ve doğru bilgiye ihtiyaçları vardır. Sağlık profesyonellerinin, tıbbi terimlerden kaçınarak, açık ve anlaşılır bir dil kullanmaları gerekmektedir. Bu, ailelerin hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini anlamalarını kolaylaştırır.

2. ***Duygusal Duyarlılık:*** Palyatif bakım, sıkça kötü haber vermeyi içerir. Kötü haber, hastanın geleceğini etkileyen ya da mevcut yaşam tarzını altüst edebilecek bilgi olarak tanımlanabilir. Bu tür durumlarda, duygusal iletişim büyük önem taşır. Ailelerin hislerini anlamak ve kabul etmek onların daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olur *(Levetown & Bioethics, 2008)*.

3. ***İş Birliği ve Ekip Çalışması:*** Palyatif bakımda, sağlık ekibinin tüm üyeleri arasında etkili bir iletişim sağlamak esastır. Hemşireler, genellikle hasta ile en fazla zaman geçiren profesyonellerdir ve bu nedenle ailenin hislerini ve anlayışını en iyi şekilde değerlendirebilirler. Ekip çalışması, ailenin tedavi sürecine aktif katılımını teşvik eder *(Pirie, 2012)*.

9.2.2. Ailelerle Etkili İletişimin Önemi

Etkili iletişim, hem sağlık profesyonellerinin hem de ailelerin duygusal ve bilişsel ihtiyaçlarını karşılamak için kritik bir unsurdur. Bütüncül ve aile merkezli bakımın temel taşı olan iletişim, hastanın ve ailenin karmaşık ihtiyaçlarına yanıt vermelidir *(Organization, 2009)*. Bilgilendirici, duyarlı ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım, ebeveyn-çocuk-hekim iletişiminde kritik öneme sahiptir. Bu unsurlar, bakım sürecinin etkinliğini artırarak, hasta ve ailelerin deneyimlerini olumlu yönde etkiler *(Pirie, 2012)*.

Ağır hastalığa sahip bir çocukla ve ailesiyle etkili bir iletişim kurmak:

- Çocuğun ve ailenin hastalığa veya tedaviye bağlı olarak yaşayabileceği zorlukları öngörebilmelerine,
- Bakım sürecinde bilinçli ve yerinde kararlar alabilmelerine,
- Klinik durumları ve ölüm gerçeğiyle baş edebilmelerine,
- Hem hastalık hem de tedavi nedeniyle oluşabilecek kafa karışıklığı, kaygı veya depresyon düzeyini azaltmalarına,
- Klinisyenler tarafından saygı gördüklerini hissetmelerine,
- Sağlık ekibiyle güven temelli bir ilişki geliştirmelerine,
- Sürekli destek alarak bilgi edinmelerine ve karar verme süreçlerinde kolaylık yaşamalarına olanak sağlar *(Mack & Hinds, 2011).*

Hasta memnuniyetsizliği, yetersiz iletişim becerileri ve etkisiz iletişim tarzları nedeniyle yaygın olarak görülmektedir *(Price vd., 2006).* Aileler, sağlık çalışanlarıyla etkileşimde bulunduklarında kendilerine saygı duyulmadığını hissettiklerinde veya endişelerinin göz ardı edildiğini düşündüklerinde sağlanan bilgiden memnun kalmadıklarını belirtmektedirler. Yapılan çalışmalar, ailelerin çocuklarının durumu, olası sonuçlar ve hastalığın prognozu hakkında mümkün olan en fazla bilgiye ulaşmak istediklerini göstermektedir. Sağlık çalışanları, ailelerin bilişsel ve duygusal iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bilgi sunmalıdır *(Levetown & Bioethics, 2008).*

Bilgi sunumu, çocuğun ve ailenin gereksinimlerine göre uyarlanmalıdır. Çocuk ve aileyle yapılacak görüşmeler sessiz bir ortamda ve önceden planlanmış bir şekilde gerçekleştirilmelidir; bu görüşmelerin, ideal olarak çocuğun nispeten iyi durumda olduğu zamanlarda yapılması tercih edilir. Palyatif bakım ekibi, görüşmeye başlamadan önce, ailenin çocuğun hastalığına dair mevcut anlayışını ve bu durumun hastalık süreci ile yaşam beklentisine olan etkilerini değerlendirmelidir. Başlangıçta, "Çocuğunuzun hastalığının seyri hakkında ileride neler olabileceğini düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilebilir. Hastalığın gidişatını ele alan konuşmalarda, ailenin bu tür bir diyaloğa hazır olup olmadığını değerlendirmek önem taşır. Klinisyen, "Siz ve çocuğunuz için ileride olabilecek durumlar hakkında konuşmak sizin için yararlı olur mu?" diye sorarak ailenin bu konudaki isteğini değerlendirebilir *(Öztek Çelebi, 2021).* Fakat aileler her zaman bu konuları konuşmaya hazır veya istekli olmayabilirler. Eğer acil bir gereklilik yoksa aile bu o an için zorlanmamalı, uygun bir vakitte tekrar gündeme getirilmelidir *(Hak vd., 2000).* Aile bilgi talep ettiğinde ise ailenin bilgiye dair ihtiyaçları ve tercihlerinin değerlendirilmesi, sağlık profesyonellerinin aileye en uygun şekilde bilgi sunmalarını kolaylaştıracaktır *(Öztek Çelebi, 2021).*

9.2.3. Kötü Haber Verme Süreci

Kötü haber vermek, çoğu sağlık profesyonelinin karşılaştığı zor bir durumdur. Dr. Chris Feudnter tarafından geliştirilen bir model, bu süreci üç aşamada ele alır:

1. ***Hazırlık Aşaması:*** Bu aşamada, sağlık profesyonelleri kötü haber vermeden önce, ne söyleyeceklerini ve hangi ortamda konuşacaklarını planlamalıdır. Ayrıca, ailenin kültürel inançlarını anlamak, iletişimde daha etkili olmalarına yardımcı olur.

2. ***İletişim Aşaması:*** Bu aşama, kötü haberin açıkça verildiği ve aileye saygı gösterildiği bir süreçtir. Sağlık profesyoneli, hasta durumunu özetlemeli, aileyi olumsuz habere hazırlamalı ve ardından kötü haberi açık bir şekilde iletmelidir. Kötü haberin verilmesinin ardından terapötik bir sessizlik sağlanarak ailenin durumuna duyulan saygı ve empati ifade edilmelidir. Ailelerin varsa soruları yanıtlanarak kafa karışıklıkları giderilmelidir.

3. ***Planlama Aşaması:*** Kötü haber verildikten sonra, çocuğun mevcut durumu ve tedavi hedefleri yeniden gözden geçirilmelidir. Görüşmeleri gelecekteki iletişim ve takip planlarıyla sonlandırmak, ailenin kendini yalnız hissetmesini önler ve iletişimde süreğen bir destek bulmasına yardımcı olur *(Feudtner, 2007).*

9.3. Aile-Çocuk İletişimi

Ebeveyn-çocuk iletişimi, ebeveynler ve çocukların karşılıklı anlayış, güven ve işbirliğini geliştirmek için bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarını paylaştıkları bir süreçtir *(Gawinski vd., 2021).* Çocukların düşünce ve duygularını anlamada, onların kaygı ve depresyonunu hafifletmede, uyumlu aile ilişkilerini teşvik etmede ve aile bütünlüğünü güçlendirmede önemli bir rol oynar *(Orm vd., 2022; Son vd., 2019).* Uygun ve etkili iletişim sayesinde çocuğun çıkarları doğrultusunda en iyi kararı verme ve bakım planlamasının yapılması sağlanabilir *(Akard vd., 2019).* Ebeveynlerin, çocuklarıyla tedavi ve semptomların hafifletilmesi konusundaki hedefleri ve tercihleri hakkında iletişim kurmaları ve yaşamı tehdit eden hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarında duygusal durumlarını anlamaları çok önemlidir *(Son & Miller, 2023).* Çocukların da ebeveynlerinden hastalığın teşhisi, ilerlemesi, tedavileri ve profesyonellerin geri bildirimleri hakkında bilgi almaya ihtiyaçları vardır *(Yamaji vd., 2022).*

9.3.1. Aile-Çocuk İletişiminde Kolaylaştırıcı Faktörler

I. Güven Oluşturma ve Olumlu İletişim:

- Çocuklar kanser gibi ciddi hastalıklar sürecinde kendilerini yalnız hissedebilir ve yaşadıkları fiziksel ve psikolojik sıkıntıları paylaşmak ister. Aile, çocuğa en yakın ve güvenilir kişidir. Güven ve samimiyete dayalı bir ilişki çocuğun anlayabileceği ve kabul edebileceği bir iletişimin temelidir.
- Ebeveynlerin, çocuklarını dinleme, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olma, duyguları

yönetme ve çatışmalarla başa çıkma konusunda yardımcı olabilmeleri oldukça önem taşır.

- Olumlu iletişim, sıcaklık, çocuk merkezlilik, duyarlılık, açıklık, dürüstlük, umut, doğallık, rahatlama, yardımseverlik ve çocuğun duygusal tepkilerine olumlu yanıt verme ile karakterizedir *(Badarau vd., 2015; Slaninka vd., 2021; Smith vd., 2019).*
- Ebeveynler ve çocuklar iletişimde eşittir. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişimlerinde yöneticilik rolüne girmekten kaçınarak, çocukları üzerindeki kontrol ve yönlendirme düzeyini en aza indirmelidir. Böylece çocukların kendi duygularını ifade etmeleri ve sürece katılımları kolaylaşacaktır *(Badarau vd., 2015; Young vd., 2003).*

II. Anı Biriktirme

- Çocuğun aileyle hatıralar biriktirmesi ve özel anlar yaratması, hem çocuk hem de ebeveyn için rahatlatıcı bir süreçtir. Anı biriktirme, çocuğun hayatının son aylarında aile üyeleri ve arkadaşlarla anlamlı ve keyifli anlar paylaşmasını ve bu anların kayıt altına alınmasını içerir.
- Çocuklar başkaları için el işleri yapma, eşyalarını vasiyet etme, sevdiklerine mektuplar yazma ve onlara hediyeler hazırlama gibi etkinliklerle aile içinde kalıcı anılar bırakabilir *(Foster vd., 2009).*
- Bu tür etkinlikler, çocuğun aile ve arkadaşlar arasında kalıcı anılar oluşturmasına yardım eder. Aynı zamanda anı biriktirme, ebeveynlerin ve çocukların gerçeği kabul etmelerine ve açıkça iletişim kurmalarına yardımcı olur *(Akard vd., 2021).*

III. Oyun Terapisi:

- Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda oyun terapisi, duygusal ifade ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmede etkili bir yöntemdir.
- Çoğu çalışma, terapistin çocukla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalardır. Bu, kum tepsisi kullanma, resim yapma, kostüm giyme ve çizim yapma gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir *(Van Breemen, 2009).* Bu etkinlikler genellikle yaklaşık 30 dakika ile sınırlıdır *(Li vd., 2023).*
- Oyun sırasında çocuklar, hastalığın önemini daha iyi anlayabilir ve ebeveynlerine hastalığın belirsiz ve açıklanamaz yönlerini (örneğin, saç dökülmesi, hastalığın doğasını açıklama) iletmelerine ve zor kararlar almalarına yardımcı olabilir *(Koukourikos vd., 2015).*
- Oyun terapisinin, çocukların duygusal sıkıntılarını ve anormal davranışlarını hafiflettiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir *(Kenny vd., 2021; Koukourikos vd., 2015).*

9.3.2. Aile-Çocuk İletişiminde Karşılaşılan Zorluklar

I. İnkar

İnkarın üç alt teması bulunmaktadır:

1. ***Gerçekçi olmayan düşünceler:*** Ebeveynler hala çocuklarının hastalığının tedavi edilebileceğini ummaktadır. Bu gerçekçi olmayan umut, çocuklarına gerçeği söyleme konusunda isteksiz olmalarına neden olmaktadır *(Smith vd., 2019).* Ebeveynler, tedavi süreci boyunca bu umudun kendilerini ve çocuklarını ayakta tutacağına inanırlar *(Zhang vd., 2024).*

2. ***Korku:*** Korku, iletişim sürecinde önemli bir engeldir *(Badarau vd., 2015).* Özellikle ebeveynler, hastalığın yaşamı tehdit eden doğasını açıklamaktan çekinir. Çocuklarına gerçeği söylediklerinde, çocuklarının tedaviden vazgeçeceğinden veya öfke, üzüntü ya da hayal kırıklığı gibi güçlü tepkiler vereceğinden endişe ederler. Ayrıca, iletişim sırasında çocuklarının duygusal tepkilerini ve reaksiyonlarını yönetmekte zorlanabileceklerini düşünürler *(Zhang vd., 2024).*

3. ***Zaman, fırsat ve güven eksikliği:*** Tedavi sürecinde, ebeveynler çocuklarını bilgilendirmek için uygun zamanın ne olduğu konusunda belirsizlik yaşayabilirler *(van der Geest vd., 2015).* Çocuklarıyla konuşmak isteseler de, bilgi paylaşımı için yeterli zaman ve fırsat bulamamaktan dolayı bunu nasıl yapacaklarını bilemeyebilirler *(Keim vd., 2017; Kenney vd., 2021).* Ayrıca, bazı ebeveynler çocuklarının ölümünün ani gerçekleştiğini ve tedavi düzenlemelerinin çok zaman aldığını, bu yüzden çocuklarıyla bu konuyu konuşma fırsatı bulamadıklarını ifade etmişlerdir *(Kenney vd., 2021).*

II. Hazırlıksız Olma ve Kaçınmacı Tutum

Ebeveynler, kendilerini yeterince hazır hissetmedikleri için çocuklarıyla iletişim kurmaktan kaçınabilirler. Bu durum, iletişime nasıl başlayacaklarını bilememe, çocuklarının zorlayıcı sorularını yanıtlayamama, hassas son dönem konularını ele alamama ve hastalıkla ilgili bilgi veya iletişim becerilerinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır *(Akard vd., 2021; Atout vd., 2019; Badarau vd., 2015; Gibson vd., 2018).* Ayrıca, bazı çocuklar bu konuları tartışmaya ve kötü haberleri ya da ölümle ilgili meseleleri kabullenmeye hazır değildir *(van der Geest vd., 2015).* Bazı ebeveynler, hekimin verdiği bilgiyi süzerek yalnızca uygun gördükleri kısımları çocuklarına aktarıp ciddi konuları dışarda bırakabilmektedir *(Bahrami vd., 2017; Young vd., 2003).* Ebeveynlerin kaçınması, çocuğun durumları hakkında güvensiz ve kafası karışık hissetmesine ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin yabancılaşmasına neden olabilir *(Heeyeon Son & Nancy Crego, 2020).*

Sağlık Profesyonellerine Öneriler:

- ***Kaçınmayı Engelleyin:*** Ebeveynlerin kaçınma davranışlarını tanınmalı ve bu konuda farkındalık oluşturularak, bu tarz tutumların olabildiğince önüne geçilmelidir *(Zhang vd., 2024).*

- ***Şeffaf ve Dürüst Bilgilendirme Yapın:*** Çocuklara hastalıklarıyla ilgili doğru ve açık bilgi verilmesi, onların güvende hissetmelerini ve durumlarını anlamalarını sağlar. Olumsuz bilgileri saklamadan, ebeveynlerin bu bilgileri açık bir şekilde paylaşmaları teşvik edilmelidir *(Beale vd., 2005; Jalmsell vd., 2016).*
- ***Güvenli Bir İletişim Ortamı Yaratın:*** Çocukların kendilerini ifade edebileceği ve duygularını paylaşabileceği bir ortam sağlanmalı ve ebeveynler bu doğrultuda yönlendirilmelidir. Çocukların endişelerini paylaşmaları, karşılıklı iletişimi güçlendirir *(Zhang vd., 2024).*
- ***Gerçekle Yüzleşme Stratejileri Geliştirin:*** Ebeveynlere, çocuklarıyla birlikte gerçeklerle yüzleşme konusunda stratejiler öğretilebilir. Bu süreçte, çocuğun yüksek yararı gözetilerek, karar verme süreçlerinde onlara ve ebeveynlere rehberlik edilmelidir *(Gaab vd., 2013).*

III. Karşılıklı Korumacı Tutum

Ebeveynler ve çocuklar arasındaki karşılıklı korumacı tutum iletişimde önemli bir engel teşkil eder *(Atout vd., 2019; Heeyeon Son & Nancy Crego, 2020; Nuss, 2014; Slaninka vd., 2021).* Karşılıklı koruma eğilimi, bilgi ve duyguların paylaşımını engellemektedir *(Stanek vd., 2022).* Ebeveynler, çocuklarını duygusal acıdan korumak için genellikle duygularını bastırmayı, çocuklarını ve diğer aile üyelerini korumayı tercih eder. Çocuklar ise, ebeveynlerini üzmekten ve onların psikolojik yükünü artırmaktan kaçınmak için kendi şüphelerini veya psikolojik sıkıntılarını paylaşmaktan çekinirler *(Zhang vd., 2024).*

Sağlık Profesyonellerine Öneriler:

- ***Karşılıklı korumayı tanıyın:*** Hangi ailelerin karşılıklı koruma riski taşıdığı belirlenmelidir.
- ***Dezavantajları aktarın:*** Karşılıklı korumanın olumsuz etkileri hakkında ailelere bilgi verilmelidir. Bu iletişim biçiminin aile içindeki dengeyi artırmadığı, aksine, çocuğun endişelerini artırabileceği açıklanmalıdır *(Gawinski vd., 2021).*
- ***İletişimin faydalarını gösterin:*** Ebeveyn-çocuk iletişimi çocukların kendini duygusal olarak daha güvende hissetmelerini sağlar. Böylece ebeveynlerin, çocuklarıyla açık iletişim kurdukları için gelecekte pişmanlık hissetme olasılıkları azalabilir *(Atout vd., 2019).*

IV. Acı Verici Duygularla Bunalmış ve Aşırı Bilgi Yüklenmiş Olmak

Ebeveynler, test sonuçları, tedavi seçenekleri, hastalığın ilerleyişi ve prognostik bilgiler gibi çeşitli profesyonel kaynaklardan sürekli yeni bilgiler alırlar. Bu bilgiler bazen karmaşık ve çelişkili olabilir *(Badarau vd., 2015).* Ebeveynler bu bilgileri kategorize edecek kaynaklardan yoksun olduklarında, kısa sürede aldıkları çok miktarda bilgi, profesyonel terimleri anlamalarını zorlaştırır ve karar verme süreçlerini çıkmaza sokar. Çocuğun durumunda devam eden değişiklikler, rahatsız edici fiziksel semptomlar ve mali baskılar da ebeveynlerin ciddi psikolojik stres yaşamalarına neden olabilir *(Gibson vd., 2018; Murphy vd., 2018).* Böyle bir durumda, ebeveynler hâlâ şok içinde

olduklarından çocuklarına ne söyleyeceklerini bilemeyebilir ve bu ağır konuları konuşabilecek durumda olmayabilirler *(Archambault Grenier vd., 2018).*

Sağlık Profesyonellerine Öneriler:

- ***Aşırı bilgi yüklememek:*** Ebeveynlerin hastalık süreci ve tedaviye dair aşırı bilgiyle yüklenmesi önlenmeli; adım adım bilgi vererek ebeveynlerin kontrol kaybı hissetmesinin önüne geçilmeli ve onların tercih ettikleri bilgi alma yöntemleri sorulmalıdır *(Zhang vd., 2024).*
- ***Destek sağlayıcı etkinlikler:*** Müzik terapisi gibi etkinlikler, ebeveynlerin stresini azaltabilir *(Robb vd., 2023).* Psikososyal programlar ve mobil uygulamalar, hastalık hakkında bilgi edinmeyi ve duygusal rahatlama sağlamayı destekleyebilir *(Alarjeh vd., 2023; Luo vd., 2021).*
- ***Mola imkânları:*** Ebeveynlerin 24 saatlik bakım yükünden kısa süreli olarak uzaklaşabileceği mola hizmetleri sunulması duygusal yüklerini hafifleterek süreçle daha iyi baş etmelerine yardımcı olabilir *(Hizanu vd., 2024).*

V. Tıp Uzmanlarının ve Ebeveynlerin Yanlış Görüşleri

Ebeveynlerin ve profesyonellerin çocukların hastalık ve ölümü anlama ve kötü haberlerle başa çıkma becerilerini hafife almaları; çocukların sadece yaşlarına ve bilişsel yeteneklerine uygun olanı bilmeleri gerektiğine ve daha fazlasını bilmelerine gerek olmadığı düşüncesi yaygın olarak görülen bir yanılgıdır *(Van der Geest vd., 2015).* Bu nedenle, çocukları kötü haberlerden korumak için onları bilgilendirmemeyi veya önemsiz bilgileri aktarmayı tercih edebilirler. Sağlık personeli de ebeveynlerin bu yanlış görüşünü destekleyebilir. Sağlık personeli, bakım verme sürecinde ebeveynlerin bakım veren olarak otoritesini kabul ederek öncelikli olarak ebeveynlerin bilgilendirilmesi gerektiğini ve hem çocuğa hem de ebeveynlere aynı anda bilgi verilmesinin gerekli olmadığına karar verebilirler *(Atout vd., 2019; Beale vd., 2005).*

Sağlık Profesyonellerine Öneriler:

- ***Yanlış inanışları düzeltin:*** Çocukların ölüm veya tıbbi konuları anlamayacağı düşüncesinden vazgeçilmelidir. Çocukların bu tür bilgileri kavrayabilme kapasitesi göz ardı edilmemelidir. Ayrıca hekimler veya ebeveynler bilgiyi seçici olarak aktarmamalı; sadece iyi tarafları anlatıp kötü haberleri gizlememelidir *(Jalmsell vd., 2016).* Zaten aslında çocuklar, hekimlerine sorarak, diğer çocuklarla konuşarak veya fiziksel durumunu gözlemleyerek neler olduğunu anlayabilir *(Stanek vd., 2022).*
- ***Çocukların hastalıkları hakkındaki bilgi ve anlama düzeylerini değerlendirin:*** Çocuğun hastalığını veya ölümü nasıl algıladığını öğrenmek için sorular sorulmalıdır.
- ***Gelişim düzeyine uygun bilgi verin:*** Çocuğun yaşına ve gelişim seviyesine göre bilgi sağlanmalı, sorular sormasına olanak tanınmalıdır *(Beale vd., 2005).* Çocuklar, olacaklara kendilerini hazırlayabilmek için, edindikleri bilgilerin anlaşılabilir ve pratik olmasına ihtiyaç

duyarlar *(Stanek vd., 2022).*

- ***İfade etmeyi teşvik edin:*** Çocuğun endişelerini, vücudundaki hızlı değişiklikleri ve ölümle ilgili düşüncelerini dile getirmesi için uygun bir ortam oluşturulmalıdır *(Beale vd., 2005).*

VI. Olumsuz İletişim

Olumsuz iletişim, ebeveynler ve çocuklar arasında etkili bir iletişim kurmada başarısızlık, açık ve dürüst iletişimden kaçınma, çocuğun durumunu daha az gündeme getirme ve çatışmalara uygunsuz tepkiler verme gibi durumları kapsamaktadır *(Atout vd., 2019; Heeyeon Son & Nancy Crego, 2020; Keim vd., 2017; Murphy vd., 2018).* Çocuklar, kendilerini yakın hissettikleri ve uzun zamandır tanıdıkları kişilerden bilgi almayı tercih etmektedir *(Young vd., 2003, Kenny vd., 2021).*

Sağlık Profesyonellerine Öneriler:

- ***İletişim Zamanlaması:*** Hastalık ilk teşhis edildiğinde, çocuğun durumunda bir değişiklik veya alışılmadık bir davranış gözlemlendiğinde iletişim kurmak için mükemmel bir zamandır *(Beale vd., 2005).*
- ***Etkili İletişim Stratejilerinin Kullanımı:*** Profesyonel ekip, meslektaşlarıyla işbirliği yaparak ebeveynlere çeşitli durumlarda kullanılabilecek etkili iletişim stratejilerini öğretebilir. Etkili iletişim stratejileri:
  - Soruları dürüstçe yanıtlamak.
  - Bilgileri kademeli ve yapılandırılmış bir şekilde sağlamak.
  - Sessizlik dönemlerine izin vermek *(Schuetze vd., 2022).*
- ***Çocuklarla İletişim:*** Çocuğa teşhis sırasında "Vücudunda neler olduğunu bilmek ister misin?" veya "Neleri öğrenmek istersin?" gibi sorular sorarak gerçeği bildirmek, bir güven ilişkisi kurabilir ve çocuğun iletişim kurmak isteyip istemediğini belirleyebilir *(Beale vd., 2005).*

VII. Kültürel Faktörler

Bazı kültürlerde özel hassasiyetler, bastırma eğilimleri ve ölüm tabuları bulunmaktadır. Aile içi konuşmalarda ebeveynler, "kanser" veya "ölüm" gibi tabu kelimeler yerine, mümkün olduğunca "bu/o hastalık" gibi ifadeler kullanmayı tercih ederler *(Bahrami vd., 2017).*

Kaynakça

Akard, T. F., Dietrich, M. S., Friedman, D. L., Gerhardt, C. A., Given, B., Hendricks-Ferguson, V., Hinds, P. S., Ridner, S. H., Beckmann, N., & Gilmer, M. J. (2021). Improved parent–child communication following a RCT evaluating a legacy intervention for children with advanced cancer. Progress in palliative care, 29(3), 130-139.

Akard, T. F., Hendricks-Ferguson, V. L., & Gilmer, M. J. (2019). Pediatric palliative care nursing. Annals of palliative medicine, 8(Suppl 1), S39-S48-S33S48.

Alarjeh, G., Boufkhed, S., Alrjoub, W., Guo, P., Yurduşen, S., Ahmed, F., Abdal-Rahman, M., Alajarmeh, S., Alnassan, A., & Al-Awady, S. (2023). Communication and information sharing with pediatric patients including refugees with advanced cancer, their caregivers, and health care professionals in Jordan: a qualitative study. Frontiers in Oncology, 13, 1118992.

Archambault Grenier, M. A., Roy Gagnon, M. H., Gauvin, F., Doucet, H., Humbert, N., Stojanovic, S., Payot, A., Fortin, S., Janvier, A., & Duval, M. (2018). Survey highlights the need for specific interventions to reduce frequent conflicts between healthcare professionals providing paediatric end of life care. Acta Paediatrica, 107(2), 262-269.

Atout, M., Hemingway, P., & Seymour, J. (2019). The practice of mutual protection in the care of children with palliative care needs: a multiple qualitative case study approach from Jordan. Journal of pediatric nursing, 45, e9-e18.

Badarau, D. O., Wangmo, T., Ruhe, K. M., Miron, I., Colita, A., Dragomir, M., Schildmann, J., & Elger, B. S. (2015). Parents' challenges and physicians' tasks in disclosing cancer to children. A qualitative interview study and reflections on professional duties in pediatric oncology. Pediatric blood & cancer, 62(12), 2177-2182.

Bahrami, M., Namnabati, M., Mokarian, F., Oujian, P., & Arbon, P. (2017). Information-sharing challenges between adolescents with cancer, their parents and health care providers: a qualitative study. Supportive Care in Cancer, 25, 1587-1596.

Beale, E. A., Baile, W. F., & Aaron, J. (2005). Silence is not golden: communicating with children dying from cancer. Journal of clinical oncology, 23(15), 3629-3631.

Brown, R. T., & Kupst, M. J. (2016). Coping with chronic illness in children and their families. Child and adolescent resilience within medical contexts: Integrating research and practice, 267-292.

Bruzzese, J.-M., Fisher, P. H., Lemp, N., & Warner, C. M. (2009). Asthma and social anxiety in adolescents. The Journal of pediatrics, 155(3), 398-403.

Ceylan, M. F. (2016). Çocuk ve Ergende Akut ve Kronik Hastalığa Uyum. Turkiye Klinikleri Child Psychiatry- Special Topics, 2(2), 13-17.

Feudtner, C. (2007). Collaborative communication in pediatric palliative care: a foundation for problem- solving and decision-making. Pediatric Clinics of North America, 54(5), 583-607.

Foster, T. L., Gilmer, M. J., Davies, B., Barrera, M., Fairclough, D., Vannatta, K., & Gerhardt, C. A. (2009). Bereaved parents' and siblings' reports of legacies created by children with cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 26(6), 369-376.

Gaab, E. M., Owens, R. G., & MacLeod, R. D. (2013). Primary caregivers' decisions around communicating about death with children involved in pediatric palliative care. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 15(6), 322-329.

Gawinski, L., Stiel, S., Schneider, N., & Herbst, F. A. (2021). Communication in dyads of adult children at the end of life with their parents and parents at the end of life with their adult children: Findings from a mixed methods study. Psycho Oncology, 30(9), 1535-1543.

Gibson, F., Kumpunen, S., Bryan, G., & Forbat, L. (2018). Insights from parents of a child with leukaemia and healthcare professionals about sharing illness and treatment information: A qualitative research study. International journal of nursing studies, 83, 91-102.

Hak, T., Koeter, G., & van der Wal, G. (2000). Collusion in doctor-patient communication about imminent death: an ethnographic study. Bmj, 321(7273), 1376-1381.

Heeyeon Son, M., & Nancy Crego, P. (2020). Communication challenges in Korean families coping with adolescent cancer. Oncology Nursing Forum,

Himebauch, A., Arnold, R. M., & May, C. (2008). Grief in children and developmental concepts of death# 138. Journal of Palliative Medicine, 11(2), 242-244.

Hizanu, M., Boeriu, E., Tanasescu, S., Balan, A., Oprisoni, L. A., Popa, M. V., Gutu, C., Vulcanescu, D. D., Bagiu, I. C., & Bagiu, R. V. (2024). Benefits of Respite Services on the Psycho-Emotional State of Families of Children Admitted to Hospice Palliative Care Unit: Preliminary Study on Parents' Perceptions. Healthcare,

Immelt, S. (2006). Psychological adjustment in young children with chronic medical conditions. Journal of pediatric nursing, 21(5), 362-377.

Jalmsell, L., Lövgren, M., Kreicbergs, U., Henter, J. I., & Frost, B. M. (2016). Children with cancer share their views: tell the truth but leave room for hope. Acta Paediatrica, 105(9), 1094-1099.

Keim, M. C., Lehmann, V., Shultz, E. L., Winning, A. M., Rausch, J. R., Barrera, M., Jo Gilmer, M., Murphy, L. K., Vannatta, K. A., & Compas, B. E. (2017). Parent–child communication and adjustment among children with advanced and non-advanced cancer in the first year following diagnosis or relapse. Journal of pediatric psychology, 42(8), 871-881.

Kenney, A. E., Bedoya, S. Z., Gerhardt, C. A., Young-Saleme, T., & Wiener, L. (2021). End of life communication among caregivers of children with cancer: A qualitative approach to understanding support desired by families. Palliative & supportive care, 19(6), 715-722.

Kenny, M., Duffy, K., Hilliard, C., O'Rourke, M., Fortune, G., Smith, O., Hynes, G., & Higgins, A. (2021). 'It can be difficult to find the right words': Parents' needs when breaking news and communicating to children with cancer and their siblings. Journal of psychosocial oncology, 39(4), 571-585.

Kostak, M. A., & Akan, M. (2011). Terminal dönemdeki çocuğun palyatif bakımı. Türk Onkoloji Dergisi, 26(4), 182-192.

Koukourikos, K., Tzeha, L., Pantelidou, P., & Tsaloglidou, A. (2015). The importance of play during hospitalization of children. Materia socio-medica, 27(6), 438.

Kurtz, B. P., Muriel, A. C., & Abrams, A. N. (2010). Pediatric consultation. Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry, 565-582.

Levetown, M., & Bioethics, C. o. (2008). Communicating with children and families: from everyday interactions to skill in conveying distressing information. Pediatrics, 121(5), e1441-e1460.

Lewinsohn, P. M., Seeley, J. R., Hibbard, J., Rohde, P., & Sack, W. H. (1996). Cross-sectional and prospective relationships between physical morbidity and depression in older adolescents. Journal of the American academy of child & adolescent psychiatry, 35(9), 1120-1129.

Li, R., Shen, X., Zhang, L., Chan, Y., Yao, W., Zhang, G., & Li, H. (2023). Effects of Child Life intervention on the symptom cluster of pain–anxiety–fatigue–sleep disturbance in children with acute leukemia undergoing chemotherapy. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 10(7), 100243.

Liben, S., Papadatou, D., & Wolfe, J. (2008). Paediatric palliative care: challenges and emerging ideas. The Lancet, 371(9615), 852-864.

Lou, H.-L., Mu, P.-F., Wong, T.-T., & Mao, H.-C. (2015). A retrospective study of mothers' perspectives of the lived experience of anticipatory loss of a child from a terminal brain tumor. Cancer nursing, 38(4), 298-304.

Luo, Y., Xia, W., Cheung, A. T., Ho, L. L. K., Zhang, J., Xie, J., Xiao, P., & Li, H. C. W. (2021). Effectiveness of a mobile device–based resilience training program in reducing depressive symptoms and enhancing resilience and quality of life in parents of children with cancer: randomized controlled trial. Journal of medical Internet research, 23(11), e27639.

Mack, J. W., & Hinds, P. S. (2011). Practical aspects of communication. Textbook of interdisciplinary pediatric palliative care. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 179-189.

Michelson, K. N., & Steinhorn, D. M. (2007). Pediatric end-of-life issues and palliative care. Clinical pediatric emergency medicine, 8(3), 212-219.

Moody, K., Siegel, L., Scharbach, K., Cunningham, L., & Cantor, R. M. (2011). Pediatric palliative care. Primary Care: Clinics in Office Practice, 38(2), 327-361.

Murphy, L. K., Preacher, K. J., Rights, J. D., Rodriguez, E. M., Bemis, H., Desjardins, L., Prussien, K., Winning, A. M., Gerhardt, C. A., & Vannatta, K. (2018). Maternal communication in childhood cancer: Factor analysis and relation to maternal distress. Journal of pediatric psychology, 43(10), 1114-1127.

Nuss, S. L. (2014). Redefining parenthood: surviving the death of a child. Cancer nursing, 37(1), E51-E60.

Organization, W. H. (2009). WHO Definition of Palliative Care. Retrieved April 11, 2009 from http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Orm, S., Haukeland, Y. B., Vatne, T., & Fjermestad, K. (2022). Measuring family communication in pediatric nursing: Psychometric properties of the Parent-Child Communication Scale–Child Report (PCCS- CR). Journal of pediatric nursing, 62, 78-83.

Özdemir, D. F., & Karabucak, B. (2016). Çocuk ve Ergende Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi. Turkiye Klinikleri Child Psychiatry-Special Topics, 2(2), 86-94.

Öztek Çelebi, F. Z. Ş., Şanlıay (2021). Pediatrik Palyatif Bakımda İletişim. In A. Ghiasee (Ed.), Sağlıkta İletişim (pp. 117-128). Nobel Yayıncılık.

Patrick-Ott, A., & Ladd, L. D. (2010). The blending of Boss's concept of ambiguous loss and Olshansky's concept of chronic sorrow: A case study of a family with a child who has significant disabilities. Journal of Creativity in Mental Health, 5(1), 73-86.

Pinquart, M., & Shen, Y. (2011). Depressive symptoms in children and adolescents with chronic physical illness: an updated meta-analysis. Journal of pediatric psychology, 36(4), 375-384.

Pirie, A. (2012). Pediatric palliative care communication: Resources for the clinical nurse specialist. Clinical nurse specialist, 26(4), 212-215.

Price, J., McNeilly, P., & Surgenor, M. (2006). Breaking bad news to parents: the children's nurse's role. International journal of palliative Nursing, 12(3), 115-120.

Rennick, J. E., & Rashotte, J. (2009). Psychological outcomes in children following pediatric intensive care unit hospitalization: a systematic review of the research. Journal of child health care, 13(2), 128-149.

Robb, S. L., Stegenga, K., Perkins, S. M., Stump, T. E., Moody, K. M., Henley, A. K., MacLean, J., Jacob, S. A., Delgado, D., & Haut, P. R. (2023). Mediators and Moderators of Active Music Engagement to Reduce Traumatic Stress Symptoms and Improve Well-being in Parents of Young Children With Cancer. Integrative cancer therapies, 22, 15347354231218266.

Schonfeld, D. (2002). The child's cognitive understanding of illness. Child and adolescent psychiatry: A comprehensive textbook, 3, 1119-1123.

Schuetze, D., Ploeger, C., Hach, M., Seipp, H., Kuss, K., Bösner, S., Gerlach, F. M., van den Akker, M., Erler, A., & Engler, J. (2022). Care practices of specialized outpatient pediatric palliative care teams in collaboration with parents: Results of participatory observations. Palliative Medicine, 36(2), 386- 394.

Slaninka, M., Krajmer, P., & Kolenova, A. (2021). Main topics related to the disease, death, and dying in communication between parents and their adolescent children with incurable cancer. Bratislavske lekarske listy, 122(8), 572-576.

Smith, L. E., Maybach, A. M., Feldman, A., Darling, A., Akard, T. F., & Gilmer, M. J. (2019). Parent and child preferences and styles of communication about cancer diagnoses and treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 36(6), 390-401.

Son, H., & Miller, L. E. (2023). Family communication about cancer in Korea: a dyadic analysis of parent- adolescent conversation. Global Qualitative Nursing Research, 10, 23333936231199999.

Son, H., Haase, J., & Docherty, S. L. (2019). Parent-child communication in a childhood cancer context: A literature review. Pediatric Nursing, 45(3), 129-141.

Stanek, C., Garcia, D., Olsavsky, A. L., Hill, K. N., Himelhoch, A. C., Kenney, A. E., Humphrey, L., Olshefski, R., Gerhardt, C. A., & Nahata, L. (2022). Communication within families about advanced pediatric cancer: A qualitative study. Palliative & supportive care, 1-8.

van Breemen, C. (2009). Using play therarpy in paediatric palliative care: listening to the story and caring for the body. International journal of palliative Nursing, 15(10), 510-514.

van der Geest, I. M., van den Heuvel-Eibrink, M. M., van Vliet, L. M., Pluijm, S. M., Streng, I. C., Michiels, E. M., Pieters, R., & Darlington, A.-S. E. (2015). Talking about death with children with incurable cancer: perspectives from parents. The Journal of pediatrics, 167(6), 1320-1326.

Waldman, E., & Wolfe, J. (2013). Palliative care for children with cancer. Nature reviews Clinical oncology, 10(2), 100-107.

Yamaji, N., Suzuki, D., Suto, M., Sasayama, K., & Ota, E. (2022). Communication tools used in cancer communication with children: a scoping review. Cancers, 14(19), 4624.

Young, B., Dixon-Woods, M., Windridge, K. C., & Heney, D. (2003). Managing communication with young people who have a potentially life threatening chronic illness: qualitative study of patients and parents. Bmj, 326(7384), 305.

Zhang, M., Li, H., Li, F., & Zhang, Y. (2024). Facilitators and barriers to parent-child communication in pediatric palliative care: An integrative review. International Journal of Nursing Sciences.

10. YAŞAM SONU BAKIM

Çocukların yaşamını ve ölümün kalitesini artırmaya ilaveten, ailenin anlam ve destek bulmasına yardımcı olan bir yaşam sonu bakım sağlanması çok önemlidir *(Şahin vd., 2022)*. Birçok sağlık profesyoneli kendisini ölmekte olan hasta ve ailesiyle iletişimin yanısıra, ÇPB uygulamaları ve canlandırma vb. işlemleri açısından deneyimsiz hissetmektedir *(Üstün vd., 2013; Gemici vd., 2014)*. Bilgilendirilmiş rıza, iyi klinik uygulamalar, uygun karar verme algoritmaları, ağrı giderilmesi, risk ve yarar durumunun değerlendirilmesi, gerçeği söyleme, sır saklama gibi etik konular bilgi ve tecrübe gerektirmektedir *(Akdeniz et.al., 2021)*.

10.1. Karar Verme

Ülkemizde yasal düzenlemelerde rıza verme yetkisi 18 yaş sınırı ile yetişkin olan bireylere tanınmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan en önemli etik unsur yeterlilik (competence) durumudur *(Üstün vd., 2013)*. Çocuklarda karar verme yeteneğinin sınırlı olduğu varsayılır *(Büken vd., 2016)*. Amerikan Pediyatri Akademisi'ne (APA) göre karar verme sırasında, hastalığın niteliğinin açıklanması, teşhis ve tedavi aşamalarının belirlenmesi, tedavi başarısı ve olası risklerin anlaşılır bir şekilde hastaya anlatılmasına dikkat edilmelidir. Hastalarda rıza yasal temsilcisinden alınıyor olsa bile, çocuğun kararı bilme ve sürece katılma hakkı vardır. Bu nedenle hekim hastayla arasında güven ilişkisi tesis etmeli ve çocuğu karara dâhil etme konusunda gayret göstermelidir. Etik anlamda 7 yaşından itibaren çocuğun tıbbi kararlara katılabileceğinden ve 15 yaşından itibaren de yetişkin (mature minor) çocuk olarak kabul edileceğinden bahsedilmektedir. Çocuk yasal yaş sınırının altında olsa bile tıbbi tedavilerin sonuçlarını anlayabilmekte ve makul kararlar verebilmektedir. Düşük riskli ve standart tedavilerde çocuğun onayı yeterlidir *(Gemici vd., 2014; Aydın vd., 2003)*.

10.2. Yaşam Sonu Bakım Kararları

Yaşam sonu bakım (end-of-life care) ve tedavi, artık hastanın ölüme yakın olduğu durumda iyileştirmeye yönelik tedavilerden vazgeçilerek, semptomların giderilmesine yönelik acıların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik verilen bakım ve tedavidir. Yaşam sonu kararı (end of life decision) ise, hastanın kendisi, yakınları veya yasal vasisiyle yapılan görüşmeler sonucunda hekim tarafından verilen "tıbbi kararlar (medical decision)"dır *(Dilli vd., 2007; Üstün vd., 2013)*. Karar verme süreci klinik etikte problem çözme sürecidir ve birçok tıbbi belirleyeni vardır. Hastanın tıbbi durumu, bunun acil mi, yoksa kronik ve geri dönüşümsüz bir durum olup olmadığı, verilen tedavinin amacı, alternatifleri, başarı şansı, sorumlu hekimi ve danışılan diğer hekimlerin görüşleri önem arzetmektedir. Çocukların karar alma sürecine dâhil edilmesi ve bilişsel durumlarının yeterli olduğu ölçüde bilgilendirilmesi sağlık personeli için etik olarak zorunlu bir yükümlülüktür *(Gemici vd., 2014)*. Karar vermede hastanın tercihleri önemlidir. Hastanın değerleri, kişiliği, varsa özel istekleri, verilen talimatları anlama ve karar verme kapasitesi, yaşamdan

beklentisi ve çocuğun yeterliliği yok ise onun adına karar verecek olan vasinin çocuğun üstün yararını gözeten kararlar verip vermediği önemlidir *(Büken vd., 2016)*. Ülkemizde gün geçtikçe büyüyen çok kültürlü bir toplumun varlığı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının farklı inançlara, değerlere, dillere ve farklı sağlık kavramlarına sahip kişiler için uygun bakımı sağlama konusunda zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. Bilhassa çocukluk çağında yaşam sonu bakıma ihtiyaç duyulduğu zaman, kültürün palyatif bakımı nasıl etkilediğini anlamak eşitlik ve etik açılardan hayati önem taşımaktadır *(Akdeniz vd. 2021)*.

Aile, hekimin önerdiği tedaviyi reddederse veya aileyle çocuğun kararında uyuşmazlık varsa, ve tedavi çocuğun sağlığı için gerekli bir müdahale ise, hekim hukuki yollara başvurarak tedaviyi uygulama konusunda yetki alabilir. Hatta acil bir durumda bu işlemi telefonla yapabilir veya tıbbi aciliyet durumunda telefon için zaman yoksa aileden onay almadan tedaviyi uygulamak gerekebilir. Savaş hali, doğal afetler, toplu kaza ve bilincin kapalı olduğu koma gibi durumlarda ivedilik söz konusu olduğu için hekimin hastayı bilgilendirme görevinden söz edilemez. Kanuni temsilci tedaviye muvafakat vermiyorsa ve müdahale tıbben gerekliyse, mahkemeden izin alınması gerekmektedir. Ancak acilen müdahale edilmediği takdirde çocuğun hayati organlarından biri ya da hayatı tehdit altına girecekse herhangi bir izin şartı aranmaz *(Türk Medeni Kanunu, 2018; Özcan vd., 2007)*.

Hastane etik kurul yapılanması ve bireysel etik konsültasyonlar son 30 yıldır dünyada rutin uygulama alanına girmiş ve etik vakalarda sorun çözme becerisini artıran eğitim programları ve sağlık kurumlarında devreye sokulan etik protokoller sayesinde hastalık süreçleri daha verimli bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Sağlık Hizmetleri Birimi Etik Kurulu, sağlık hizmetinin; insan sağlığına, onuruna ve haklarına saygılı, etik norm ve değerlere ve meslek ahlakına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, klinik izlemde karşılaşılan etik ikilemlerde doktorlara danışmanlık hizmeti vermek, hastane yönetimi, sağlık profesyoneli, hasta ve ailesine ihtiyaç duyulduğunda etik danışmanlık vermek, kurum içi eğitim programları planlayıp yürütmek ve verilen hizmetin kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır *(Büken vd., 2016)*. Türkiye'de tıp hizmetlerinde etik alanında epey yol alınmış olmasına rağmen, etik algoritma ve rehberlerin rutin kullanıma girmesi, etik konsültasyonların uygulanması ve hastane koşullarında etik kurulların sayılarının artırılması gereklidir. Hasta, hasta yakını ve hekimler arasında fikir birliği olmadığı durumlarda ''Hasta Etik Kurulları''ndan destek alınmalıdır.

10.3. Bilgilendirilmiş Rıza

Çocuk hastalar incinebilir grupta yer aldıkları için çocuk hasta yönetimi özen ve duyarlılık gerektirmektedir. Hekimler kronik ilerleyici hastalığı olan, hayati tehlikesi bulunan, mental ya da fiziksel engelli çocuklar, yuva çocukları, terminal dönem hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar, yoğun bakım ünitelerindeki ölümcül hastalıklar gibi yaşamın son dönemindeki hastalar karşısında birçok etik ikilemle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlarla baş etme, klinik ve etik karar verme süreçlerini işletme konusunda hekim, sağlık çalışanı, hasta, ailesi ve sağlık kurumu gibi

ilgili tarafların verecekleri kararlar, bulundukları toplumun ahlaksal, kültürel, sosyal ve hukuki yapısına ek olarak, ülkelerin sağlık politikaları ve sağlık ekonomilerinden de etkilenmektedir *(Üstün vd., 2013; Civaner vd., 2007).* Günümüzde, "rızasını açıklayamayacak durumda bulunan' çocukların korunması ve her hastanın, "kendi geleceğini belirleme hakkı", tıbbi müdahale ve tedavi uygulamaları bakımından hastanın onamını gerekli kılar. Bu nedenle hekimin bilgilendirilmiş rıza sürecinin gerekliliğine inanması ve bunu işletmeye istekli olması önemlidir *(Dilli vd., 2007; Aydın vd., 2003; Malthora vd., 2009).*

Bilgilendirilmiş rıza sürecinin 3 temel öğesi vardır: 1-Yeterlilik-karar verebilme için gerekli zihinsel kapasiteye sahip olmak, 2-Bilgilendirme- tedavinin başarısı, riskleri, alternatif tedavi gibi tüm olasılıkların anlatılması ve karşıdaki tarafından anlaşılması ve 3-Gönüllülük- kişinin kendi durumu ve değerleri açısından en iyi, en doğru ve haklı olanı anlayarak seçmesidir *(Civaner vd., 2007; Malthora vd., 2009).*

10.3.1. Türkiye'de Çocuk Bireyde Bilgilendirilmiş Rıza

Karar verme yeterliliği olmayan çocuk hastalarda yasal temsilcisinin rızası alınmalı ve çocuk elden geldiğince aydınlatılmalı ve karar alma sürecine dâhil edilmelidir. Ülkemizde hastanın rızası ancak reşit olduğunda alınmaktadır ve 18 yaş altı çocuklara kendi başlarına tedavi olabilme hakkı veren yasal bir düzenleme bulunmamaktadır *(Özsunay,1979).* 13-18 yaş arasında olan çocukların yasal temsilcilerinden rıza alınması yasal bir zorunluluktur. Bununla birlikte, çocuğun tedavi sürecinde rahatlatılması açısından kendisinden de rıza alınmasının etik yönden uygun olacağı belirtilmektedir *(Çetin vd. 2006; Ay vd., 2019).*

Bilgilendirilmiş rıza sadece imzalanması gereken bir kağıt parçası değildir. Hastayı bilgilendirmek yeterli değildir. Hasta veya yakınının verilen bilgiyi anladığından emin olunması gereklidir. Kişiye uygulanacak olan tanı ve tedavi yöntemleri, buna alternatif olabilecek uygulamalar ve bu işlemlerin yarar ve riskleri hakkında bilgi verildikten sonra hasta veya veliden ya da vasiden onam alınması gereklidir. Pediyatrik hastalara yapılacak tıbbi müdahalelerden önce rıza alınması tıp ve hukuk kültürümüzde standart hale gelmiştir. Süreç, yetkinlik, bilgi, kavrayış, gönüllülük ve özerklik olmak üzere beş maddeden oluşmaktadır. Rıza süreci, yeterli zaman ve özeni gerektirmektedir *(Gemici vd., 2014; Aydın vd., 2003).*

Tıbbi işlem, tedavi ve bilgilendirilmiş onamın reddi hasta haklarıdır *(Ay vd., 2019).* Hastaneye yatış ve hekim tavsiyesi dışında taburculuk, invaziv müdahaleler (lomber ponksiyon, kemik iliği aspirasyonu, trakeostomi kanül uygulanması, cerrahi operasyonlar vb.) çocuklarda en sık reddedilen müdahalelerdir *(Acoglu vd.,2021; Mine vd., 2021).* Çocukların fizik muayene, ilaç uygulamaları ve tıbbi karar verme sürecine katılımı, hekim, çocuk ve ebeveyn arasında açık bir iletişim gerektirir. İletişim hasta işbirliği için önemli bir faktördür *(Gemici vd., 2014).*

10.4. Ailenin Çocukla İlgili Kararları

Biyomedikal etiğin ilkeleri bağlamında değerlendirme yapılırken ilk kaynak toplumun entelektüel ve kültürel gelenekleridir. Hasta hakkında karar verme süreçleri kurum ve kamu politikalarının, dini otoritelerin, hastane etik kurullarının ve hasta ailesinin olduğu çok belirleyenli bir ilişki içindedir. Hastanın yeterliğinin olmadığı durumlar için yasal vasinin hastanın üstün çıkarını gözetip gözetmediği önemlidir *(Ay vd., 2019)*. Ailenin kararlarında hastanın beklentisi, karar için gerekli bilgilerin verilip verilmediği, hastanın mevcut durumu tam olarak anlayıp anlamadığı, hastanın tedavisinde farklı alternatifler ve olasılıklardan haberdar olup olmadığı yanında, hastanın kendisine uygulanacak tıbbi girişimler için gönüllü olup olmadığı ve görünür veya görünmez baskı/zorlamalara maruz kalıp kalmadığı göz önüne alınmalıdır *(Mine vd., 2021)*.

10.5. Ailenin Karar Vermesinde Kültürün Rolü

Sosyal faktörler, kültürel normlar ve gelenekler, tanı veya prognoz hakkında ailenin kararlarıyla ilgili olduğu için kritik öneme sahiptir. Farklı bir kültürün karar vermedeki rolü, inanç ve din adamlarının katılımı, beden dili, çocuklara gerçeği söyleme,, ağrı ve ıstırabın anlamı, ölümün anlamı ve yaşam sonu bakımın yeri hakkında iletişim kurmak çok önemlidir *(Hatano vd., 2011)*. Birçok kültür için aile aynı zamanda topluluk üyeleri olarak tanımlanabilir. Mesela, bazı aileler çocuk hakkında karar vermede, saygı gösterilen bir topluluk lideriyle bilgi paylaşımını veya ailenin yaşça en büyük erkek üyesiyle konuşmayı tercih edebilir. Cinsiyet de karar vermede rol oynayabilir ve hastalık, cinsiyete bağlı olarak farklı bir anlam arz edebilir. Bu durum aile varlığını sürdürmek için erkek çocuklara sahip olma yönünde güçlü bir istek gösteren bazı gelenek ve kültürler için yaygındır. Bazı ailelerde, anne tipik olarak birincil bakıcıdır; bu nedenle kararlar genellikle onun tarafından verilecektir. Bununla birlikte, anneler tedaviyi sürdürme veya kesme kararı öncesinde çocuğun babasından izin isteyebilir *(Kebudi vd., 2017; Mazanec vd., 2003)*.

Yaşam sonu kararı tamamen tıbbi bir karardır ve hastayı takip eden hekimler tarafından verilmektedir. Bunlar herhangi bir tedavinin başlanıp başlanmayacağı (withhold), verilen tedavilerin kesilip kesilmeyeceği (withdrawal) ve faydasız (boşuna/beyhude) tedavi (tıbbi müdahalenin yararsız/etkisiz olduğu, hastanın beklentilerine cevap vermediği, yaşam kalitesine çok az fayda sağladığı, makul yaşam şansı tanımadığı konusunda birleşilen) tedavi uygulamalarının yapılıp yapılmayacağı kararlarıdır *(Kebudi vd., 2017; Mazanec vd., 2003)*. Yaşam hakkından tıbbi veya başka nedenlerle vazgeçilemez. Kişinin hayatına, söz konusu kişinin veya başkasının rızası ile son verilemez *(Demir vd., 2014)*. Ancak hastanın sadece acı çekmesine neden olan ve hiçbir fayda sağlamayan boşuna/nafile tedaviler hastayı takip eden hekimi tarafında kesilebilir *(Damps vd., 2022)*. Çocuğun ve aile üyelerinin yaşam kalitesini ve yaşam sonu bakımını artırmak için, geleneklere uyumlu ve kişisel değerlerdeki yapısal farklılıklara duyarlı aile merkezli bir yaklaşım uygulanmalıdır. Globalleşen dünyada değişik ırk, milliyet, din ve kültürden hasta ve hekimlerle karşılaşmak günümüzde olağan hale gelmiştir, bu durum kültürler arasında yanlış

anlama riskini artırmaktadır. Kültürlerarası hoşgörü ve iletişim tekniklerinin uygun kullanımı hasta bakım sürecini iyileştirecektir *(Şahin vd., 2022)*. Gelişen teknolojinin yasal düzenlemeleri gerisinde bırakacağı düşünüldüğünde, kurumlar ve meslek kuruluşları tarafından etik kılavuzların hazırlanması, hasta/yakınları ve sağlık personeli için faydalı olacaktır *(Çelebi vd., 2022; Ayar vd., 2022)*.

Sonuç olarak; ülkemizde çocuklara uygulanacak tıbbi tedavi ve girişimlerde, dünyada kabul gördüğü gibi çocuk anlamaya başladığı andan itibaren çocuğun kendisi hakkında alınacak kararlar konusunda bilgilendirilmesi, ülkemizi Dünya'daki uygulamalara ve taraf olduğu sözleşmelere uyumlu hale getirecektir. Hastanın bilgilendirilme ve karar verme hakkı, özerklik sağlanması açısından her zaman merkezde yer almalıdır. Ayrıca etik ikilem yaratan karmaşık klinik durumlarda karar verme sorumluluğunun paylaşılması ve hastanın üstün çıkarı gözetilerek klinik zor kararların alınması için multidisipliner çözüm sağlayacak Hastane Etik Kurulları (HEK) nın hastanelerde oluşturulması ve bu kurullardan gerektiğinde destek alınmasında fayda vardır.

10.6. Ölüm Yeri Tercihi

Tedavisi olmayan bazı hastalıklarda çocuklarının daha fazla acı çekmesine neden olacak faydası olmayan invaziv tıbbi işlemlerden korumak için ebeveynler evde ölümü tercih edebilirler. Bu bağlamda çocuğun ölüm yeri çok önemlidir. Üçüncü basamak pediyatri hastanelerinde çocuklarını kanserden kaybeden 140 ebeveynle yapılan kesitsel bir çalışmada, ölüm yerini planlama şansının yüksek kaliteli palyatif bakımla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Ebeveynlerin çoğunun çocuğun ölüm yeri için tercih yaptığı, ev ve ev dışı ölümlerin değerlendirildiği bilimsel bir çalışmada, ebeveyn planlamasının pediyatrik yoğun bakım ünitesinden ziyade servisleri tercih ettiği ve daha az çocuğun entübe edildiği bildirilmiştir. Hekim ve evde sağlık hizmetleri ile iyi iletişim, çocuğun ölüm yerini planlama olasılığını artırmaktadır *(Dussel vd., 2009; Şahin vd., 2022)*. Ebeveynlerin manevi hazırlığı da ölüm yerinin planlanmasıyla bağlantılıdır ve yüksek kaliteli yaşam sonu bakımına katkıda bulunan önemli bir faktördür. Ayrıca, planlama yapan ebeveynlerin ölüm anında daha az invaziv bakımı tercih etme olasılığı daha yüksektir.

10.7. Bir Çocuğun İyi Ölüm Konsepti

'İyi ölüm' yaşamın sonuna yaklaşmış kişiler için kullanılan bir deyimdir ve genellikle ölmekte olan çocuklar için kullanılmaz. Bir çocuğun ölümü, doğal bile olsa, yaşlıların ölümüyle karşılaştırıldığında normalleştirilemez. Dolayısıyla, bir insan için 'bir çocuğun ölümü nasıl iyi/güzel olabilir?' sorusu basitçe; acılardan ve önlenebilir sıkıntılardan arınmış, huzurlu bir ölüm olarak tanımlanmaktadır. Ölmekte olan bir çocuğa yaklaşımda, kültüre özgü farklılıklar olabileceğinden, hastaların ve bakım verenlerin isteklerine, kültürel ve etik standartlarına uygun davranılması gerekmektedir *(İto vd., 2015; Şahin vd., 2022)*. Bu nedenle ölüm sürecini tasarlamak, yaşam sonu bakımı optimize etmek için gereklidir. İyi bir ölüm; sıkıntıdan uzak olmak, sevilen bir yerde ölmek, aile üyeleri ve sağlık

personeli ile iyi ilişkiler içinde olmak, yaşamın tamamlandığını hissetmek, saygınlığı korumak ve ölüme hazırlanmak olarak tanımlanabilir. Bir çocuğun ölüm huzuru için, ailelerin kararıyla yerine getirilmesi gereken çevresel detay düzenlemeleri önemlidir. Günün tercih edilen saati, ölüm anında bulunmak isteyen aile üyeleri/personel, gürültü ve aydınlatma (alarmlar tolere edilebilir olmalı), hastanın konforu için hatlar/tüpler, makineler/monitörler ve pompalar kaldırılabilir. Aile, inançları doğrultusunda çekilmeden önce kültürel ve dini uygulamaları gerçekleştirmek isteyebilir. Ayrıca, ebeveynlerin tercih ettiği pozisyon (çocukla birlikte yatakta yatmak veya çocuğu kucağında tutmak), çocuğun odadaki pozisyonu (örneğin, pencereye yakın vb.) ve çocuğun en sevdiği şarkıyı çalmak veya çocuğun çok sevdiği kitabı okumak gibi diğer özel istekler, son saatlerinde ölümün kalitesini sağlamaktadır *(Welch vd., 2008; Şahin vd., 2022)*. Kapsamlı bir çalışmada, kanserli çocuklar için iyi bir ölümün bileşenleri; özgürce oynamak için yeterli fırsatın yaratılması, akran desteği, ortak faaliyetlere erişimin devam etmesi, mahremiyet güvencesi, kararlarına ve tercihlerine saygı, sıkıntı verici semptomların en aza indirilmesi, umut, güçlü aile ilişkileri, aile üyelerine yük olma hissinin olmaması ve sağlık personeli ile iyi ilişkiler olarak belirlenmiştir. Hastaların fiziksel ve psikolojik sıkıntılarına odaklanan optimal palyatif bakım ile ölümcül onkoloji hastaları için normal okul hayatı gibi sağlıklı bir sosyal çevre sağlamak gereklidir. Yüksek kaliteli ÇPB sağlamak için her hastanın yaşına ve gelişim dönemine göre bireysel olarak uyarlanmış bakım sağlanmalıdır. Buna ek olarak, bir çocuğun ölümüne tanıklık etmekten en çok etkilenen sağlık çalışanları, destek yapısının önemli bir parçasıdır. Bazı çalışmalar hekimler ve sağlık personelinin özellikle bu konularda yeterli eğitim almamışsa "tükenmişlik" ve "yetersizlik" duygularına karşı savunmasız olduğunu bildirmektedir. Bu bakımı sağlayan personel için destek gerekebilir.

10.8. Yaşam Sonu Bakımındaki Tartışmalar

Aileye verilen bilginin dürüstlüğü ve kapsamı, haber verirken gösterdiği etki, bilginin saklanması, yanlış umut verilmesi, dil/iletişim karmaşası, bilgi verme hızı, çelişkili bilgiler ve hekimin beden dili, ebeveynlerin yeterli bakım konusundaki algılarını etkileyen iletişimle ilgili faktörlerdir. Ebeveynler, açık ve dürüst bilgilendirme ile "daha iyi hazırlandıklarını" çünkü bunun ne beklemeleri gerektiğini bilmelerine yardımcı olduğunu belirtmektedir. Dahası, ebeveynlerin çoğu "büyük resmi" görmek, yani gerçeği bilmek istemektedir. Pediyatrik bir anket, invazif tedavilere ilişkin endişelerin çocukların yaşam sonu bakımında yetişkinlere göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Aşırı invaziv tedaviler sunma konusunda Uzman hekimler 10 kat, hemşireler ise 20 kat daha fazla endişe duymaktadır. Bu hastalarla ilgilenen uzmanlar vicdani kaygılara sahiptir çünkü ÇPB hastalarında anlamlı bir varoluşa geri dönüş umutsuz görünmektedir *(Solomon vd., 2005; McCabe vd., 2008)*.

Ebeveynler ve sağlık profesyonelleri arasında çocuğun ölümcül durumuna ilişkin hassas, özenli ve dürüst bir diyalog olması, ölüm sürecine hazırlanmaya yardımcı olacaktır. Dürüst, şefkatli ve ulaşılabilir sağlık çalışanları tarafından bu sürece hazırlanan aileler; çocukları için yapılabilecek her şeyin yapıldığı konusunda kendilerini daha rahat hissetmektedir.

10.9. Yaşam Sonu Bakım Eğitimi

Çocuk palyatif bakım ortamı, eğitim, özel yetkinlik ve becerilerin yanısıra çocuk ve aileleriyle birlikte muhtemelen birkaç yıl boyunca tedaviye, desteğe ve iletişime devam etmeyi gerektirmektedir. Çünkü çocuklar, disiplinler arası uzmanlık gerektiren birçok semptom ve hastalıktan muzdariptir *(Çelebi vd. 2022; Solomon vd., 2005)*. Palyatif bakım için anahtar konular iletişim, ağrı, fiziksel, psikososyal, manevi hususlar ve etik/yasal kaygılardır. Ayrıca ölüm sürecindeki bir hastanın yönetimi ve ölümün bildirilmesi de bir başka karmaşık deneyimdir. Ancak uygun eğitimden sonra ölmekte olan çocuk ve ailesine karşı profesyonel destek sağlanması artmaktadır *(Browning vd. 2005)*.

Bir çocuğun yaşam sonu ve ölümünden sonra bakımın kalitesini artırmak için, doğumsal anomalilerin, yaşamı tehdit eden hastalıkların, çocuğun ömrünü kısaltabilecek durumların mortaliteye ilişkin sonuçlarının yaşam beklentisi/sağkalım açısından değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Ailelerde sadece bakım verenler değil, kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar, akrabalar ve sağlık çalışanları da bir çocuğun ölümünden etkilenmektedir ve onların da ihtiyaçları araştırılmalı, desteklenmesi sağlanmalıdır. Çocuk palyatif bakım personeli, ölmekte olan çocuklara ve ailelerine uygun bakımı geliştirmek için ÇPB ve yaşam sonu bakım konusunda mutlaka eğitim almış olmalıdır.

Kaynakça

Acoglu EA, Oguz MM, Sari E, Yucel H, Akcaboy M, Zorlu P, et al.(2021). Parental attitudes and knowledge about lumbar puncture in children. Pediatric emergency care. 37(7):e380-e3.

Akdeniz M, Yardımcı B, Kavukcu E. (2021).Ethical considerations at the end-of-life care. SAGE open medicine. 9:20503121211000918.

Ay A, Çınar S, Boztepe H.(2019). Çocuklarda aydınlatılmış onam. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 6(2):120-5.

Ayar G, Şahin Ş, Çelebi FZÖ. (2022). Pediatrik Palyatif Bakım-Ankara Deneyimi. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi.3(3):1-9.

Aydın E.(2003). Çocuklarda aydınlatılmış onam sorunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi.46(2):148-52.

Browning DM, Solomon MZ, Team IfPPCI.(2005). The initiative for pediatric palliative care: An interdisciplinary educational approach for healthcare professionals. Journal of pediatric nursing.20(5):326-334.

Büken NÖ.(2016). Yaşamın Sonunda Klinik Etik Karar Verme Süreci ve Belirleyici Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tar¬ihi Özel Dergisi,2(3):24-33.

Çelebi FZÖ, Şahin Ş.(2022). Pediatrik palyatif bakımda verilen hizmet kalitesini belirleyen faktörler. Journal of Medicine and Palliative Care.3(4):372-5.

Çetin G, Yorulmaz C.(2006). Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu. Tıbbi Malpraktis Ve Adli Raporların Düzenlenmesi. 2006;1.

Civaner M, Kavas M. (2007).Aydınlatılmış Onam Almak Üzerine Öneriler. Türkiye Biyoetik Derneği, Ankara.2-4.

Damps M, Gajda M, Stołtny L, Kowalska M, Kucewicz-Czech E.(2022). Limiting futile therapy as part of end-of-life care in intensive care units. Anaesthesiol Intensive Ther.54(3):279-284. doi: 10.5114/ait.2022.119124. PMID: 36189906; PMCID: PMC10156502.

Demir M.(2014). End-of-life decisions and their legal status in Turkey. Acta Medica.45(1):42-5.

Dilli D, Bostancı İ, Dallar Y.(2007). Çocuk hekimliğinde güncel etik sorunlar. Çocuk Dergisi.7(4):222-6.

Dussel, V., Kreicbergs, U., Hilden, J. M., Watterson, J., Moore, C., Turner, B. G., ... & Wolfe, J. (2009). Looking beyond where children die: determinants and effects of planning a child's location of death. Journal of pain and symptom manage¬ment, 37(1), 33-43.

Gemici HB, Göksoy ÖE, Doğan A, Doğan M, Arıca V.(2014). Çocuklarda aydınlatılmış onamda güncel yaklaşımlar. Journal of Clinical and Experimental Investigations.5(3):496-503.

Hatano Y, Yamada M, Fukui K. (2011).Shades of truth: cultural and psychological factors affecting communication in pediatric palliative care. Journal of pain and symptom management.41(2):491-5.

Ito Y, Okuyama T, Ito Y, Kamei M, Nakaguchi T, Sugano K, et al.(2015). Good death for children with cancer: a qualitative study. Japanese journal of clinical oncology.45-4:349-55.

Kebudi R, Cakir FB.(2017). Cultural challenges in implementing palliative services in Turkey. Palliat Med Hosp Care Open J. 1:10-4.

Malhotra S, Subodh B.(2009). Informed consent & ethical issues in paediatric psychopharmacology. Indian Journal of Medical Research. 129(1):19-32.

Mazanec P, Tyler MK. (2003).Cultural considerations in end-of-life care: how ethnicity, age, and spirituality affect decisions when death is imminent. AJN The American Journal of Nursing.103(3):50-8.

McCabe ME, Hunt EA, Serwint JR. (2008).Pediatric residents' clinical and educational experiences with end-of-life care. Pedi¬atrics.121(4):e731-e737.

Mine K, Özlem B, Sevay AG.(2021). Pediatri Pratiğinde Bilgilendirilmiş Ret: Üçüncü Basamak Bir Çocuk Hastanesinin Tek Merkez Deneyimi. Çocuk Dergisi.21(3):254-9.

Özcan BG, Çağlar Ö.(2007). Kişilik hakları-hasta hakları bağlamında tıbbi müdahale dolayısıyla çıkan hukuki ilişkide hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü ve aydınlatılmış rızaya ilişkin bazı değerlendirmeler. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 10(1):49-73.

Özsunay E. (1979).Gerçek kişilerin hukuki durumu, Kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişinin ehliyetleri, kişisel değerler ve korunması, kişilik hakkı, kişinin hukuken önemli ilişkileri, hısımlık, konut, kişisel durumlar kütükleri. Garan Matbaası: İstanbul Üniver¬sitesi Hukuk Fakültesi.

Şahin Ş, Çelebi FZÖ, Ayar G.(2022). End-of-life care in pediatric palliative care. Journal of Medicine and Palliative Care. 3(4):394-8.

Solomon MZ, Sellers DE, Heller KS, Dokken DL, Levetown M, Rushton C, et al.(2005). New and lingering controversies in pedi¬atric end-of-life care. Pediatrics .116-4:872-83.

Türk Medeni Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (No: 1219). 2018.

Üstün Ç, Demirci N.(2013). Tıpta çocuk ve etik. Türk Pediatri Arşivi.48(1):1-6.

Welch SB.(2008). Can the death of a child be good? Journal of Pediatric Nursing.23(2):120-125.

11. YAS SÜRECİ

Karmaşık ve kronik hastalıklara sahip çocuklar, farklı nedenlerle çocuk palyatif bakım ekiplerine yönlendirilebilir. Bunlardan bazıları karmaşık tıbbi kararlar, ağrı ve semptom yönetimi ve uzun süreli desteğe yönelikken, bazıları da yaşam sonu bakımıyla ilişkili olabilir *(Hospice vd., 2013)*. Bir çocuğun ölümünü düşünmek aileler için oldukça zorlayıcı ve sarsıcıdır. Yas, ağır ve izole edici bir süreçtir *(Sadak & Weiser, 2017)*. Bu süreçte, hem çocuk hem de ailesi derin bir kaygı ve üzüntü yaşar; bu, çocuklarının kaybını beklemek zorunda kalan ebeveynler için özellikle zorlayıcıdır.

Yas süreci, ailelerin hayatında derin yaralar açarken, toplumsal olarak ölümden kaçınan bir kültür, bu süreci daha da zorlaştırabilir *(Kripalani, 2019)*. Aileler, çocuklarının ölümünün ardından yalnız bırakıldıklarını ve sağlık sisteminden dışlandıklarını hissedebilir *(Rosenberg vd., 2012; Stevenson vd., 2017)*. Bu süreçte sağlık profesyonellerinin, ailelerin yanında durarak, onların yas sürecini anlamaları ve bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerine destek olmaları hayati önem taşır *(Hudson vd., 2018)*.

Bu çok yönlü, disiplinler arası ve bütüncül yas desteği, çocuğun ölümünden önce başlar ve her ailenin özgül ihtiyaçlarına göre şekillenerek yas süreci boyunca devam eder *(Currier vd., 2008)*. Kapsamlı bir yas desteği, ailelerin bu süreçte yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına ve kendilerini yalnız hissetmemelerine yardımcı olur.

11.1. Beklenen Yas

11.1.1. Normalin, Kontrolün ve Dünya Görüşünün Kaybı

Yaşamı sınırlayan bir hastalık tanısı, aile için yas yolculuğunun başlangıcıdır. Çocuğun tedavi, testler ve prosedürler nedeniyle "normal" bir çocukluk geçirme umudu artık mümkün değildir. Ebeveynler, "Ya...?" sorularını sormaya başlar ve genellikle ölüm düşüncesini akıllarından uzaklaştırmaya çalışırlar. Birçok aile destek sistemlerini, işlerini, mali güvencelerini, fiziksel sağlıklarını, inançlarını, ruh sağlıklarını ve daha fazlasını kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır; bu ikincil kayıplar, çocuğun hastaneye yatmasıyla birlikte yaşanan stresi daha da artırır *(Harris, 2019)*. Ailenin güvenlik hissi, daha önce kabul edilen dünya görüşünün çatlamasıyla kaybolur ve her birey, neyin iyi, adil ve anlamlı olduğunu sorgular hale gelir *(Kauffman, 2013)*.

11.1.2. Erken Dönemde Danışmanlık Hizmeti Gereksinimi

- ***Erken Dönemden İtibaren Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi:*** En iyi uygulamalar, yaşamın sonuna yaklaşmadan, tanı sürecinin daha erken dönemlerinde danışmanlık hizmeti verilmesini teşvik etmektedir; çünkü bu sayede çocuk, hem palyatif bakım hizmetlerini hem de hastalık odaklı tedaviyi eş zamanlı olarak alabilir *(Friedrichsdorf & Bruera, 2018; Keim-Malpass & Lindley, 2017)*. Bu erken etkileşimler, yas sürecinde biriken duyguları ele

almak için daha fazla zaman tanır. Ailelerin başa çıkma becerilerini geliştirmelerine erken dönemde yardımcı olmak, gelecekte karşılaşacakları zor anlar için sağlam bir temel oluşturur *(Fleming-Damon, 2016)*.

- ***Yas Sürecini İsimlendirmek:*** Aileler, kimi zaman güçlü duygularının, öfke patlamalarının ve fiziksel sıkıntılarının altta yatan yas sürecinden kaynaklandığını fark etmeyebilirler. Bu yaşadıkları durumun bir yas süreci olduğunu doğrulamak ve isimlendirmek, ebeveynlere yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve potansiyel olarak daha yumuşak bir kişisel bakış açısı sağlayabilir *(Krawczyk & Gallagher, 2016)*.

11.1.3. Beklenen Yas Sürecinin Başlaması

Beklenen yas genellikle tıbbi ekibin, çocuklarının hastalığının tedavi edilemeyeceği bir safhaya geldiği haberini aileyle paylaşımından kısa bir süre sonra başlar. "Tüm tıbbi müdahaleleri tükettik. Çocuğunuzu iyileştirecek hiçbir şey kalmadığını söylemekten derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasının yapıldığı anlarda veya, aileler çocuğun fiziksel veya zihinsel gerileme belirtilerini gözlemlediğinde bu süreç başlayabilir. Çocuğun yaşamının sonuna yaklaştığı bu dönemde, aileler, tıbbi ekibin bakım sağlamayı bırakacağından endişe edebilir. Ancak bu duygusal dönemde, palyatif bakım ekibinin özel semptom yönetimi ve şefkatli yas müdahaleleri öncelikli hale gelir *(Sisk vd., 2020)*.

11.1.4. Çocuğun ve Kardeşlerin Yas Sürecine Dâhil Edilmesi

Bazı çocuklar, kendi ölümlerinin yaklaşmakta olduğunu anlayacak yaşta veya bilinçte olabilir. Bu durum, çocuğun ve ailenin yas sürecine daha derin bir hazırlık süreci gerektirir. Ayrıca aileler, kardeşlerin de yaşam sonu bakıma dâhil edilmesi konusunda desteklenmelidir. Bu dönemde sağlanan destek, ailenin yas sürecinin ilerleyişi açısından kritik bir öneme sahiptir *(Schuelke vd., 2021)*.

11.1.5. Ölüm Kaygısı

- ***Ölüm Kaygısında Risk Faktörleri:*** Ölüm öncesindeki süreçte çocuklar daha duygusal olsalar dahi, çocukların tümünde yüksek düzeyde kaygı yaşanacağı varsayımı yanlıştır ve bu düşünce semptomların etkin bir şekilde değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini olumsuz etkileyebilir *(Breitbart & Alici, 2014)*. Yetersiz bilgilendirme ya da çocuktan bilgi gizleme, çocuğun tıbbi karar alma sürecine dâhil edilmemesi ve fiziksel sıkıntılarının yeterince giderilemeyeceği endişesi (örneğin ölüm anında acı çekme endişesi) çocukların ölüm kaygısını artırabilir. Özellikle ergenlerin, yaşam sonu sürecinde anksiyete ve depresif belirtiler yaşama olasılığı küçük çocuklara göre daha yüksektir *(Schuelke vd., 2021)*.
- ***Önceden Var Olan Kaygı Bozukluklarının Etkisi:*** Araştırmalar, ölüm öncesi dönemde kontrol edilemeyen kaygının, ebeveynlerin ölüm sonrası yaşadıkları psikolojik sorunları kötüleştirdiğini göstermektedir *(Jalmsell vd., 2010)*.

- ***Fiziksel Semptomlar ve Kaygı Arasındaki Döngüsel İlişki:*** Ölüm kaygısının değerlendirilmesini ve tedavisini zorlaştırabilen bir diğer durum, organik fizyolojik semptomlar ile kaygıya bağlı bedensel duyumlar arasındaki döngüsel ilişkidir. Örneğin, nefes darlığı, yaşam sonuna yaklaşan bireylerde sıkça deneyimlenen bir semptomdur ve bu his, fizyolojik olarak sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu taklit edebilir. Bu da bir dizi endişeli düşünceyi (örneğin, "Acaba şu anda ölüyor muyum?") ve ardından daha fazla fizyolojik uyarılmayı tetikleyebilir *(Schuelke vd., 2021)*. Buna ek olarak, fiziksel semptomları hafifletmek için verilen bazı sempatomimetik ilaçlar da (örn. prednizon, deksametazon, bronkodilatörler) kaygıyı istemeden kötüleştirebilir *(Breitbart & Alici, 2014)*.
- ***Ölüm Sürecine İlişkin Bilgilendirme:*** Bazı ergenler, nasıl ölecekleri konusunda bilgi sahibi olarak hazırlıklı olmak isterler. Örneğin, akut tıbbi bir olay neticesinde ölüm korkusu olan bir ergen her an ölebileceği düşüncesiyle sürekli bir kaygı yaşayabilir. Hastalığının yavaş ilerleme göstereceği bilgisinin verilmesi gencin yaşadığı kaygıyı azaltmada önemli bir etken olacaktır. Buna karşın, bir gün sabah uyanamayacağı korkusu gibi başka kaygılar ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda kaygının doğrudan ele alınması, gevşeme stratejilerini içeren bir rutin oluşturulması ve aile üyeleriyle fiziksel yakınlık ve sevgi ifadelerinin açık paylaşımı sürecin yönetimini kolaylaştıracaktır *(Schuelke vd., 2021)*.
- ***"Koruyucu Kaçınma" ve İnkar:*** Bazı gençler "koruyucu kaçınma" davranışı sergiler ve durumlarının ciddiyetini inkar ederler; bu da başa çıkma becerilerini zayıflatabilir ve korku ve kaygılarını yeterince ele almayı zorlaştırabilir *(Breitbart & Alici, 2014)*. Çocuk ve ergenler kendi çekecekleri acıdan duydukları korkunun yanı sıra, ölümlerinden sonra sevdiklerinin nasıl başa çıkacağı konusunda endişe duyabilirler *(Himelstein vd., 2004; Kreicbergs vd., 2004)*.
- ***Kültürel ve Ailevi Faktörler:*** Ölüm kaygısı, aile ve kültürel değerler bağlamında da ele alınmalıdır. Çocukla kurulan iletişimin tarzı, ailenin çocuklarını tıbbi karar verme sürecine ne oranda dâhil ettiği, ağrı/acı gibi fiziksel sıkıntıların aile içinde nasıl ifade edildiği, yine aile ya da kültürel değerler içerisinde acı çeken kişiye yönelik diğerlerinin tutumunun nasıl olduğu gibi faktörler, çocukların kaygı düzeyini önemli ölçüde etkileyebilir *(Breitbart & Alici, 2014; Sisk vd., 2016)*. Bunlardan bazılarının çocuğun anksiyetesini artırdığı tespit edilse dahi, kültürel uyum gözetilmeden yapılan müdahaleler, çocuk ve aile için uygunsuz olacaktır, hatta bazı durumlarda zararlı dahi olabilir *(Schuelke vd., 2021)*.

11.1.6. Maneviyatın Rolü

Manevi acı, ihtiyaçların karşılanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Fiziksel acı, örneğin kişinin hareket kabiliyetini tehdit edebilirken, manevi acı, kişinin inançlarını ve yaşam amaçlarını tehdit eder *(O'Brien, 1996)*. Özellikle çocuklar ölüm hazırlığı yaparken manevi acı hem çocuklarda hem ailelerinde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Din ve maneviyat, çocuklar ve aileleri için yaşamın anlamı ve amacı üzerinde güçlü bir temel oluşturur. Çocuklar yaşamın derin sorularını sorduğunda ne söylemek gerektiğini bilmek zor olabilir, çünkü bu sorulara kesin cevaplar yoktur.

11.1.7. Son Dönem Bakımında Mekanın Önemi

Bir çocuğun son dönemlerini nerede geçireceği, nerede ve nasıl öleceği, aileler için büyük bir anlam taşıyabilir, hatta ölümün üzerinden yıllar geçse de bu anlam devam edebilir *(Meij vd., 2008)*. Tüm aileler çocuklarının nerede öleceğini seçemese de, planlama için zaman varsa, sağlık personeli ailelere bu konudaki tercihlerini sorabilir.

- ***Ev Tercihi:*** Bazı aileler, çocuğun sevdikleriyle birlikte tanıdık ve rahat bir ortamda olması nedeniyle evde ölümün değerli olduğunu düşünür. Evde palyatif bakım, çocuğun fiziksel, duygusal ve manevi semptomlarının ele alınmasını sağlamak için sıklıkla destek sunar. Bazı aileler ise evde ölüm istemezler, genellikle kardeşlerin ölüm anına tanık olmasını istemedikleri veya çocuğun ölümünden sonra evde yaşamın çok zor olacağına dair bir korkuları olduğu için evde ölümden kaçınırlar.
- ***Hastane Tercihi:*** Hastane ortamı, tedavi edici terapiler, yaşam kurtarıcı tedaviler ve rahatlatıcı bakımın tek bir yerde sağlanabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir *(Zwerdling vd., 2006)*. Bazı aileler, hayatlarının sonuna kadar "savaşmayı" değerli bulur, diğer aileler, çocuğu rahat tutmaya yönelik ilaçları sağlamaya ve/veya artık faydalı olmayan yaşamı sürdürme tedavilerini sonlandırmaya odaklanabilir. Çocuklar genellikle yıllarca hastanelerde tedavi aldıkları için, son dönemlerinde tanıdık sağlık çalışanlarıyla çevrili olmak onlara rahatlık verebilir. Terminal dönemde mekan seçimi son derece kişiseldir ve ailelere son derece zor bir zamanda bir miktar kontrol duygusu sağlayabilir *(Schuelke vd., 2021)*.

11.1.8. Aile Temelli Müdahaleler ile Yas Sürecini Desteklemek

- ***Aile Genelinde İyilik Halinin Sağlanması:*** Aile bütünlüğünün ne oranda sağlanabildiği ve aile içindeki ilişkilerin yakınlığı, yas sürecinin nasıl yaşanacağını belirleyen önemli faktörlerdendir *(Warnick, 2015)*. Bu nedenle destekleyici müdahaleler, aile üyeleri arasındaki duygusal ifadeyi kolaylaştırmayı, çatışmalı ilişkileri çözümlemeyi ve yaklaşan kayıp karşısında ailelerin bir anlam ve amaç duygusu kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyebilir *(Breitbart & Alici, 2014)*.
- ***Kardeşler:*** Ölümü beklenen çocuklar için, kardeşlerin bu ölüm hakkında bilgilendirilmesi ve ne beklemeleri gerektiği konusunda hazırlanmaları önemlidir (örneğin, kardeşlerinin nasıl görüneceği, hangi fiziksel semptom veya olayları görebilecekleri gibi). Bu bilgilere önceden erişimi olmayan kardeşler, uzun vadede daha yüksek kaygı ve genel duygusal sıkıntı yaşarlar; buna karşın, tam anlamıyla bilgilendirilen ve sürece dâhil edilen kardeşler daha sağlıklı yas süreci geçirirler *(Lövgren vd., 2016; Rosenberg vd., 2015)*. Ebeveynlerini ek sıkıntıdan korumak amacıyla, kardeşler çoğu zaman kendi yaslarını ifade etmekten kaçınırlar. Ancak bu durum, zamanla kaygı olasılığını artırabilir *(Schuelke vd., 2021)*.

11.1.9. Ölüm Hakkında Çocuklarla Konuşmak

11.1.9.1. Ölmek Üzere Olan Çocukla İletişim

- ***Sık Yapılan Hatalar:*** Ölüm ve ölmek hakkında küçük çocuklarla konuşmak, ebeveynler için çok zorlayıcı bir deneyim olarak bildirilmektedir *(Longbottom & Slaughter, 2018)*. Araştırmalar, yaklaşan ölüme dair daha kaygılı olan ebeveynlerin bu önemli konuşmalardan kaçınma eğiliminde olduğunu ve "uykuya dalmak", "daha iyi bir yere gitmek" gibi örtük ifadeler kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu tür örtük ifadeler, çocuklarda ve kardeşlerinde kafa karışıklığına neden olabildiği gibi, aynı zamanda yeni stres ve korkuların ortaya çıkmasına yol açabilir *(Stuber & Hovsepian, 2001)*. Örneğin, "uykuya dalma" benzetmesi yapıldığında çocuklar bir daha uyanamayacağından korkabilir ve uyumaya yönelik yoğun bir kaygı yaşayabilirler.
- ***Doğru Terimlerin Kullanılması:*** Sağlık profesyonelleri, çocuklarla konuşurken "ölüm", "ölmek" ve "ölü" gibi doğrudan terimlerin kullanılması için aileleri teşvik etmelidir. Küçük yaştaki çocuklar, otizm spektrumundaki çocuklar ve gelişimsel gecikmeleri olan çocuklar için yaşam döngüsünün açıklanması ve ölümün kalıcılığı hakkında bilgi verilmesi yararlı olabilir.
- ***Duyguların Kabulü:*** Çocuklarla ayrıca yas sürecinde yaşayabilecekleri duygular hakkında konuşmak ve üzüntü, öfke, rahatlama ve mutluluk gibi çeşitli duyguları hissetmenin normal olduğunu belirtmek; yeri geldiğinde ağlamalarına izin vermek yararlı olacaktır.
- ***Sağlık Profesyonellerinin Aracı Rolü:*** Palyatif bakım ekibi, "Çocuğunuz ölüm ve ölmek hakkında sorular sorarsa bu durumu nasıl ele almak istersiniz?" gibi sorular sorarak ailelerin bu konuşmalara hazırlanmalarına yardımcı olabilir ve gerektiğinde bu konuşmaları kolaylaştırmak için bir aracı olmayı teklif edebilir *(Longbottom & Slaughter, 2018; Stuber & Hovsepian, 2001)*.

11.1.9.2. Kardeşlerle İletişim

- ***Çocukların Geçmiş Ölüm Deneyimlerini Öğrenmek:*** Bir çocuğun yaklaşan ölümü hakkında bu önemli konuşmalara başlamadan önce, bakım verenlere kardeşin daha önceki ölüm deneyimleri hakkında sorular sormak faydalı olabilir; bu deneyimler aile üyelerinden birini, bir evcil hayvanı veya bir arkadaşı kaybetmekle ilgili olabilir.
- ***Sağlık Profesyonellerinin Rolü:*** Sağlık profesyonelleri, ayrıca çocukların farklı gelişim aşamalarındaki yas deneyimleri hakkında örnekler barındıran ve kaçınılması gereken yaygın terimleri açıklayan kaynaklar sunabilir. Ailelere, bebekler ve küçük çocuklar da dâhil olmak üzere tüm çocukların yas sürecini yaşadıklarını ve çevrelerindeki duyguları algılayabildiklerini hatırlatmak önemlidir.

- ***Aileleri "Ölüm" Hakkında Konuşmaya Teşvik Etmek:*** Ailelerin ölüm ve ölmekle ilgili konuşmalara katılımını teşvik etmek, her ne kadar zorlayıcı olsa da, çocuklarla açık ve dürüst biçimde bu tür konuşmalar yapmak, onların bakım verenlerine yönelik temel güven duygularını ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olur.
- ***Eksik Bilgiler Yas Sürecini Olumsuz Etkileyebilir:*** Çocuklar başka bir şeye odaklanmış görünseler bile genellikle çevrelerinde konuşulanları dinlerler; bazen hasta olan kardeşlerinin ölümünün gerçek nedeni hakkında yanlış anlamalara yol açabilir. Bu nedenle, palyatif bakım ekibinin ve aile üyelerinin çocuklara, kardeşlerinin ölümüne neden olanın söyledikleri veya yaptıkları bir şey olmadığını güvenceyle ifade etmeleri büyük önem taşır *(Kurowska-Susdorf, 2015; Schuelke vd., 2021).*

11.2. Ölüm Zamanındaki Yas

11.2.1. Ölüm Anı

Bir çocuğun ölümünden önceki ve sonraki günler ve saatler birçok kişi için çok değerlidir. Bu anlar, ailenin çocukla birlikte olacağı son zamanları temsil eder ve ailenin hafızasında kalıcı bir iz bırakır *(Contro vd., 2010).* Birçok aile sessizce dua etmeyi, çocuklarıyla yatmayı, müzik çalmayı veya çocuklarına son kez söylemek istedikleri şeyleri veya duygularını ifade etmek için yumuşak bir şekilde konuşmayı tercih edebilir.

- ***Aileler için Mahremiyetin Sağlanması:*** Aile tarafından özel bir destek hizmeti talep edilmedikçe, sağlık profesyonelleri bu dönemde ailenin mahremiyetine olanak sağlamalıdır. Profesyoneller, ailenin kolayca ulaşabileceği mesafede olmalı ancak aileye mahremiyet tanıyacak kadar uzak durmalıdır.
- ***Çocuğun Son Saatleri Hakkında Aileleri Bilgilendirme:*** Ailelerin, çocuğun yaşamın son döneminde yaşayabileceği belirtiler ve semptomlar hakkında bilgilendirilmesi faydalıdır (örneğin, sığ ve düzensiz solunum, ciltte morarma, idrarın azalması, sindirim sisteminin yavaşlaması, bilinçte azalma) *(Thompson & Young Saleme, 2015).* Bu belirtiler ortaya çıktığında, sağlık profesyonellerinin ek semptom yönetimi, eğitim ve psikososyal destek sağlama açısından ailenin yanında hazır bulunmaları önem taşır. Aileler bu süreçte çoğunlukla çocuğa rahatlatıcı ilaçlar verilmesinden endişe duyarlar, çünkü bu ilaçların ölümü hızlandırabileceğinden korkarlar *(Greenfield vd., 2020).* Palyatif bakım ekibinin rehberliğiyle, ailelere, ağrı ve semptom yönetimi için ilaçların uygun şekilde kullanılacağı konusunda güvence verilebilir.

11.2.2. Ölüm Sonrası Bakım

- ***Ölümden Sonraki İlk Anlar:*** Ölümün hemen ardından yaşanan anlar, aileler için derin duygusal ve manevi bir anlam taşır. Hastane ve palyatif bakım ekipleri, ailelerin dini

otoritelerle koordinasyonuna destek olarak gerekli işlemler hakkında rehberlik sağlayabilir ve bu anlamlı zamanda ailelerin kendi geleneklerini onurlandırmalarına yardımcı olabilir *(Wiener vd., 2020)*.

- ***Duygusal Tepkiler ve Yas Sürecini Destekleme:*** Eğer ölüm öncesinde hatıra eşyaları yapılmamışsa, sağlık profesyonelleri bu hatıraların aile ve kardeşlerle birlikte oluşturulmasını teşvik edebilir. Bu duygusal anlar, hıçkırıklar, gözyaşları içinde gülümsemeler veya öfke dolu tepkiler gibi çok çeşitli duygularla dolu olabileceği ve bu duyguların yas sürecinin normal bir parçası olduğu önceden aileye aktarılmalıdır. Sağlık profesyonellerinin rolü, aile üyelerinin yas tepkilerini onaylamak ve desteklemek, ayrıca güvenli ve sıcak bir ortam oluşturulması için aracılık etmektir *(Breen vd., 2022)*. Aileler, ölüm anında tıbbi ekibin yaptıklarını ve söylediklerini ayrıntılı olarak hatırlayacaktır *(Pike, 2015)*. Sağlık profesyonelleri, basmakalıp ifadelerden ve "en azından" diye başlayan cümlelerden kaçınmalıdır.
- ***Ölüm Sonrası Ailenin Bilgilendirilmesi ve Desteklenmesi:*** Çocuğun bedeninin alındıktan sonra hangi aşamalardan geçeceği konusunda aileye önceden bilgi verilmesi yararlı olabilir. Kardeşlerin de bu süreçte ihtiyaçları gözetilmeli ve bedenle vedalaşma anında bulunmak istemezlerse onlara güvenli bir alan sunulmalıdır. Ayrıca, ailenin soru sormak veya destek almak istediklerinde kolayca ulaşabilecekleri bir iletişim kişisi belirlenmesi büyük önem taşır. Bu ayrıntılar, yas sürecinde ailenin ilerleyen günler, haftalar ve aylar boyunca güçlü bir destek hissetmesine katkıda bulunur *(Lebus vd., 2014)*.

11.2.3. İlk Haftalar

Bir çocuk kaybedildikten sonraki ilk haftalarda aileler, çoğu zaman şok içinde olup yaşananları tam anlamıyla idrak edemeyebilir. Yas süreci her ne kadar kişisel ve bireye özgü olsa da, yasla ilgili yaygın tepkiler şu şekilde sıralanabilir ve bu tepkiler arasında gidip gelmeler yaşanabilir: (1) hissizlik ve isyan; (2) arayış ve özlem; (3) dağılma ve umutsuzluk; (4) yeniden toparlanma (Lebus vd., 2014). Bu süreçte inanmama ve inkâr, suçluluk ve kendini suçlama, öfke ve çaresizlik, kıskançlık ve içerleme, yalnızlık ve özlem gibi başka duygular da ortaya çıkabilir. Ayrıca yas sürecine eşlik eden bazı fiziksel belirtiler görülebilir, bunlar: (1) nefes darlığı, (2) halsizlik ve yorgunluk, (3) huzursuzluk ve kaygı, (4) unutkanlık, (5) kalp atışında hızlanma, (6) kilo ve iştah değişiklikleri, (7) göğüste veya boğazda sıkışma hissi şeklinde sıralanabilir *(Eaton vd., 2016)*. Fiziksel belirtiler zamanla azalabilirken, duygusal tepkiler yas sürecinde bireyin duygularını anlamlandırmaya başlamasıyla birlikte evrilebilir *(Schuelke vd., 2021)*.

11.3. Ölümden Sonra Yas

11.3.1. Yas Takibi Süreci

Bir çocuk vefat ettiğinde, aile yeni ve istenmeyen bir gerçeklikle karşı karşıya kalır. Birçok aile, hayatlarını çocuklarının ölümünden önce ve sonra olarak ayıran bir perspektif değişimi yaşar *(Stevenson vd., 2017)*. Aileyle olan iletişim çocuğun ölümünden sonra aniden kesilecek olursa, bu durum ailede terk edilmişlik hissine neden olabilir *(Lichtenthal, Sweeney, vd., 2015; Stevenson vd., 2017)*. Tıbbi ekip tarafından çocuğun ölümünün ardından başlatılacak bir yas takibi süreci, hastane ortamından çıkan ailelerin kendi topluluğuna yeniden uyum sürecinde bir köprü işlevi görebilir *(Borgman vd., 2014)*. Destekleyici bilgiler içeren broşür ya da kitapçıklar faydalı olabilir. Ayrıca, ölümden birkaç gün ve ay sonra aileyi arayarak destek sunmak oldukça anlamlı olabilir. Genel olarak, aileler palyatif bakım ekibi ve sağlık ekibinden haber almayı, kendilerinin ve çocuklarının unutulmadığını bilmekten memnuniyet duyarlar *(Raitio vd., 2015)*.

11.3.2. Yas Sürecinde Bireysel - Kültürel Duyarlılık ve Kapsayıcılık

- ***Yasın Evrensel ve Bireysel Boyutu:*** Yas, kişiye özgü bir deneyim olmakla birlikte aynı zamanda evrensel bir yaşantıdır *(Worden, 2018)*. Bu nedenle, ailelerle yapılacak görüşmelerde uzmanların kendi kayıp ve yas deneyimlerinin farkında olmaları, karşı tarafın kültürel veya geçmişine dair varsayımlarda bulunmadan merak ve anlayışla yaklaşmaları çok önemlidir. Bu yaklaşımda, yas sürecine dair bireyin kendi "dünya görüşüne" odaklanmak, süreci daha iyi anlamak için güçlü bir zemin oluşturur.
- ***Kültürel Farklılıkları Gözetmek:*** Toplumlar giderek daha çeşitli hale geldikçe, yas sürecindeki çocuklar ve ailelerle çalışan uzmanların kültürel hassasiyetle yaklaşmaları gerekliliği de artmaktadır. Bu yaklaşım, çeşitli aile yapıları, gelenekler, cinsiyet kimlikleri, sosyal sınıflar, etnik kökenler ve farklı inançlara sahip ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çocuğun veya ailenin kendi kültürlerine dair uzmanlıklarına saygı duymayı içerir *(Layne, 2013)*. Bu, kültürel tevazu prensiplerine dayanan bir yaklaşımdır; uzmanların her bireyin kültürüne dair her şeyi bilmediklerini kabul etmeleri ve öğrenmeye açık bir zihinle karşısındakinin hikayesine yaklaşmalarını gerektirir *(Harris & Bordere, 2016)*. Yas süreci hem bireysel hem de evrensel boyutlarıyla karmaşık bir yapı sergilediğinden, uzmanlar çocuğun veya ailenin olduğu noktada onlarla buluşmalı ve onların kendi hikayelerinin uzmanı olmalarına imkân tanımalıdır.

11.3.3. Danışmanlık ve Terapi Desteği

- ***Yasın Doğal Süreci ve Müdahale Gerekliliği:*** Yas, kişisel bir kayba verilen doğal bir tepkidir ve genellikle patolojik bir durum olarak değerlendirilmez. Son derece acı verici olmasına rağmen, bireylerin yas deneyimleri genellikle normatif bir süreçtir ve bu nedenle her zaman

özellikli bir psikolojik müdahale gerekmez. Müdahale genellikle, kayıptan sonra 6 ila 12 ay geçene kadar düşünülmez, çünkü bu müdahale doğal yas sürecine etki edebilir veya onu patolojik hale getirebilir. Bir çocuğun kaybı, özellikle zorlayıcıdır. Yas tutan ebeveynler, eş veya ebeveyn kaybı yaşayanlara kıyasla daha yoğun ve uzun süren karmaşık yas semptomları bildirmektedir *(Middleton vd., 1998; Tervalon & Murray-Garcia, 1998).*

- ***Komplike ve Uzamış Yas:*** Komplike ve uzamış yas süreci yaşayan bireylerde, ölümden bir yıl sonra bile hala yoğun bir şekilde devam eden yas semptomları ve işlevsellikte kayıp olabilmektedir. Komplike ve/veya uzamış yas sürecinde olduğu fark edilen ailelerin psikolojik destek ve uygun müdahaleler açısından doğru birimlere yönlendirilmeleri gerekir.
- ***Ebeveynlerin Psikolojik Destek Arayışındaki Engel ve Zorluklar:*** Araştırmalar, ebeveynlerin yaklaşık %40'ının destek istemekle birlikte tedaviye başvurmadıklarını göstermektedir *(Lichtenthal, Corner, vd., 2015).* Yas sürecine özgü, tedavi arayışını engelleyen birkaç engel bulunmaktadır. Bu engeller arasında gerçekliği kabulde zorlanma, kaybın acı veren hatırlatıcılarından kaçınma isteği, yas sürecinde ruh sağlığı desteğinin rolü ve mevcudiyeti hakkında bilgi eksikliği sayılabilir *(Schuelke vd., 2021).*
- ***Kardeş Kaybı Yaşayan Çocukların Yas Deneyimi ve Destek İhtiyacı:*** Kardeş kaybı, çocuklar için karmaşık ve uzun soluklu bir yas süreci başlatabilir ve bu sürecin doğası, çocukların gelişim seviyelerine göre zamanla değişebilir *(Lövgren vd., 2016).* Kardeşini kaybetmiş çocuklar, duygularını ifade edebilecekleri, kendilerini yalnız hissetmedikleri ve anlamlı sosyal destek buldukları ortamlara ihtiyaç duyarlar. Şiddetli ve sürekli yas tepkileri gösteren çocuklar içinse psikolojik tedavi ihtiyacı doğmaktadır *(Schuelke vd., 2021).*
- ***İntihar Düşünceleri ve Davranışları:*** Yas tutan ebeveynler, ölen çocuklarına kavuşma arzusu veya onsuz yaşamanın getirdiği acı nedeniyle sıklıkla kendi ölümleriyle ilgili düşünceler yaşayabilirler. Bu tür düşünceler, yas sürecindeki bir ebeveyn için oldukça normal kabul edilebilir *(Zetumer vd., 2015).* Özellikle kişi intihar planından bahsediyorsa veya silah gibi tehlikeli araçlara erişimi varsa, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından bir intihar değerlendirmesi yapılması önemlidir. Bu nedenle, uyarı işaretlerini tanıyabilmek ve yas sürecindeki kişilere intihar krizleri durumunda başvurabilecekleri kaynakları sunmak önemlidir. Ailelerin, yakın çevrelerinden destek almalarının yanı sıra, çocuklarının ölümünden sonra, bu tür düşüncelerin ortaya çıkma ihtimaline karşı iletişime geçebilecekleri bir profesyonelin (sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hekim, hemşire, ya da yas danışmanı gibi) iletişim bilgilerine sahip olmaları faydalı olacaktır *(Schuelke vd., 2021).*

Çocuk palyatif bakımda, ölüm anındaki şefkatli ve bilinçli destek büyük önem taşımaktadır *(Pfaff & Markaki, 2017).* Yas desteği, her ailenin ihtiyaçlarına göre kapsamlı ve özel olarak uyarlanmalıdır. Yetersiz destek, hiç destek olmamasından daha zararlı olabilir *(Stroebe vd., 2017).* Tüm palyatif

bakım ekibinin, uzmanlık alanları ne olursa olsun, güncel yas teorisi, destekleyici dil ve en iyi uygulamalar konusunda eğitim almalarına olanak sağlayacak programların düzenlenmesi veya imkân varsa yas konusunda psikoeğitim almaları çok yararlı olacaktır. Aile ile ilişki en azından akut dönemi boyunca devam etmelidir *(Schuelke vd., 2021)*. Yas süreci boyunca her bir aile üyesinin anlaşıldığını ve desteklendiğini hissetmesi sağlanmalı, bu süreçte yalnız olmadıkları onlara hissettirilmelidir. Sonuç olarak, çocuk kaybı yaşayan ailelere sağlanan yas desteği, palyatif bakım hizmetlerinin temel bir bileşeni olmalıdır.

Kaynakça

Allen, R. S., Hilgeman, M. M., Ege, M. A., Shuster, J. L., & Burgio, L. D. (2008). Legacy Activities as Interventions Approaching the End of Life. Journal of Palliative Medicine, 11(7), 1029–1038. https://doi.org/10.1089/jpm.2007.0294

Boles, J. C., & Jones, M. T. (2021). Legacy perceptions and interventions for adults and children receiving palliative care: A systematic review. Palliative Medicine, 35(3), 529–551. https://doi.org/10.1177/0269216321989565

Borgman, C. J., Meyer, M. C., & Fitzgerald, M. (2014). Pediatric Bereavement Services: A Survey of Practices at Children's Hospitals. OMEGA - Journal of Death and Dying, 69(4), 421–435. https://doi.org/10.2190/OM.69.4.e

Breen, L. J., Kawashima, D., Joy, K., Cadell, S., Roth, D., Chow, A., & Macdonald, M. E. (2022). Grief literacy: A call to action for compassionate communities. Death Studies, 46(2), 425–433. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1739780

Breitbart, W. Y., & Alici, Y. (2014). Psychosocial palliative care. Oxford University Press.

Care, N. C. P. for Q. P. (2004). Clinical practice guidelines for quality palliative care. The Kansas Nurse, 79(9), 16–20.

Contro, N., Davies, B., Larson, J., & Sourkes, B. (2010). Away from Home: Experiences of Mexican American Families in Pediatric Palliative Care. Journal of Social Work in End-Of-Life & Palliative Care, 6(3–4), 185–204. https://doi.org/10.1080/15524256.2010.529020

Currier, J. M., Neimeyer, R. A., & Berman, J. S. (2008). The effectiveness of psychotherapeutic interventions for bereaved persons: A comprehensive quantitative review. Psychological Bulletin, 134(5), 648.

Eaton, M., Hughes, H., & MacGregor, J. (2016). Contemplative approaches to sustainability in higher education. Taylor & Francis. https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315641249&type=googlepdf

Fleming-Damon, C. (2016). Family care during end-of-life vigils. Nursing Clinics, 51(3), 459–469.

Foster, T. L., Dietrich, M. S., Friedman, D. L., Gordon, J. E., & Gilmer, M. J. (2012). National Survey of Children's Hospitals on Legacy-Making Activities. Journal of Palliative Medicine, 15(5), 573–578. https://doi.org/10.1089/jpm.2011.0447

Friedrichsdorf, S. J., & Bruera, E. (2018). Delivering pediatric palliative care: From denial, palliphobia, pallilalia to palliactive. In Children (Vol. 5, Issue 9, p. 120). MDPI. https://www.mdpi.com/2227-9067/5/9/120

Gallagher, L. M., Lagman, R., & Rybicki, L. (2018). Outcomes of Music Therapy Interventions on Symptom Management in Palliative Medicine Patients. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 35(2), 250–257. https://doi.org/10.1177/1049909117696723

Gallagher, L. M., Lagman, R., Bates, D., Edsall, M., Eden, P., Janaitis, J., & Rybicki, L. (2017). Perceptions of family members of palliative medicine and hospice patients who experienced music therapy. Supportive Care in Cancer, 25(6), 1769–1778. https://doi.org/10.1007/s00520-017-3578-y

Greenfield, K., Holley, S., Schoth, D. E., Harrop, E., Howard, R. F., Bayliss, J., Brook, L., Jassal, S. S., Johnson, M., Wong, I., & Liossi, C. (2020). A mixed-methods systematic review and meta-analysis of barriers and facilitators to paediatric symptom management at end of life. Palliative Medicine, 34(6), 689–707. https://doi.org/10.1177/0269216320907065

Harris, D. (2020). Non-death loss and grief: Context and clinical implications. Routledge.

Harris, D., & Bordere, T. (2016). Handbook of social justice in loss and grief. Routledge.

Himelstein, B. P., Hilden, J. M., Boldt, A. M., & Weissman, D. (2004). Pediatric Palliative Care. New England Journal of Medicine, 350(17), 1752–1762. https://doi.org/10.1056/NEJMra030334

Hospice, S. on, Medicine, P., Care, C. on H., Feudtner, C., Friebert, S., Jewell, J., Friebert, S., Carter, B., Feudtner, C., Hood, M., Imaizumi, S., & Komatz, K. (2013). Pediatric palliative care and hospice care commitments, guidelines, and recommendations. Pediatrics, 132(5), 966–972.

Hudson, P., Hall, C., Boughey, A., & Roulston, A. (2018). Bereavement support standards and bereavement care pathway for quality palliative care. Palliative & Supportive Care, 16(4), 375–387.

Jalmsell, L., Kreicbergs, U., Onelöv, E., Steineck, G., & Henter, J. (2010). Anxiety is contagious—Symptoms of anxiety in the terminally ill child affect long term psychological well being in bereaved parents. Pediatric Blood & Cancer, 54(5), 751–757. https://doi.org/10.1002/pbc.22418

Kauffman, J. (2014). Loss of the assumptive world: A theory of traumatic loss. Brunner-Routledge.

Keim-Malpass, J., & Lindley, L. C. (2017). Repeal of the affordable care act will negatively impact children at end of life. Pediatrics, 140(3). https://publications.aap.org/pediatrics/article- abstract/140/3/e20171134/38338

Krawczyk, M., & Gallagher, R. (2016). Communicating prognostic uncertainty in potential end-of-life contexts: Experiences of family members. BMC Palliative Care, 15(1), 59. https://doi.org/10.1186/s12904-016-0133-4

Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Onelöv, E., Henter, J.-I., & Steineck, G. (2004). Talking about Death with Children Who Have Severe Malignant Disease. New England Journal of Medicine, 351(12), 1175–1186. https://doi.org/10.1056/NEJMoa040366

Kripalani, S. (2019). Death and dying: The literature, philosophy, & practices of adult & pediatric end-of-life care. Veritas: Villanova Research Journal, 1, 45–76.

Kurowska-Susdorf, A. (2015). Parents and children in death education–a Kashubian context. Edukacja, 133(2), 139–149.

Layne, A. K. A. (2013). Tapestries: A Creative & Inclusive Approach to Grief Support for Youth & Communities. CreateSpace.

Lebus, C., Parker, R. A., Morrison, K., Fraser, D., & Fuld, J. (2014). Families' Concerns after Bereavement in Hospital: What Can We Learn? Journal of Palliative Medicine, 17(6), 712–717. https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0483

Lichtenthal, W. G., Corner, G. W., Sweeney, C. R., Wiener, L., Roberts, K. E., Baser, R. E., Li, Y., Breitbart, W., Kissane, D. W., & Prigerson, H. G. (2015). Mental Health Services for Parents Who Lost a Child to Cancer: If We Build Them, Will They Come? Journal of Clinical Oncology, 33(20), 2246–2253. https://doi.org/10.1200/JCO.2014.59.0406

Lichtenthal, W. G., Sweeney, C. R., Roberts, K. E., Corner, G. W., Donovan, L. A., Prigerson, H. G., & Wiener, L. (2015). Bereavement Follow Up After the Death of a Child as a Standard of Care in Pediatric Oncology. Pediatric Blood & Cancer, 62(S5). https://doi.org/10.1002/pbc.25700

Longbottom, S., & Slaughter, V. (2018). Sources of children's knowledge about death and dying. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1754), 20170267. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0267

Lövgren, M., Jalmsell, L., Eilegård Wallin, A., Steineck, G., & Kreicbergs, U. (2016). Siblings' experiences of their brother's or sister's cancer death: A nationwide follow up 2–9 years later. Psycho-Oncology, 25(4), 435–440. https://doi.org/10.1002/pon.3941

Meij, L. W., Stroebe, M., Stroebe, W., Schut, H., Bout, J. V. D., Van Der Heijden, P. G. M., & Dijkstra, I. (2008). The Impact

of Circumstances Surrounding the Death of a Child on Parents' Grief. Death Studies, 32(3), 237–252. https://doi.org/10.1080/07481180701881263

Middleton, W., Raphael, B., Martinek, N., & Burnett, P. (1998). A Longitudinal Study Comparing Bereavement Phenomena in Recently Bereaved Spouses, Adult Children and Parents. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 32(2), 235–241. https://doi.org/10.3109/00048679809062734

O'Brien, M. E. (1996). Relief of suffering: Where the art and science of medicine meet. Postgraduate Medicine, 99(6), 189–208. https://doi.org/10.1080/00325481.1996.11946144

Pfaff, K., & Markaki, A. (2017). Compassionate collaborative care: An integrative review of quality indicators in end-of-life care. BMC Palliative Care, 16(1), 65. https://doi.org/10.1186/s12904-017-0246-4

Pike, A. (2015). Care at the Time of Death. Nursing Care at the End of Life, 93.

Pratt, M., & Wood, M. (2015). Art therapy in palliative care: The creative response. Routledge. https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9 781315788012&type=googlepdf

Raitio, K., Kaunonen, M., & Aho, A. L. (2015). Evaluating a bereavement follow up intervention for grieving mothers after the death of a child. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 510–520. https://doi.org/10.1111/scs.12183

Rosenberg, A. R., Baker, K. S., Syrjala, K., & Wolfe, J. (2012). Systematic review of psychosocial morbidities among bereaved parents of children with cancer. Pediatric Blood & Cancer, 58(4), 503–512. https://doi.org/10.1002/pbc.23386

Rosenberg, A. R., Postier, A., Osenga, K., Kreicbergs, U., Neville, B., Dussel, V., & Wolfe, J. (2015). Long-term psychosocial outcomes among bereaved siblings of children with cancer. Journal of Pain and Symptom Management, 49(1), 55–65.

Rye, N. (2008). Play therapy as a mental health intervention for children and adolescents: Play therapy has much to offer children who have had traumatic experiences or suffer from mental health and other problems. Play therapist Nina Rye explains. Journal of Family Health Care, 18(1), 17–20.

Sadak, B. B., & Weiser, L. (2017). Acknowledging the Archetypal Elements of Grief. Psychological Perspectives, 60(4), 434–444. https://doi.org/10.1080/00332925.2017.1386987

Schuelke, T., Crawford, C., Kentor, R., Eppelheimer, H., Chipriano, C., Springmeyer, K., Shukraft, A., & Hill, M. (2021). Current grief support in pediatric palliative care. Children, 8(4), 278.

Shafır, T., Orkibi, H., Baker, F. A., Gussak, D., & Kaimal, G. (2020). The state of the art in creative arts therapies. Frontiers in Psychology, 11, 68.

Sisk, B. A., Bluebond-Langner, M., Wiener, L., Mack, J., & Wolfe, J. (2016). Prognostic disclosures to children: A historical perspective. Pediatrics, 138(3). https://publications.aap.org/pediatrics/article- abstract/138/3/e20161278/52781

Sisk, B. A., Feudtner, C., Bluebond-Langner, M., Sourkes, B., Hinds, P. S., & Wolfe, J. (2020). Response to suffering of the seriously ill child: A history of palliative care for children. Pediatrics, 145(1). https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/145/1/e20191741/37009

Staudt, C. (2013). Whole-person, whole-community care at the end of life. AMA Journal of Ethics, 13(12), 1069–1080.

Stevenson, M., Achille, M., Liben, S., Proulx, M.-C., Humbert, N., Petti, A., Macdonald, M. E., & Cohen, S. R. (2017). Understanding How Bereaved Parents Cope With Their Grief to Inform the Services Provided to Them. Qualitative Health Research, 27(5), 649–664. https://doi.org/10.1177/1049732315622189

Stroebe, M., Schut, H., & Boerner, K. (2017). Cautioning Health-Care Professionals: Bereaved Persons Are Misguided Through the Stages of Grief. OMEGA - Journal of Death and Dying, 74(4), 455–473. https://doi.org/10.1177/0030222817691870

Stuber, M. L., & Hovsepian, V. (2001). What do we tell the children? The Western Journal of Medicine, 174(3), 187.

Tervalon, M., & Murray-Garcia, J. (1998). Cultural humility versus cultural competence: A critical distinction in defining physician training outcomes in multicultural education. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 9(2), 117–125.

Thompson, A. L., & Young Saleme, T. K. (2015). Anticipatory Guidance and Psychoeducation as a Standard of Care in Pediatric Oncology. Pediatric Blood & Cancer, 62(S5). https://doi.org/10.1002/pbc.25721

Turner, R. (2020). Playing through the unimaginable: Play therapy for traumatic loss. International Journal of Play Therapy, 29(2), 96.

Wiener, L., Tager, J., Mack, J., Battles, H., Bedoya, S. Z., & Gerhardt, C. A. (2020). Helping parents prepare for their child's end of life: A retrospective survey of cancer bereaved parents. Pediatric Blood & Cancer, 67(2), e27993. https://doi.org/10.1002/pbc.27993

Worden, W. (2018). Grief counseling and grief theory: A handbook for mental health practitioners. Springer Publishing Company.

Zetumer, S., Young, I., Shear, M. K., Skritskaya, N., Lebowitz, B., Simon, N., Reynolds, C., Mauro, C., & Zisook, S. (2015). The impact of losing a child on the clinical presentation of complicated grief. Journal of Affective Disorders, 170, 15–21.

Zwerdling, T., Hamann, K. C., & Kon, A. A. (2006). Home Pediatric Compassionate Extubation: Bridging Intensive and Palliative Care. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 23(3), 224–228. https://doi.org/10.1177/1049909106289085